

“森田疗法在中国”系列丛书

社交恐怖症 的森田疗法

主 编 施旺红

编 者 施旺红 倪文娟

杨兴洁 宋丽娜

李 米 杨业兵

许 涛 林冠群

第四军医大学出版社·西安

图书在版编目(CIP)数据

社交恐怖症的森田疗法/施旺红主编. —西安:第四军医大学出版社,2008.7

“森田疗法在中国”系列丛书

ISBN 978-7-81086-460-2

I. 社… II. ①施… III. 人间交往-恐怖症-治疗
IV. R749.990.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 098456 号

社交恐怖症的森田疗法

主 编	施旺红
责任编辑	徐文丽 王 娥
出版发行	第四军医大学出版社
地 址	西安市长乐西路 17 号(邮编:710032)
电 话	029-84776765
传 真	029-84776764
网 址	http://press.fmmu.sn.cn
印 刷	西安交通大学印刷厂
版 次	2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷
开 本	889×1194 1/32
印 张	9.5
字 数	200 千字
书 号	ISBN 978-7-81086-460-2/R·394
定 价	25.00 元

(版权所有 盗版必究)

良

好的人际关系是社会繁荣、稳定与发展的前提，人际关系的和谐也是构建和谐社会的重要内容。随着改革开放的深入发展，我们的生活节奏越来越快，竞争愈演愈烈，人际交往方面出现了许多新的问题。例如，我国已经进入独生子女成人化时代，许多父母对子女期望过高，对孩子的教育过分投资，而忽视了对孩子社交技巧、耐受挫折力等心理素质的培养。在巨大的社会压力面前，部分青少年不堪重负，导致厌学、闭门不出、离家出走、上网成瘾等，并患上各种心理疾病。社交恐怖症（social phobia）就是一种常见的心理疾病，它已经严重危害了人们的身心健康。

社交恐怖症，又称社交焦虑、对人恐怖症，是一种常见的心理障碍。社交恐怖症患者精神极度痛苦，严重影响社会功能。严重者往往闭门不出，有更高的患抑郁症及自杀的危险性。美国等调查发现其患病率为 10% ~ 13%。日本社交恐怖症的发病率占神经症的 30%，青少年发病率尤其高。在中国还没有确切的数据报告。

在我国，社交恐怖症尚未引起足够重视。对中国科技期刊数据库 1979 ~ 2007 年论文检索发现，有关社交恐怖症的论文仅为 200 余篇，而抑郁症的论文为 12500 余篇，前者仅是后者的 1.6%。

2001 年我去日本九州大学从事社交恐怖症及森田疗法的学

Foreword

习研究。回国后发现，中国有很多的社交恐怖症患者，由于其症状的多变性及复杂性，医生往往无法进行恰当诊断，常常被误诊为精神分裂或其他精神障碍，许多患者求医无门，饱受社交恐怖症的折磨。我为国人对社交恐怖症的知识了解得少之又少的现状而深感忧虑，从日本归国后就暗下决心，一定要写一本有关社交恐怖症的书。经过七年多的临床探索，在总结国内外专家及患者的临床经验的基础上，终于完成了本书的初稿。

本书分为上、下两篇，先是对社交恐怖症进行概述，然后重点探讨社交恐怖症的森田疗法。全书写作中，我有意列举了大量病例、患者自述及康复者的体会，旨在使读者获得“共感”，从而使读者更好地体会森田疗法的妙处。在此，也深深感谢实践集团森田疗法的朋友们，是他们给我的写作提供了大量的素材和支持。

希望本书对中国的同行，尤其是社交恐怖症患者及家属提供一些帮助。这是我撰写本书的初衷，也是我的愿望以及对社交恐怖症患者的祝福。

感谢在本书撰写过程中全力支持和协助我的同仁！

感谢日本冈本财团的大力支持！

施旺红

2008年6月于西安

上篇 社交恐怖症概述

第 1 章 社交恐怖症概念的由来 3

欧洲最早报道了社交恐怖症的病例，但真正对其深入研究的是日本的森田教授，他提出了“对人恐怖症”的概念。ICD-10 将社交恐怖症归类于恐怖性焦虑障碍，DSM-IV 也归类于焦虑障碍，我国 CCMD-3 则将其归类于神经症下的恐惧症，又叫社会焦虑恐惧症。

第 2 章 社交恐怖症的分类 10

社交恐怖症根据对象可分为一般社交恐怖症和特殊社交恐怖症；根据症状分为视线恐怖、赤面恐怖、表情恐怖、异性恐怖、口吃恐怖、厕所恐怖、写字恐怖、放屁恐怖、教室恐怖、聚会恐怖、会餐恐怖、出汗恐怖、体臭恐怖等，其中视线恐怖还有很多亚型。

第 3 章 社交恐怖症的流行病学数据 37

从国内外调查情况来看，社交恐怖症有相当高的患病率，而且常常共患其他精神障碍，但社交恐怖症在医疗机构的识别率与治疗率都很低，是一种被严重忽视的焦虑障碍。

第 4 章 社交恐怖症的发病因素及机制 44

社交恐怖症的发病因素包括生物学因素、心理因素、社会环境因素，同时还受传统文化的深刻影响。其中，自卑情绪、

家庭环境及父母教养方式、童年期的生活事件都会增加患病的几率，我国传统文化观念及最近几十年来我国传统文化与外来文化的碰撞则是社交恐怖症的深层原因。

各种心理学学派，包括行为主义学派、精神分析学派、认知学派对社交恐怖症的发病机制都有所探讨，为其治疗提供了理论依据。

第5章 社交恐怖症的诊断 80

社交恐怖症的诊断比较简单，一般当患者在社交场合下出现明显的紧张、焦虑或回避行为时便可诊断。现有的诊断标准有DSM-IV和ICD-10诊断标准，以及我国的CCMD-3诊断标准。

第6章 社交恐怖症的治疗 89

社交恐怖症的治疗包括药物治疗和社会—心理治疗。目前常用的药物有4类：单胺氧化酶抑制剂、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂、苯二氮䓬类及 β 受体阻滞剂。而社会—心理治疗则包括暴露疗法、认知疗法及森田疗法等。森田疗法是日本治疗对人恐怖症最有效的心理疗法。

第7章 社交恐怖的预防——论自卑与超越 96

社交恐怖症的发病有许多影响因素，超越自卑是最有效的预防。自卑有其形成的条件，而超越自卑则要从改变认知、用补偿心理超越自卑、用乐观态度面对失败、用实际行动建立自信等方面去努力。

Contents

下篇 社交恐怖症的森田疗法

第8章 森田疗法 113

森田疗法的基本理论有疑病素质论、精神交互作用 and 思想矛盾、生的欲望和死的恐怖、精神拮抗作用等，其治疗原理可概括为：顺其自然，为所当为。实施森田疗法要养成森田式的生活态度并注重实践，通过行动可以改变人的情感，陶冶性格。

森田疗法的治疗用语中有许多格言，非常富于哲理，其如醇酒，慢慢品之，可以渗透到心灵深处……

第9章 日本对人恐怖症的研究概况 142

日本是对社交恐怖症研究最为深入的，但在日本常用“对人恐怖症”这一概念。日本学者认为对人恐怖症与文化有密切的关系，日本特有的文化现象如集团主义、娇宠与间人、新人类现象对社交恐怖症的高发有深切的影响。东亚地区文化也与对人恐怖症有密切关系。

第10章 森田理论关于对人恐怖症发病机制的论述 162

神经症的症状之多比其他任何一种疾病所无法相比的。其症状大多是由某种契机为诱因而突然出现。内向型性格的人容易出现神经症的症状，但并不等于神经症皆出于内向型性格。神经症患者的性格是复杂的，有疑病素质，又有劣等感，他们

经常处于一种精神内部冲突的状态，有极强的自我发展愿望，而用主观愿望控制客观现实而引起的精神拮抗作用的加强正是对人恐怖症等神经症形成的根本原因。

第11章 森田教授与患者谈如何治疗对人恐怖症 176

森田教授认为养成“顺应自然”的态度是对人恐怖症的治疗秘诀。“顺其自然”绝不是“放任自流”，而是不用意志的力量去控制情绪，任其自然地出现，接受它，以减轻内心冲突，带着症状继续做日常该做的事，即“为所当为”。森田教授分析了许多对人恐怖症治愈的病例，从中可以体会其理论精髓。

第12章 一位日本社交恐怖症患者的心路历程 204

一个渴望去无人的地方的日本女性，深受社交恐怖症的折磨。从她的心路历程中，我们也许可以悟出更多——也许每个人的人生之路都会遇到坎坷，有些是外在的原因，有些是我们自己的心结，都不必怕，接受自己，面对现实，会找到一个新的自我，生活依然会阳光灿烂。

第13章 施旺红教授的集团森田疗法 213

社交恐怖症的集团心理疗法是施旺红教授潜心研究森田疗法，并且在国内从事了大量临床心理治疗的基础上逐步总结出来的，是森田疗法在中国的成功运用与发展。众多患者的学习体会从更感性的角度阐释了森田疗法，同时又是此集团疗法成功的体现。

Contents

第14章 施教授论森田疗法的运用技巧 233

施教授通过自己的感悟，与日本学者的共同探讨，进一步总结了森田疗法的精髓，并提出自己的见解，如“像健康人一样去行动，你就会变成健康人”“重在实践”“森田疗法是一种人生哲学”“行动是解决问题的唯一途径”“前途是光明的，道路是曲折的”“关于性格的修养”“别希望消除自己的症状了”“关于治愈”。细细品味吧，答案就在其中，命运掌握在我们自己手中。

附：人际关系中的心理效应 266

人际交往是个体社会化的必由之路。了解人际交往的技巧，了解其中有关心理效应的知识，会为我们打开一扇门，走出自己的内心，走向社会。

上

篇

社交恐怖症概述



- 第1章 社交恐怖症概念的由来
- 第2章 社交恐怖症的分类
- 第3章 社交恐怖症的流行病学数据
- 第4章 社交恐怖症的发病因素及机制
- 第5章 社交恐怖症的诊断
- 第6章 社交恐怖症的治疗
- 第7章 社交恐怖症的预防

第 1 章

社交恐怖症概念的由来

对于绝大多数人来说，在社交活动中感到不好意思和没有自信，在公众面前演讲，甚至和别人约会时会紧张，出现心跳手抖或是感觉神经性的发抖，这些焦虑反应是暂时的，很快会消失，并不会影响你的正常生活和学习。但是如果这些焦虑反应影响你的正常生活和学习，成为一种严重的问题——社交恐怖症，这就必须引起人们的重视。

最早报道脸红恐怖的是德国学者 Casper（1846 年）。接着 Westphal（1877 年）报道了同样的病例。Janet（1903 年）将其命名为交际恐怖或社会恐怖症；Stoekert（1929 年）以接触神经症命名此类疾病。Schilder 又称之为社会神经症。虽然西欧专家最先报道，但他们没有对此类疾病给予足够的重视。

1966 年，英国的 Marks 提出社交焦虑（social anxieties）的概念；1970 年，Marks 又提出了社交恐怖症（social phobia）的概念。1980 年，美国《精神疾病诊断和统计手册》第 3 版（DSM-III）中，将社交恐怖症作为焦虑性障碍的一种类型沿用至今。

DSM-IV关于社交恐怖症的分类定位

焦虑障碍

惊恐障碍不伴广场恐怖

惊恐障碍伴广场恐怖

广场恐怖，无惊恐障碍病史

特殊恐怖症

社交恐怖症

强迫性障碍

创伤后应激障碍

急性应激障碍

广泛性焦虑障碍

躯体疾病所致焦虑障碍

物质所致焦虑障碍

焦虑障碍，未特定

社交恐怖症这一名称被采用之后，受到很多学者的关注。1985年，Liebowitz发表了名为《A Neglected Anxiety Disorder》的论文，之后对于社交恐怖症的研究迅速展开。根据北美数据调查发现，社交恐怖症的发病人数比预想的要多很多，是一种常见的焦虑障碍，终生患病率为3%~13%。紧接着欧洲、中东、澳大利亚关于社交恐怖症报道接踵而至。他们对社交恐怖和空间恐怖的异同进行了讨论，以Sheehan为代表提出了内因性焦虑发展学说，即惊恐发作——社交恐怖——空间恐怖。多数学者认为，社交恐怖症是一种独立的疾病，只是偶尔与惊恐发作有关联。1987年，DSM-III-R认为社交恐怖症是对几乎所有的社交情况产生恐惧的广泛焦虑类型，DSM-IV更加明确了

社交恐怖症的诊断。1994 年，DSM-IV 对其诊断标准做了一些修改，提出了基准 B（根据情况有时候会诱发惊恐发作），这种修改意味着在社交场合紧张是导致惊恐发作的一种类型，但是有没有惊恐发作，不作为诊断社交恐怖症的关键指标。1992 年，国际疾病分类 ICD-10 也采用了社交恐怖症的诊断，这个诊断标准被全世界所认可。

ICD-10 关于社交恐怖症的分类定位

F40	恐怖性焦虑障碍
F40.0	广场恐怖
F40.00	不伴惊恐发作
F40.01	伴惊恐发作
F40.1	社交恐怖
F40.2	特定的（孤立的）恐怖
F40.8	其他恐怖性焦虑障碍
F40.9	恐怖性焦虑障碍，未特定

实际上，日本是世界上社交恐怖症发病率最高的国家，社交恐怖症占神经症的30%，远远高于欧美。日本对社交恐怖症的认识以及有关社交恐怖症的研究治疗也更深入。在日本，森田正马最早报道赤面恐怖。1909年，森田在《神经衰弱性精神病性体质》一文中将赤面恐怖命名为在多人场合的场所恐怖。1932年，森田教授认为这些恐怖都是在社交场合发生的恐怖，因而提出了对人恐怖症的概念，并列举了赤面恐怖、视线恐怖、口吃恐怖、表情恐怖、自己臭恐怖等许多常见的症状。

森田教授认为，赤面恐怖、对人恐怖实质上就是强迫症的

一种亚型，其病理与强迫观念是一致的。对人恐怖症的共同的特征是羞耻。不好意思或者羞耻是日本人际交往中经常出现的一种文化特征。

韩国是 1970 年开始报道对人恐怖症的。1982 年，韩国的李时炯首先开展了对人恐怖症的研究，并出版了《To Live With Guts》，这本书在韩国引起了很大的反响。随后大量的对人恐怖症患者接踵而至来接受治疗。1982~1985 年，到韩国总医院接受治疗的对人恐怖症患者达 315 名，李时炯采用了集团心理疗法。治疗之前先面接，然后进行集团疗法，每周一次，共八次。治疗共分三期：第一期，理解对人恐怖症的症状特征，让其勇敢面对；第二期，通过体验加深理解症状发生的机制；第三期，对症状顺其自然地接受，带着症状去生活。整个治疗的过程中，强调体验的重要性。集团疗法对对人恐怖症起到了良好的效果。

中国在 1950 年时，在精神医学的用语中就有过社交恐怖的概念（指不能与人交往），被分类为神经衰弱的一种。1980 年北京首次报道此症。1986 年《中国精神病分类标准》第 2 版（CCMD-2）取用了社交恐怖（社交场面中对人紧张焦虑）的概念，把它归类为恐怖症的一种。

比较研究发现，日本、韩国、中国对人恐怖症的症状特点为：都与身体症状相关联，强迫性的观点明确。有趣的是，日本、韩国对人恐怖症在同性别、同年龄的人群中明显，而中国是在异性的社交场合明显。根据王哲的调查发现，在中国，色目恐怖的出现频率最高，这体现了与性相关的羞耻意识，因为，眼神是传递爱的表现形式，所以担心自己的眼神给异性造成了

恐怖。因此对人恐怖与文化明显相关。

日本对对人恐怖症的心理机制和症状学特征研究比较深入，研究范围从轻度的社交焦虑到严重的闭门不出。许多学者如土居、西田、近藤、山下、笠原等都发现一些重症患者带有妄想倾向。1980 年，美国精神病诊断分类标准 DSM-III 中提出社交恐怖概念后，许多其他国家的同行认为对人恐怖症不同于社交恐怖症。为此，1990 年日本专门成立对人恐怖症研究会，组织专家制定对人恐怖症的诊断标准。其对人恐怖症的诊断标准须满足以下条件：

(1) 在与人打交道时对自己的态度、行为或者身体的特征感到不协调。

(2) 在与人交往的情况下表现出羞耻、困惑、不安、恐怖、发抖、紧张等持续性的情感反应，感到极度痛苦。

因为 (1)、(2) 的原因，不能和他人维持良好的关系（感到不能被别人接受，被人瞧不起，被人疏远，从而产生烦恼）。

(3) 回避感觉痛苦的社交场合，同时又对自己的行为产生抵抗情绪。

满足以上诊断标准，再满足以下 3 项，就可诊断为妄想型对人恐怖症。

(1) 与自己身体特定的部位或者身体感觉相关，确信自己的身体有缺陷（如自己的视线、气味、丑貌）。

(2) 因为 (1) 的原因产生给别人造成了伤害或不愉快的妄想而且确信无疑。

(3) 因为以上的症状而确信别人逃避自己。

值得一提的是，日本并没有自己的精神病学诊断标准，他

们直接应用美国和国际的诊断标准即 DSM-IV 及 ICD-10。对人恐怖症研究会是由日本森田疗法学会设立，由现任理事长北西宪二教授牵头的。可以说，对人恐怖症是日本精神病学界唯一一个由本国命名并专门制订诊断标准的精神科疾病。

可以看出，对人恐怖症和社交恐怖症内容基本相同，但对人恐怖症包含了带有妄想倾向的重症。美国、德国、韩国的专家也报道部分患者带有加害妄想。中国医科大学秦晓霞对 1992 年～1998 年六年间住院治疗的 43 例社交恐怖症病例进行回顾性总结时发现，其中 32 例具有敏感性关系妄想。钟友彬也提到大部分社交恐怖症病例存在敏感性关系妄想。而这些重症社交恐怖症患者，容易被错误诊断为精神分裂、强迫症等其他疾病而得不到有效的治疗。因此，日本对人恐怖症的诊断标准对此类疾病的认识更深入，值得中国同行借鉴。本作者撰写社交恐怖症的专著，就是希望通过本书系统介绍国内外尤其是日本同行的研究，提高我国社交恐怖症的诊治水平。

我国精神病学诊断标准 CCMD-3 是主要参考 DSM-IV 和 ICD-10，结合中国实际而制订的。

CCMD-3 将社交恐怖症归类为神经症中的恐惧症（恐怖症）之下，称之为社交恐惧症（社会焦虑恐惧症）。

CCMD-3 关于神经症的分类

- 43 神经症
- 43.1 恐惧症（恐怖症）
- 43.11 场所恐惧症
- 43.12 社交恐惧症（社会焦虑恐惧症）

- 43.13 特定的恐惧症
- 43.2 焦虑症
- 43.21 惊恐障碍
- 43.22 广泛性焦虑
- 43.3 强迫症
- 43.4 躯体形式障碍
- 43.41 躯体化障碍
- 43.42 未分化躯体形式障碍
- 43.43 疑病症
- 43.44 躯体形式自主神经紊乱
- 43.45 持续性躯体形式疼痛障碍
- 43.49 其他或待分类躯体形式障碍
- 43.5 神经衰弱
- 43.9 其他或待分类的神经症

在中国的临床上，社交恐怖症、社交焦虑症和对人恐怖症的概念在混用。张明园认为，该病的命名应该用社交恐怖症还是社交焦虑症，是有争议的。DSM-IV 和 ICD-10 不同的表述，反映了精神科对此病认识的不完善，并存在着分歧。在我国，社交恐怖症的识别率低、诊断不准确是导致治疗率低的直接原因。

第 2 章

社交恐怖症的分类

社交恐怖症多起病于青春期，只有少数起病于 20 岁以后。症状表现多种多样。除个别病人外，症状只出现在和别人在一起的时候，独处时则没有恐怖症状。常见的症状之一，是在一对一的社交场合下产生强烈的不安，而与一群陌生人（如在街上或公共场所）混在一起时并无恐惧或只有轻微的紧张。社交恐怖症发作厉害时常伴有头晕、恶心、震颤等。严重者拒绝与任何人（除家属外）发生接触，不能参加任何社交活动，完全把自己跟朋友孤立起来，无法上学和工作。有的人害怕社交时会脸红，而实际上病人并不容易脸红。有人害怕在社交场合下会晕倒、打嗝或放屁等，以致回避社交。社交恐怖症还有其他各种不同的表现形式。如，有一男青年害怕与人交谈时用手挠头皮，他认为这是很不礼貌的行为，其实，他头皮并不痒，也没有挠头皮的习惯，可就是怕交谈时会控制不住地这样做，因而避免社交，可又认为不社交无法立足于社会，十分痛苦。另有一女青年总害怕有人有特异功能，能透过衣服看见她的阴部。尽管她对特异功能持怀疑态度，却仍然害怕与人接近。从童年

能记事时起，她就特别怕别人看见她在大小便，因而出门前必须先上一次厕所，也不敢远离家门，怕忍不住要去厕所——她多年来从不敢上公厕。即使在家，也必须门窗紧闭，挂上厚窗帘后才敢大小便，尽管如此严加防范，大小便时仍极为紧张害怕。虽然社交恐怖症可以有各式各样的变异，无法尽述，但归结到一点，社交恐怖症的核心是怕人，各种变异都可以视为人的象征化。社交恐怖症主要类型如下。

根据对象分类

1. 一般社交恐怖症 一个人如果患了一般社交恐怖症，在任何地方、任何情境中，他都会害怕自己成为别人注意的中心。他会觉得周围每个人都在看着他，观察他的每个小动作；他害怕被介绍给陌生人，甚至害怕在公共场所进餐、喝饮料；他会尽可能回避去商场和进餐馆；他从不敢和老板、同事或任何人进行争论，捍卫自己的权利。

一般社交恐怖症患者总是担心会在别人面前出丑，在参加任何社会聚会之前，他们都会感到极度的焦虑。他们会想象自己如何在别人面前出丑。当他们真的和别人在一起的时候，他们会感到更加不自然，甚至说不出一句话。当聚会结束以后，他们会一遍一遍地在脑子里重温刚才的镜头，回顾自己是如何处理每一个细节的，自己应该怎么做才正确。这类社交恐怖症都有类似的躯体症状：口干、出汗、心跳剧烈、想上厕所。周围的人可能会看到的症状有：脸红、口吃、轻微战抖。有时候患者发现自己呼吸急促、手脚冰凉。最糟糕的结果是，患者会

进入惊恐状态。

2. 特殊社交恐怖症 如果一个人患了特殊社交恐怖症，他会对某些特殊的情境或场合特别恐惧。比如，害怕当众发言与当众表演。尽管如此，他在别的社交场合，却并不感到恐惧。推销员、演员、教师、音乐演奏家等，经常都会有特殊社交恐怖症。他们在与别人的一般交往中，并没有什么异常，可是当他们要上台表演，或者当众演讲时，他们会感到极度的恐惧，常常变得结结巴巴，甚至愣在当场。

根据症状分类

1. 视线恐怖 视线恐怖是社交恐怖症的一种常见形式，患者怕看别人的眼睛，怕跟人家的视线相遇。患者主诉与别人见面时不能正视对方，自己的视线与对方的视线相遇就感到非常难堪，以至于眼睛不知看哪儿才好。患者一味注意视线的事情，并急于强迫自己稳定下来，但往往事与愿违，结果不能集中注意力与对方交谈，谈话前言不搭后语，而且往往失去常态。患者怕别人看出他表情不自然，或者感到别人的目光很凶恶，或者从别人的眼光中能看出别人对他的鄙视、厌恶甚至憎恨。有些病人诉述总控制不住用“余光”看人，病人所谓余光，指注视某物或某人时，觉得自己控制不住地同时也看着另一物或另一人。如果问病人用余光看人有什么不好，是不是意味着斜眼看人，有看不起人的意思，还是意味着暗送秋波，不正派时，病人通常说不清楚，但否认有任何看不起人和不正派的想法。病人的痛苦似乎在于，他必须使自己的眼光像焦点一样集中于

某人或某物，而不允许其他人或物进入他的视野，但是，他做不到。还有极个别病人害怕自己的眼光会伤害别人，至于用眼看人怎么会伤害别人，病人却无法自圆其说。尽管如此，病人还是害怕。

有的视线恐怖患者与许多人同在一个房间时，主诉不能注意自己对面的人，而强迫地注意旁边其他人的视线，或认为自己的视线朝向旁边的人而使其感到不快。结果患者的精力无法集中于对面的人。有的学生患者在上课时，总是不能自己地去注意自己旁边的同学，或总感到旁边的同学在注意自己，结果影响了上课，并给自己带来无比的痛苦。

视线恐怖常见的亚型有：

(1) 对视恐怖 与人对视时感到紧张害怕，看人时总想着对方的眼神，即使勉强对视，也躲躲闪闪，一扫而过，看人时间不足一秒钟。当对视时心情慌乱，脑子一片空白，说不出话，目光不能集中，感觉对方的目光流露出“疑惑、生气、反感或仇视”的意思。有的病人坚信其目光能伤人、太毒、刺人或不柔和，使被视者显得局促不安、表情难堪或手脚难受、不自然。相当一部分病人认为其目光“色迷迷”的，有邪念，或有异样表情，看人时有“非分之想”的意思，只好眯眼看人或干脆闭上眼睛，悲观地认为眼瞎了问题就解决了。

【病例】^①

施教授：你好！能帮帮我吗？救我一命吧，我生不如死啊。

注^①：本书所写病例大部分都是患者自述，其中有些是患者写来的求助信，有些是治疗日记，有些是在网上发表的言论，在此我只对原作言辞进行必要的修改，以保持原作的语言风格。

我痛苦了10年，我找不到工作，受尽了别人的欺辱啊。我想结婚，想有个工作，但因为我怕人看，我什么都失去了。我今年29岁，大概两年前我开始出现一种莫名其妙的症状，就是不敢和别人的眼睛对视，那样会让我感到一种难以言说的恐慌，全身上下都会变得无所适从，严重的时候我甚至不敢看妈妈的眼睛。我不知道到底为什么会这样，我努力想克服这种毛病，但是失败了。听说这是一种社交恐怖症，到底要怎样才能克服呢？我真是痛苦极了。怎么办啊，我是一名社交恐怖症患者，每天都过着似人非人的生活，好像在我的字典里从来找不到“轻松”这个词语。我也不知道到底是什么原因使我得了这种病，书上说我这叫视线恐怖症，主要是不敢和别人面对面地交流，致使整个场面搞得很尴尬，不知所措；还有就是总认为旁边的人在盯着我，只要旁边有人在，不管是家人、同事，还是朋友，我都无法认真工作，静不下心，总是要分心；有时还会选择逃避，自己跑开暗自悲伤，感觉在这个世界上我好像真是多余的。我特别怕别人的眼睛与我对视，每当这时我就羞得要命，不仅面红耳赤，连手心都汗淋淋的，必须马上躲开，否则双腿就抖个不停，连迈步都艰难。开始只是对男性，现在对女的也是如此，为此我常躲开视线，可是又情不自禁地用眼睛的余光扫视对方，给对方以很不体面的感觉，说我这人“很不正经”。我自己也特别恨我这双眼睛，有时甚至都想把它挖掉。

(2) 余光恐怖 患者用眼睛的余光看人，特别是在异性面前感到不安、害怕。病人称余光看人并不等于斜视，而是眼球定视前方注意力却能高度集中于侧面视野的目标，时间一长，

积习成癖难以自控，引起侧面异性的注意和反感，病人抱怨当正视前方时，眼光发散，注意力集中不起来，不由自主地“余光”视野中的动静或人成了注意的目标，这个目标常常是异性或异性的胸乳部、阴部。由于情绪不安，只好偷视一次以求放松，不久后“余光”又使其精力分散，难以控制。有些学生患者因此不能听课，只好在课桌两侧垒上两堆书或用手捧着脸挡住余光，以求视线集中。有的病人先是不敢和人对视，只好用余光看人，余光看人成了主要症状。

【病例】

坐在回家的公交车上，我一直闭着眼睛，长期的余光恐怖让我的眼神变得十分恶心，我不想让任何人看到，同时我也不想再看到别人鄙视的目光。就这样，我能感到车窗外阳光的味道，但是我已经无法再享受了，车子里有说话声，笑声……我不知道是不是他们都在笑我。呵呵，当一个人从可以无视任何人，到现在反而让所有人都看不起，有谁可以想象呢？现在我什么也没有，有的只是痛苦和仇恨，是这个世界亲手毁了我的一切……我想我会很快地死去，每时每刻都活在恐惧和焦虑之中。轻易就这么死去的理由是：凭什么他们可以如此毫无遮拦地嘲笑我，为什么！现在想来，我还要感谢他们，因为没有他们，我也许早就死去，是他们让我看到活下去的可能，因为我要报复，余恐算得了什么，那个曾经的我早已死去。是这种该死的心理疾病和这个世界的冷漠亲手毁了我的一切，但我不会放弃。同时我要对所有社恐的人说，这个世界上人心都是丑陋的，你还为什么要害怕他们呢？你就是要用这种余恐的眼神去看他们，不要感到内疚，不会有一个人来同情你，人活着为了

自己，有机会就把一切都还给他们……我从来都没有想过我会变成今天这个样子，我无法给自己一个答案，我竟会是今天这个样子。六年了，六年的时间让我失去了所有的自尊，所有人都嘲笑我，别人甚至还当面对我哈哈大笑，而我只能默默地忍受，多少次几近疯狂，我真想冲上去杀光他们，我讨厌听到他们的声音，可是我没能那么做，因为我要报复他们，他们越是笑我，我就越是要活得更好。但我还是害怕上课，所有的强迫都向我袭来，我的心一次又一次地被掏空。我更恨坐在我后面的人，我恨他们，因为他们让我的强迫到了近乎疯狂的地步，我有时甚至想他们全都死光了，我就不会余恐了。我的一切难道要全部毁在社恐上吗？为什么……

【病例】

我因为得了余光恐怖，在这几个年头里，我过着浑浑噩噩的生活。像我们这种人所受到的折磨远远比身体残疾的人大。一个断手，瞎子，癌症患者能得到别人的理解、同情与关怀，我们呢？

是的，我控制不住自己的眼神，我的眼光会因小孩、女性、男性或物体而偏，这种眼神甚至让人厌恶。我多想让别人知道我的眼神并不是要有意偏视，我也不是要有意看他们，但有谁理解？村里人在你背后议论纷纷，中年人在大街上朝你哈哈大笑，民众们在车上怀疑你是小偷，他们朝你瞪眼，嘲笑，谩骂，咳嗽，吐痰——我越来越感觉自己不属于这个世界……

【病例】

在上高二时，我一直希望在分文理后到新的班级，我可以给新同学留下好的印象。可是，就在一次课堂上，我注意到我

后面的两个男生在谈论我，说我总是揉眼睛，好像在哭。其实我有沙眼，但是我从小就很习惯和男生说话。之后我就一直很注意那两个男生，那时我开始用眼睛余光看别人。后来我的眼睛余光被他们发现了，之后他们就跟班里的人说我的眼睛很不正常，渐渐地我对知道我眼睛余光的人很在意，我发现我的眼睛余光已经严重到不管我看什么东西我都会不自觉地看到其他的东西。慢慢地，我的同桌，我的好朋友，乃至我的家人，都开始讨厌我，班里的男生也认为我是一个不规矩的女生，每天去上课他们都会用很脏的话骂我。我以前是一个学习好的学生，也是所有人眼中的守规矩的女生，当然我从来没有被别人那样骂过，我真的好痛苦。后来我开始逃避学校，我经常旷课，每天呆在自己的卧室，自己一个人在哭泣，我骂自己为什么自己会是这样。一直到现在我还是那样，甚至我在考试的时候、写字的时候都会不自觉地看其他地方。我真的不想那样，更不想别人认为我是一个不正常的人，我不想给别人带去困扰，我现在真的很担心自己上不了大学，有人可以帮助我吗？

(3) 目光失控恐怖 患者眼睛总是不能控制地四处乱看，看人时觉得别人不愿被看，像是在生气；看别人的手脚，手脚像是“难受、躲避”。病人称不愿干扰别人，只好把目光转移到别的目标上，但又马上觉得这一目标太牵扯精力，只能再转移到别处，这样摇头晃脑不停，做任何事情都不能专注。有的病人总感到眼球像被人牵着，不由自主地随周围人转动，无法集中注意力，深感苦恼。还有的病人感到眼球不能灵活自如地转动，目光僵直呆板，看人不礼貌，怀疑眼神经有毛病，反

复到医院检查，也查不出器质性病因。

(4) 被视恐怖 很多患者是在受到别人关注、注视的时候感到浑身不自在，感到莫名的紧张、恐怖，会出现脸红、手心出汗等自主神经症状。

【病例】

我实在是无法与人交往，痛不欲生。我的症状是不敢看人，怕被人注视，尤其害怕暴露在众目睽睽之下。一旦有人在我旁边或者从我旁边经过，我的眼珠总是会控制不住地斜向他。我的眼珠斜向别人的时候，我觉得不知为什么别人就会很难堪、尴尬甚至是愤怒，所以我很怕别人生气，就害怕眼珠斜向别人，可越担心偏偏眼珠就越斜向别人，别人就越难堪，形成了恶性循环。而且我觉得眼珠斜向别人也是非常可耻的事，可总是不由自主。所以我很怕也从来不敢和别人围成一桌吃饭或开会，最怕众人面对面的情形，包括自己的家人，一旦在这样的场合，我就会惊恐万状。其实我本来也是正常人，过着正常的生活。问题起源于1994年上初二时，来了一位新同学与我同桌，因为我是尖子，他也是尖子，而我又很积极举手发言，所以我每次举手发言时，他都露出不悦的神情。开始我觉得他怎么这么奇怪，可后来我不知不觉地竟然也被他传染了，他举手发言时，我也会露出不悦的表情。由于害怕老师发现我的丑恶心态，我每天忐忑不安，我太在乎老师对我的美好看法了，在他们眼里我一直是个好学生，所以我总想保留自己的完美形象，不想让老师发现自己的缺点。可后来传染得越来越厉害，开始只是老师眼光注视我的同桌时我会脸露不悦，后来发展到老师不论眼光落到哪位同学身上，我都会脸露不悦；慢慢地又从教室里传

到家里，当我的父母眼光注视到我的其他兄弟身上时，我也会脸露不悦；后来发展到旁边的人不论是谁，只要他眼光一看别人或别的东西，我都会脸露不悦。我的这种丑态让我在别人面前感到非常可耻，所以我总怕别人发现我的这个缺点，整天惶惶不可终日。后来为了不让别人发现我的丑态，我一与别人的目光接触就迅速躲开，老是侧身不看别人，躲着人家的目光，这样躲了一段时间后，我发现我再也无法与别人交往了，一与人在一起就紧张，一与人的目光接触就心惊肉跳。从此，旁边一有人我就紧张，眼光就会斜向他，好像警惕着他，防着他，如果四周都有人的话，我的眼珠更是各个方向都会斜去，曾有好多人在我面前做出翻白眼的怪样，我知道他们是在学我。我总怕别人发现我心理不正常，总怕人家说我心理变态，我常常因此深以为耻，我的耻辱感太强了，所以我一与人相处就非常紧张。由于在人前总是慌慌张张，我总怕人家会认为我傻，看不起我。我该怎样才能恢复正常人的生活，与人正常地相处呢？

(5) 色目恐怖 色，是指色情，目，是指视线，色目就是含有色情意味的眼光和视线。这种病的症状表现为对自己的视线和他人视线的恐怖，担心在对视中因自己的眼神给对方留下轻浮、多情甚至下流的印象，而产生紧张、不安、窘迫的情绪，甚至感到痛苦和羞耻，在行为上表现为千方百计回避对方甚至不与之交往。此症的患者多为进入青春期以后的青年男女。这时的男女随着生理上的成熟，第二性征的出现，性意识开始萌动，对性别角色的差异敏感起来。十五六岁以后，他们的异性

疏远心理逐渐为异性接近心理所替代，产生了一种对异性的好奇心和吸引力。男女之间的爱意表达形式多样，但眉目传情是一个很重要的方式。人们常形容花季少女的眼中“脉脉含情”，说男女相爱时用眼光“暗送秋波”，使青年男女的爱情表达更含蓄和优美。这也是青年男女心理刚开始成熟的一种表现。他们的行为拘谨，尚能克制自己以遵守一定的界限，这是正常的现象。

有一些青年男女在幼年时期受到封闭式的教育，传统道德观念极强，自尊心也很强，性格又比较内向，对自己的心理发育变化还不能正确认识，认为自己的性萌动是不正派的表现，对于性萌动在思想上和行动上的表现有强烈的羞耻感和自责感，如果偶然同异性的眼光相遇，便可能激发出色目恐怖症。

【病例】

十年前，我在读中学的时候，看了不少黄色书刊。由于那时的无知，无端地为书中人物所迷惑，把自己想象成为书中的美女，希望成为书中描写的那样：走在路上要有百分之百的回头率，要有女人的嫉妒。为了达到这个目标，我开始把眼睛睁大，把嘴抿小，心想这就会达到美女的要求。走在路上时，我故意不看别人，眼睛直视着前方，每个陌生人从我身边走过，我就想他一定在想我长得漂亮，她一定嫉妒我长得比她好看。后来参加工作，这种心态仍然未改，且不断往下陷。忽然有一天，我发觉自己的目光变得色迷迷的，是一种勾引人的眼神。我好害怕，于是想回到健康时的样子，可是我已无法调节自己的心态了。不仅如此，假如我发现哪个女的漂亮，我就嫉妒，从六七十岁的老太太到未满周岁的婴儿，更不用说与我年龄相

当的人。每当此时，我就觉得自己非常丑，丑极了，谁都不如。我知道我这样想是不对的，可当我想回到正常的心态，进行自我调整，已做不到了。现在我犹如行尸走肉，脑子里没有亲情、友情和爱情，只有漂亮和嫉妒，我已失去自尊心，假如现在谁骂我几句，我都不会生气。我连起码的同情心都没有了，比如我奶奶前不久去世，我居然不感到难过，并不是我奶奶待我不好，而是我想难过也难过不起来。我再也不想这样活下去了，活着不能和正常人交往，得不到人们的尊重，多痛苦啊！

【病例】

白妮是化学系一年级学生，她是以全县第一名的成绩考进这所闻名中外的学府的。由于个子不太高，加上太多的青春痘，她总是习惯地坐在教室的最前排靠墙的座位上，因为上课时怕老师有意无意地盯着她，故而总是低着头听课。

同宿舍的几位女同学，入学不到三个月就已经熟悉了整个校园环境，课外活动总是积极参加。也许是出于形象上的自卑感，每当周末活动时，白妮总是一个人守在宿舍里，用琼瑶小说来慰藉少女的寂寞。

随着女伴们的活跃，她越来越感到压抑和孤独。渐渐地，她失去了笑声，唯一的寄托就是一天不忘地写日记，自己对自己说心里话。记得在高中时，也曾有男生对她射来倾慕的目光，她心里明白这是由于她优秀的成绩，但毕竟也是一种安慰，她心中萌生了一种爱的憧憬，这憧憬随即化成了奋斗的动力。可如今不然了，成绩已经不是至上的目标，人们也不再仰视她，而是更为喜欢全面的女孩形象。对比班上任何一个女同学，她都自愧不如，相形见绌。尤其当她见到校园中那一对对靓丽的

佳偶和听到同学入睡前的一番“爱情沙龙”，她更加感到性的压抑。她需要爱，但她得不到爱，哪怕是某个男生投来的一笑一瞥……

这天，一位年轻的化学老师，首次出现在讲台上，看样子他不过二十七八，矮矮的个子，却有着洪亮的声音，双目炯炯有神，不住地四处盯着，连白妮这样的姑娘也要扫上几眼。每当此时，白妮都情不自禁地脸红，心跳加速，视线不知往何处落，似乎要找一块地躲进去。越是有这种感觉，就越是想和那老师对视，而每当她鼓起很大的勇气去看时，都恰好遇到老师直视她的目光。刹那间不知怎的，她竟把视线的焦点突然凝集到老师的下身处。她羞死了，但她的目光回收不了，头脑里迅速涌现出老师走下讲台，径直向她扑来的情景，她闭紧双眼，等待那一幕的到来……直到憋出一身冷汗才从一阵快感中惊醒。不知为什么她无法遏制这奇异的性幻想。只要那老师一上课，她就必然会产生这种反射性的白日梦。最后，即使眼中没有老师的形象，她也会在脑海中勾画出来，并发展成被他强奸的场面……

她变得消瘦多了，寝食不思，动辄旷课，躺在宿舍里做她的白日性梦，终于经大学医院诊断为神经衰弱而被迫休学。从此她得了专视男人下身的“色目恐怖症”（怕见任何男人，只要见到男人就要凝视其下身）。

还有些病例是将这几种亚型或其中一两种亚型掺杂在一起的，就像如下病例所述。

【病例】

我现在一直在家，不敢出去，与别人交流都是在网上。一

出去身体就会紧张，总在想看到人后会如何如何。怕看见人，走路很不自在，注意力总会集中在我身边的人身上，拼命不想看人，把注意力放在走路上面，结果自己的瞳孔会放大，眼睛总充满泪水。与别人对视时可以看出别人的不自在，我也会很不舒服。所以我上学的时候没法在教室里面听老师讲课，没法把注意力集中在黑板上，自己好像没法控制自己一样地会把注意力集中到别人身上，以致使别人产生不快。我那时候是很痛苦的。我和别人坐一起的时候没法看书，身体因为害怕而紧张，视线和注意力没法集中在书本上，会在余光中看别人。我想问我该怎么办啊？我能从别人的眼睛中看出异样的眼光，我觉得这是我瞳孔放大，眼睛好像总是发亮的原因，由此我非常内疚，我总想让自己眼睛不要那么多泪水，不让自己的瞳孔放大，可是总做不到，这样我都会害怕看别人的眼睛。总之，一看到别人的眼睛我就会讨厌自己为什么不能正常些，我会特别害怕而讲不清楚话，很多人由此而讨厌我，在上学的时候别人都暗地叫我“神经”。这种情况已经持续六年了。我现在一直待在家里，有一年多没有出去过了，我不知道出去会怎样。

2. 赤面恐怖 一般人在众人面前时，经常会由于害羞或不好意思而脸红，但赤面恐怖患者却对此过度焦虑，感到在人前脸红是十分羞耻的事，最后由于症状固着下来，则非常畏惧到众人面前。患者一直努力掩饰自己的赤面，尽量不使人觉察，并十分苦恼。患者惧怕到众人面前，在乘公共汽车时，总感到自己处在众人注视之下，终于连公共汽车也不敢乘。如有位赤面恐怖的学生患者，对上学乘公共汽车感到痛苦，便总是在别

人上车完毕，公共汽车快开时才匆匆上车，以此方法避开人们的注目，因为坐下会与别人正面相对，便干脆站在车门口来隐藏自己的赤面。又如一位学生患者，因赤面恐怖不能乘公共汽车，只好坐出租车或干脆步行。在必须乘公共汽车时，就事先喝上一杯酒，使别人认为他脸红是喝酒所致，以此自我安慰，或拼命奔跑急匆匆上车，解开衣服的纽扣，用什么东西扇着风，让别人相信他脸红是由于奔跑所致，以掩饰赤面。另一患赤面恐怖的医生，为了掩饰赤面，便佩戴红色领带。还有人为了缩小赤面的面积，而留起了胡须。有一位著名的雕刻家，在与人谈话时感到赤面，便借故小便暂时离开座位。这一类患者甚至连向别人问路也感到不便，宁肯自己一个人躲在无人处拼命查看地图，就是多花费时间也甘愿如此。

上述症状在正常人看来似乎很可笑，但对患者来说却如落入地狱般痛苦不堪。他们觉得不治好赤面恐怖症状，一切为人处世都无从谈起。

【病例】

我因为脸红，胆子小，完全没有自信，没有朋友，没有工作，我很痛苦，活着没有意义。每天都待在家里，周围的人都嘲笑我，我要疯了。几年来，我承受着两种折磨：白天窒息的赤恐和夜晚强烈的思念。我一直认为自己是世界上最不幸的人，从小我在公共场合就不是什么很放得开的人，天生一副不成气候的性格，面浅，尤其对异性，属于只活跃在表面上的拟外向型，但是起码不会有事无事都脸红。上了高中后竟然鬼使神差地开始高频率地脸红起来了，那个时候只觉得是自己面浅造成的，没有引起重视，同时伴随着视线恐惧直到毕业。我喜欢艺术，

却由于很多现实的因素，踏入了最不适合自己的警校。这时才开始意识到脸红确是实实在在的“问题”，却为时已晚。关于交感神经的交互作用我不太清楚，只知道是反射，条件反射导致了症状。单就赤恐来说，以自己的经历来分析以下两种情况：首先，由于恐惧感，越是把注意力放在脸红上，越是感到面部燥热，即使接触到不应该敏感的事物还是会一触即发，出现症状，这种心态是医疗上的忌讳；其二，即使在极为放松或兴奋的状态下，突然出现的敏感事物会导致症状瞬间表现出来而无法抵抗，突如其来的尴尬更容易导致心理被阴影笼罩，使症状加深。可见，赤恐的反射一旦建立，单凭主观意识克服是不可能的，我尝试过很多理论，在身临其境的时候终究还是以失败告终。

【病例】

我今年30岁了，脸很容易红，特别是跟陌生人交往的时候，心里只要有一点点小变化，就会反应在脸上。随着年纪的增长觉得脸红很丢脸，所以不喜欢跟人交际。心里只要稍微觉得有一点点不好意思，或者有一点点紧张，心里咯噔一下，脸马上就红了。跟女士交往，怕人家觉得我这么大年纪还脸红；跟男士交往，怕人家认为我对别人有意思，其实心里不是这样想的。而且我不太敢正视陌生人的眼睛，跟陌生人说话时眼睛总是看着他处，显出很没有礼貌的样子。我很苦恼。请问这是什么样的情况？应该怎么克服呢？

【病例】

在高一的时候我喜欢上一个女生。因为赤恐，从一见钟情到现在一厢情愿，已经本科毕业了，而我却只能眼睁睁地看着

她和一个人分手，和另一个人交往；因为赤恐，我痛恨自己错过了太多的机会，然而在赤恐的面前我显得软弱无力，我是那么渺小……万幸的是，从某种概念上来说现在和她的关系还不错，只是长期的消极让我在面对她的时候始终不能突破压抑的感觉，因为太重要，所以心理压力重，我仍然会对她脸红，然后思维短路，语无伦次……任何人都没有理由接受这样一个我，我比谁都理解！然而我需要面对的不是她的拒绝，而是我已经疯狂到不懂得接受别人了。我甚至怀疑对她的思念已经强烈到变态的程度。看见别的女人我马上就会想到她，而看到她我就什么女人都想不起来了，所以我无数次地遭到拒绝，仍然无数次地坚持着，因为我不敢也没有能力放弃，即使一千次地被拒绝，我想我会一千零一次地坚持。我看到别的恋人在一起，马上就会去想象她和别人拥在一起的场景，这种撕心裂肺的折磨简直让人痉挛让人窒息！我强行克制自己不去想，但是越是那样越是无法控制……我的精神太需要她了，她可以使一切症状都好起来，改变我的人生观，但是我需要争取啊，我必须先让症状好起来，而这种矛盾太让我懊恼……我现在每天情绪好低落，几近崩溃，甚至做好了最坏的打算。如果最后和她一起的人不是我，我肯定会不由自主地把这种积蓄发泄出来，但不是自尽；接下来便是我的解脱和铺天盖地的嘲讽和舆论。如果说万事都有是非之分的话，我姑且承认这种错误的态度，但是命运和我开了天大的玩笑，除了感情，赤恐将我仅剩的正常生活都洗劫一空，致使我这种错误的观念越发强烈和坚定。但是我却不敢找心理医师，我害怕，害怕现在和医师共同铸建起来的赤恐防火墙，到她结婚那天会崩溃得更加彻底，体无完肤……

但是生存，除了压力，还有责任和负担，残留着的理智告诉我，我不能！我该怎么办？

【病例】

后天就要去实习了，可我却是个社恐患者，真的觉得压力好大。一想起来，我就觉得胃里一阵痉挛，所以我宁愿选择逃避不去想它。我是个即将毕业的师范生，胆小自卑，可教师这个职业偏偏需要你放得开，真是郁闷呐！看着教材我连翻都懒得翻一下，心里满是抵触情绪，要是不用去实习就好了。

想想我社恐已经有七年多了，从十七岁到二十四岁，一见到异性就提心吊胆，生怕脸红，可越紧张就越会脸红。其中痛苦的滋味也只有同病相怜者能体会得到了。

真是不甘心呀！看着其他女孩子都有自己的男朋友，或者都谈过恋爱，可我却始终处于感情空白期。可一见到异性就脸红的我该怎样去坦然地面对他们呢？马上就要毕业了，估计一毕业就会有三姑四婆忙着给我说媒相亲了，到时候我该怎么办呢？年龄这么大了，也应该找个男朋友了啊！

但愿上天能够发发善心，让我快点好起来吧！但愿我能找到一个好的心理咨询师，但愿我能够胆大自信起来，但愿我能够变得朋友多多，但愿所有在社恐里挣扎的朋友都能挣脱束缚！哦，但愿……

【病例】

本人21岁，男，如果脸不红，还算帅。因为脸红生不如死！我一听到“你脸怎么红了”，而且还带着嘲笑的样子，那个时候是无比痛苦的时候，还不如死了算了。有谁能理解啊，我连日记中都不敢把这个事情写上去，怕被看到，也怕自己看到。感

觉只有晚上才是我的活动时间——那个时候别人看不清我。

有了这个毛病，先不说什么女朋友的事情，就是工作都不好找，人要我这号人做什么，影响市容啊。我告诉自己：“你就连臭狗屎都不如。”我想过自杀，但我家很穷，父母怎么办啊。你说老天怎么对我这样不公平。年龄越来越大，连朋友都不敢交。别人是因为不好意思而脸红，我是因为脸红而不好意思。小时候还凑合着过，现在呢，没法过了。一听到别人说我，我的想法就是死。死了多好啊！可惜连死的机会，上天都不给我。

世上的好人，谁能救救我啊！一个生不如死的人的祈求。

3. 表情恐怖 表情恐怖患者总担心自己的面部表情会引起别人的反感，或被人看不起，对此惶恐不安。表情恐怖多与眼神有关。患者认为自己的眼神令其他人生畏，或认为自己的眼神毫无光彩等。有一位表情恐怖患者，他固执地认为自己的眼睛过大，黑眼球突出，这样子被人瞧不起，又认为自己的表情经常是一副生气的样子，肯定会给别人带来不快。他冥思苦想，竟然使用橡皮膏贴住自己的眼角，认为这样就会使眼睛变小。但眼睛承受极大的拉力，非常痛苦，也很难持久。最后，患者下决心动手术，当然没有一个眼科医生会给他做这样的手术。还有一位患者，他认为自己总是眼泪汪汪，样子肯定很丑，竟找医生商量是否能切除泪腺。另有一位公务员，他认为自己说话时嘴唇歪斜，给人带来不快，竟因此而考虑辞职。有的患者认为自己笑时是一副哭丧相，有的患者则认为自己眉毛、鼻子长得像病态的样子等。有个女同学在和别人开玩笑时，听别人说自己的脸长得像一副假面具，从此她对自己面孔倍加注意，

不知如何是好，最后甚至不愿见人了。

【病例】

我的一大困扰就是表情恐怖，这大概是九年前一次事件的阴影。那是一次同事结婚，我去参加的时候，给新人红包的时候，可能是太想压抑自己的紧张，太想给别人留下好印象的缘故吧，当时我的面部肌肉就像抽风了一样，面部痉挛，嘴角抖个不停。没想到以后这种情形就定格下来，一到社交场合，一紧张就会像放电影一样重现当时的情形。在下面的文字里我要引用一些心理学文章中的话，因为它们反映了我的真实心理活动。视恐有两方面的原因：一个就是性妄想的压抑造成的社恐，我恐惧的不是别人，而是害怕别人透过我的目光洞悉到我的性妄想，这种倒错首先从视线中表露出来，我恐惧的就是被别人洞悉到自己的想法；还有一个原因就是我对自己的意象评价是十分丑陋的，我对家里人特别是我的父母评价也很低，我在心底还是对他们很怨恨的，我对家人以及周围的一些人，怀着一些敌意，而正是这种敌意，正是这种对他人不能谅解与宽恕同时也不能原谅自己的态度，便是我产生并加重不敢见人的心理障碍的重要原因之一。我的社恐已经很深很深了，有过敏性牵连和被洞悉感。我对害怕的场面或人，会发生“草木皆兵”的心理泛化，对外部事物产生异常过敏的反应。别人在看我，甚至他人的一举一动，都暗示着对我的讨厌、排斥、无奈等，从而加强我回避的理由：由于我不好，所以人家讨厌我，与其让人厌恶，不如主动离开人群，何必自找没趣呢？从而以这种投射心理使自己取得病态中的平衡。我把我这么多年心里的真实想法都写了出来，希望得到心理医生的帮助，还有，想和目前

深受社恐困扰的朋友交流一下，共同进步。

4. 异性恐怖 异性恐怖的主要症状与前几种情况大致相同，只是患者在与异性同事或者异性的领导、上级接触时，症状尤其严重，感到极大的压迫感，不知所措甚至连话也说不出来。与自己熟识的同性及一般同事交往则不存在多大问题。

【病例】

也许由于以前父亲管得挺严，并经常在我耳边说“现在外面很乱，女孩子出去容易出事”等等，可能让我在潜意识里有了一种对男性的恐惧。到了中学和大学以后，一些因素的刺激，使这些潜在的恐惧转化为具体的表现：不敢看男性，一看就会紧张。若有男性坐在我身边，全身紧张得就跟拉紧了而又扭曲的橡皮筋似的。在这个时候，想笑笑不出来，想说说不出话，腰背酸痛，头痛难忍。而在大学中，学生、老师、食堂的、修鞋的、看门的，男性无处不在，我根本没有办法逃避，而且还要学习、考试，于是我每天像一张绷紧的弓，天天如此，当时我感觉自己随时都会“啪”的一声而把弦弄断了。回想起来，我竟然在这样恶劣的情绪中挣扎了大约九百多天，但有一个念头拉着我，让我没有去拥抱死神，那就是我还有十分疼爱我的爸爸妈妈，对我寄予了很高的期望，所以我想“我不能去死！我不能让他们伤心得在一夜间白了头，我要活得更好，让他们高兴”。

【病例】

我是个严重的社交恐怖症患者，主要症状是害怕异性，这是由于初中时我的有意压抑和过分自闭造成的。如今已十年过去，我的恐怖症状主要表现在目光恐怖上，我害怕异性，因而

有意地回避异性，但我越是回避，这眼睛越是鬼使神差地要去看他们，甚至是他们要害的地方。后来如果我的视线里出现与男生相关的比如打火机、烟、鞋或男人专用的衣物等，也会扰乱我的目光，使我心神不宁。如果我身边有男人，哪怕距离很远，我的目光都不自然，只好低下头闭上眼睛去躲闪。但我特别紧张，局促不安，全身别扭，因此我拒绝与人交往，与社会交往，我的生活一直处在半封闭状态中。另外，也因为这个目光问题，人们对我都极尽羞辱之词，让我的人格尊严受到伤害。

【病例】

我从小就害羞，怕见人，人家叫我“假丫头”。据说我父亲小时候也有“假丫头”的绰号，一辈子说不上一篓子话。现在我比他还厉害。20多岁了，也想找个老婆，可是我不敢抬头说话。一天到晚没完没了地抽烟，因为烟可以缓和我的紧张。在相亲时，我不仅满身大汗，且身体像麻绳一样扭着，既怕人家看前面，又怕人家看后面，手脚不知放在哪里好，头也点个不停，在场的人以为我犯“羊痫风”了，那女孩吓得叫喊着跑了出去……

5. 口吃恐怖 口吃恐怖可归类于社交恐怖的一种。患者本人独自朗读时，没有什么异常，但到别人面前时，谈话就难以进行，或开始发音障碍，或才说到一半儿，就说不下去了。患者对此忧心忡忡，因不能顺利地与人交谈而感到自己是个残缺的人，终于因此而非常苦恼。

【病例】

我是一名机关工作人员。我的性格比较内向，但以前社会交往还算可以，并没有太大的问题。我的反应可能是比较慢的，

在对自己不确定的事情要回答时，习惯性地爱拖长音，好使自己有个思考的时间。但我的新领导对此特别反感，他总说我各种各样的不是，虽然有时是以相对轻松的口吻说出来的，可我一样紧张。不知怎么地，我开始结巴起来，而且越来越厉害。只要领导让我汇报工作，我就不知所措，有时更是招来同事的嘲笑。我知道其实自己是因为恐惧而口吃，越想改变越严重，为此十分苦恼，请教授帮帮我。

6. 厕所恐怖 厕所虽然是一个场所，而厕所恐怖却被归类为社交恐怖，主要原因是患者实际上不是害怕厕所，而是害怕在厕所里与人交往，害怕自己的隐私被别人发现，有他人在场时无法顺利大小便。

【病例】

我是一个大一在校学生，患厕所恐惧症多年。这是我小时候养成的一个习惯。我原来不是本地人，四岁的时候从家乡搬到这里来。那时候的我特别胆小，又不会说这里的话，别人都当我是哑巴。在幼儿园想上厕所，不懂怎样说也不敢跟老师说，于是就一直忍，忍不住就干脆尿裤子。后来我每天早上去幼儿园前都要把大小便都拉干净才去上学，有时拉不出就不去上幼儿园，爷爷总是庇护我，上幼儿园时我就老是迟到。后来上小学，我仍然是这样，每次同学们叫我去上厕所我都会借不急而不去，即使真被他们拉去了，我都只是脱了裤子假装在拉，实际上什么都拉不出，有时真的很内急我会等他们都走了自己偷偷去，于是和一大班人真正上厕所一直是我最羡慕的事。小学无知，虽然觉得这样有点怪，但是还是这样过来了。初中时我

还是这样，随着认知的加深，反而觉得去厕所更怕了，连只有一个人时都拉不出了，于是我就尽量少喝水，等放学回家才上厕所。上高中时要住宿，这对我来说是个很严重的问题，但一开始由于大家不熟，都关上门上厕所，刚开始的一两个月，我反而正常多了。后来大家熟了，上厕所都不关门，我又开始不习惯了，又回到以前的样子，于是每回上学，我都等到大家都走了我才去。就这样又挨了一年。高二时，我把这事跟父母说了，他们说我是神，居然能把一件事隐瞒这么久，居然能忍尿这么多年。他们同意了我不住宿，于是高二、高三基本上都是我一个人住。其实高二、高三前期我都去做过心理咨询，曾经稍微好了一点，但高三后期就没时间弄了，于是又恢复原形。高中我不再无知，但这并不是什么好现象，有时知道越多就越害怕。你肯定想象不到我这十几年怎么过的，连我自己都不敢想象。也许是我已经习惯了。

这也不仅仅是习惯问题，我很多时上厕所都怕被人家发现，说我拉得很久，实际上就是怕别人知道我的恐惧症，导致更加紧张，但实际上别人没发现更不会说我什么。但我每次去时都摆脱不了这种想法。

7. 写字恐怖 写字恐怖主要发生在当别人注视的情况下，独自一人时写字不会出现恐怖。

【病例】

我早在读高中的时候，就害怕别人看我写字，一看我就非常紧张，手就抖个不停，并伴有轻度的头痛，字越写越大，极不规整，慢慢在人前既不敢提笔，同时还表情不自然，除身体

的僵硬感外，连思维都不灵活了。

8. 放屁恐怖 在有人的场合，放屁是非常令人尴尬的，这是每一个人都可能经历过的事。但极个别人由于一次经历，便成天担心在别人面前放屁，久久难忘，以致无法与人交往，这就是所谓的放屁恐怖。

【病例】

我的性格比较孤僻，而且越大越怕接触人，原因是我从小肠胃不好，总是放屁，人们叫我“屁精”。等到我长大后，这毛病虽然没有了，但我的臭味也离不开身了，一个人呆着闻不出来，和同学在一起，臭味就特别大，因为我从别人的眼光以及捂鼻子或是突然从我身边离开的动作中可以察觉到，所以我想与其人家讨厌我，不如我知趣点，每当遇到熟人走来，我便远远地躲开。

9. 教室恐怖 教室是每一个学生每天学习的场所，由于害怕同学的嘲笑或老师的提问批评，或害怕教室里同学的目光注视等而不敢去教室，久而久之便形成了教室恐怖。

【病例】

也许我从上学开始就习惯了小教室，到了大学每当有大教室的课时，我都早早去占座，在别人还没进教室之前坐定。如果去晚了，或是因特殊情况迟到了，在进入教室或穿过走道时，心里就打起鼓来，完全像做贼似地蹑手蹑脚，紧张，出汗，脸也白了，举步维艰地坐到位置上，全身发抖。由于我的抖动，不仅影响到邻桌及前后座的同学，有时全教室的人都不安。他

们用挪动身体、咳嗽、回头张望来向我“抗议”。

10. 聚会恐怖 人是社会性动物，与人交往，参加各种聚会是平时生活必不可少的。有些人由于偶尔出丑，便害怕各种交往，形成了聚会恐怖。

【病例】

我特别怕到人多的地方去，比如上商店、广场，参加集会、宴会或穿越马路。每当这时，我就心惊肉跳，既不敢抬头看人，更不敢与人交谈。我曾问过我母亲这是为什么，母亲说我在幼儿园时，有一次表演节目在台上出了丑，老师说了几句，从此就不愿去幼儿园了，后来在六岁时，母亲带我去逛商场，人多又把我挤丢了，我在人群里大喊大叫找妈妈，吓得尿裤子……

11. 会餐恐怖 社交活动中，和朋友或单位同事或陌生人一起聚众会餐也是常常不可避免的，个别人极度恐惧会餐场合，常常逃避。

【病例】

我20岁，十分孤僻，不爱说话，和别人交往有低人一等的感觉，几乎每天都在自卑中生活，有时想到轻生。出来打工的目的就是想在社会中锻炼一下自己，可是经过一年的时间一直不能适应，不敢和人说话，见人就害羞、紧张。我特别怕和人一块吃饭，那样我张不开口，连吞咽都感到嗓子噎得慌，我担心我会疯。

12. 出汗恐怖 出汗是一种正常的生理现象，在运动、炎

热、紧张等场合，每个人都会常常体验。可个别人对在公开场合出汗非常烦恼，以致达到恐惧而逃避正常的交往。

【病例】

我的问题就是在公共场合写东西或当众发言就开始紧张，紧张的同时额头开始出汗，这时如有风吹着，紧张即消失。如没有风吹着，则汗越流越多，直至变成“太平洋”，越想停止流汗越是流得多，就想离开，解决流汗问题。汗不流了，紧张也消失了。请教授赐教！

13. 体臭恐怖 每个人的身体都会发出气味，是汗腺分泌物所致。个别人对自己的气味非常敏感，总担心自己的气味让别人讨厌而不敢与人交往。

【病例】

我是体臭恐怖患者，因为把汗臭当成了腋臭，害怕得要死，还在那里涂香水。后来因恐惧紧张而以为自己有病，经别人介绍去做了腋臭手术。更可恶的是医生在做好后问：“那你到底有没有腋臭啊？”我后又因怀疑腋下的皮肤被我用香水和洗发液擦坏了而又逼爸爸带着去了一个认识的亲戚那里“做手术”，他弄了4分钟就说好了。而我回来后感到好多了。过了一天又那样，我才感到是自己的心理在作怪。我现在明白汗臭本来就是臭的，但我还是会害怕别人发现那里的秘密。

总之，社交恐怖症的症状是多种多样、复杂多变的，有的时候各种症状表现掺杂在一起，既有视线恐怖又有赤面恐怖还有表情恐怖，很难说清具体属于哪一种类型。

第 3 章

社交恐怖症的流行病学数据

国内外调查情况分析

社交恐怖症，是一种常见的、损害社会功能、影响相当数量人口的慢性疾病。

美国社交恐怖症协会指出，社交恐怖症是现时世界排行第三位的心理健康问题。专家指出全球约有 7% 的人患有此病，而平均每 100 个人当中就有 13 个人在他们一生中有发病的机会。社交恐怖症又被称作“被忽略的焦虑障碍”，近年来受到越来越多的关注。发病年龄大多为青少年时期，是一种病程长、自发缓解可能性较小的慢性疾病。与普通入相比，社交恐怖症患者更易独身或生活孤独，学习过程中会有更多的困难，工作中会错过更多的发展机会。根据美国全国疾病普查，社交恐怖症年患病率为 7.9%（其中男性为 6.6%，女性为 9.1%），终身患病几率为 13.3%（其中男性为 11.1%，女性为 15.5%）。社交恐怖症已成为继重度抑郁、酒精依赖后的第三大精神疾患。有一

项研究发现，约 20% 的人过分害怕公开讲话和表演，但只有 2% 的人因对工作或生活造成影响方才诊断为社交恐怖症。社区中的社交恐怖症患者仅有小部分（大约 5%）的患者为他们的状况寻求医生帮助，在美国推算有 240 万的患者没有接受任何治疗。

据国内调查，社交恐怖症占心理咨询门诊的 20%，女性多见。有人做过一项北京某中学 1337 名学生社交焦虑症的调查，67.5% 的学生说自己曾经偶尔有过社交恐惧的情况，经常有这种情况的学生占 10.7%，其中女生及高中生更为明显，有 1.4% 的人最后被初步诊断为社交恐怖症。

针对大中学生的社交恐怖症状况，华西心理卫生中心的 30 余位专家历时数月，在成都的 167 所中等职业学校、531 所中学和 36 所大学的 945 700 名学生中进行了抽样调查。调查结果显示，成都市大、中学生患社交恐怖者达到了 8.15%，与国际上大中学生患病率 7% 接近。19 岁是患社交恐怖症的高发年龄，达到 11.98%；其中女生多于男生；处于高考、中考阶段的发病率最高。此次调查覆盖成都市 734 所学校，94 万多名 12 岁至 25 岁的大中学生，这也是我国首次进行的社交恐怖症流行病学调查。

在我国台湾，20 岁以下年轻人中有越来越多的人罹患社交恐怖症，严重的成了抑郁症。心理学家认为，他们自杀的可能性大大高于正常人。现在，台湾患社交恐怖症的年轻人呈上升趋势。10 年前，每 100 人中有 1 人患社交恐怖症；据台湾一家医院的最新研究资料，现在每 10 人中就有 1 人。台北市疗养院成人精神科的林医生介绍，社交恐怖症患者有九成以上是在 20 岁以前发病的，其中四成病人可能是在青少年或学龄时就发病。据分析，社交恐怖症对台湾青少年的学业或工作有很大影响。

在青年和成年人患者中，有二成的患者滥用药物或酒精，并由此导致抑郁症，半数以上患有畏惧症，他们自杀的危险性高于一般人 5 倍以上。

香港中文大学医学院公布的一项调查显示，3.2%被访港人患上社交恐怖症，平均发病年龄为 19.5 岁。患者中只有近 9% 曾求诊，反映港人对此病症认识不足。香港中文大学医学院曾以电话形式访问约 3000 名 15 至 45 岁人士，研究港人患上社交恐怖症的人口比例、症状及求医意欲。按照比例，估计全港 15 至 45 岁的人口中，有 11.1 万人可能受到社交恐怖症的困扰。

社交恐怖症与其他精神疾患的共患情况

由于社交恐怖症发病较早，因此许多患者在患社交恐怖症的基础上出现其他精神障碍。世界卫生组织的一项研究发现：社交恐怖很少是单独存在的，往往伴随有其他精神障碍。大约有 70%~80% 的病人除了有社交恐怖外还伴随有至少一项其他的精神障碍。社交恐怖症患者比常人更易罹患其他精神障碍。常见的有场所恐怖症、单纯恐怖症、重性抑郁症、药物滥用、强迫症、惊恐障碍等。对 123 名社交恐怖症患者进行的调查发现，共患其他精神障碍的比例分别为：单纯恐怖症（63%），场所恐怖症（47%），广泛焦虑障碍（20%），抑郁（14%），酒精滥用（12%），惊恐障碍（10%）；同时有 10% 有自杀企图。许多患者试图以饮酒来缓解焦虑，故社交恐怖症患者中酒精依赖和滥用的发生率较高。在美国进行的流行病学研究表明，社交恐怖症患者的自杀观念较对照组常见，且在有共患病的患者中自杀企图更为

常见。表 3-1 是社交恐怖症与一些精神障碍的共患情况。

表3-1 社交恐怖症的共病率

	社交恐怖症 (%)	普通人群 (%)
单纯恐怖	59.0	13.2
广场恐怖	44.9	6.1
酒 滥 用	18.8	12.2
重症抑郁	16.6	4.0
药物滥用	13.0	5.0
心境恶劣	12.5	3.1
强迫障碍	11.1	2.5

目前识别和诊治情况

社交恐怖和其他许多焦虑障碍一样，虽然在初级保健机构中较为常见，但大部分未能得到诊断和治疗。有调查发现，在法国初级保健诊所，1 个月的患病率为 4.9%，但是全科医生的识别率很低（表 3-2），同时治疗率也是比较低的。可以这样说：社交恐怖症是一种被严重忽视的焦虑障碍。

表3-2 全科医生的识别率

	社交恐怖 伴抑郁	社交恐怖 不伴抑郁	其他焦虑障 碍,无抑郁	无 焦 虑 障 碍,无抑郁
以心理问题为主述	61.6%	5.6%	15.4%	7.2%
以精神问题为主述	76.5%	46.7%	64.9%	32.6%
以 焦 虑 为 主 述	11.1%	40.0%	18.9%	12.8%

在大多数就医行为中，社交恐怖很少被作为前来治疗的一个主要因素，然而社交恐怖的合并症状如抑郁、恐怖、药物依赖等会推动他们求医。在门诊、内科、急诊科、精神科门诊和精神科住院病人中，因单纯社交恐怖前来求医的比有并发症后前来求医的要少许多（表 3-3）。

表3-3 病人的就诊情况

	单纯社交恐怖	伴并发症	无障碍
门 诊 病 人	19.6%	51.0%	14.7%
内科门诊病人	17.0%	28.9%	9.2%
精神科门诊病人	5.4%	37.8%	7.9%
急 诊 科 病 人	1.8%	11.2%	1.4%
精神科住院病人	0.9%	13.7%	1.5%

在一项调查中发现社交恐怖症患者在治疗中只花 0.5 天时间在医院治疗而强迫症患者要花 5.5 天在医院治疗。在社交恐怖症患者寻求他人帮助时，有 78%求助于全科医生，21.0%前往公立医院精神科，20.3%求助私人开业的精神医生，14.9%求助心理专家，13.5%求助其他医生，8.1%求助于其他非医学专业人员。

在对社交恐怖的治疗中由于各科的医生对社交恐怖症的认识水平不同，给予的治疗也不尽相同。在一项调查中发现许多非精神科专业的医师往往较多地使用苯二氮草类药物和三环类抗抑郁药物治疗，这项调查是在前几年做的。就目前的情况来说，由于选择性 5-羟色胺抑制剂（SSRIs）进入市场，三环类抗抑郁药物（TCA）和选择性 5-羟色胺抑制剂（SSRIs）的使用基本持平（表 3-4）。

表3-4 社交恐怖治疗情况

治疗情况	百分比 (%)
没有任何治疗	16.2
普通精神治疗	10.8
综合精神治疗	9.5
苯二氮草类药物	58.1
抗精神病药	4.1
三环类抗抑郁药	32.4
选择性 5-羟色胺抑制剂	13.5

社交恐怖症的疾病负担问题

社交恐怖症是一种慢性疾病，其平均病程约为 20 年，自发缓解的可能性不大。流行病学研究发现，只有 1/4 的患者可以恢复正常，且恢复正常者往往具有如下特点：教育水平较高，起病年龄较大，无其他精神科共患病症。不过，如果能让更多的患者接受治疗，相信会改善患者的预后。

此病多发生于青春期前后，而这一阶段对于学业发展、人际交往及职业的选择具有极其重要的影响。这一疾病对患者会产生哪种影响？Wittchen 和 Beloch（1966）采用社会功能问卷（36 项），对患有社交恐怖症的成年人进行评估。研究发现，与对照组相比，社交恐怖症患者的生活质量严重受损，损害最明显的是由于情绪问题、社会功能及活力等方面问题而出现角色受限。就上述三方面而言，50% 的患者达到中度到重度的损害，而对照组只有 5%。而对患者本人而言，他们自我评价认为最严

重的损害体现在与配偶及其家人的关系、教育、就业等方面。

社交恐怖症不仅造成个人的痛苦，也会给社会造成损失。Wittchen 和 Beloch 发现，与对照组相比，患者的劳动生产力平均下降 12%，另有 11% 的患者失业（对照组为 3%），患者中有 8% 称由于自己的症状而请假，23% 称因自己的症状而严重影响自己的工作表现。

第 4 章

社交恐怖症的发病因素及机制

社交恐怖症的发病由生物、心理和社会文化等各种因素引起。下面就对这些因素进行探讨并对以往国内外的研究成果进行回顾和总结。

发病因素

（一）生物学因素

近年来，越来越多的研究者已经在社交恐怖症的遗传、神经化学、神经内分泌学、神经解剖学等基础研究方面取得重要信息。

1. 双生子的遗传研究 社交恐怖症的遗传学研究通过对双胞胎的调查统计来论证其发展。Torgersen 发现在一些症状如害怕在他人或陌生人面前书写、做事或进食的相似性上同卵双生比异卵双生明显得多。Horn 在对“社交技能”和“社交仪态”的研究中发现，同卵双生的相似度分别为 0.51 和 0.54，而在异卵双生中，其相似度分别为 0.18 和 0.21。Kendler 曾经报道在

女性中，同卵双生社交焦虑障碍发生的一致率为 24%，而异卵双生社交焦虑障碍发生的一致率为 15%。在对社交焦虑障碍的各项影响因素的研究中发现，来自遗传因素的为 0.21，来自环境因素的为 0.36。故环境和遗传是社交焦虑障碍发生的最重要的两个因素。

2. 神经递质因素 神经生物学家们发现社交恐怖症患者有特殊神经系统的改变，尤其是关于 5-羟色胺、去甲肾上腺素和多巴胺系统。尽管没有发现血小板 5-羟色胺载体密度异常，社交恐怖患者针对增高的焦虑及 5-羟色胺探针所引起的激素反应，表现出突触后 5HT1A 和 5HT2 受体亚型敏感度增高。血小板 5HT2 受体密度已被报道证实与社交恐怖症患者症状严重程度相关。在公开演讲的预期中，与对照组相比社交恐怖患者有心率的增加。社交恐怖症患者针对体位诱发试验或 Valsalva 动作所引起的去甲肾上腺素的反应也是增大的。当淋巴细胞内 β 肾上腺素能受体数目正常，由可乐定（一种 α_2 肾上腺素受体激动剂）所引起的直接的反应是激素增高。这就表明社交恐怖症患者中存在与去甲肾上腺素过度活动相关的突触后 α_2 肾上腺素受体功能的减低，脑脊液中也有多巴胺代谢产物高香草酸的降低。社交恐怖症患者对心理应激源表现出较强的肾上腺皮质反应。这提示这些神经递质的增加或者减少与社交恐怖症的发病有关系。

近年来神经影像学方面的进展发现了社交恐怖患者存在纹状体结合处低水平多巴胺 D2 受体和低水平多巴胺转运蛋白密度。他们已经证实这其中涉及皮质边缘通路，包括额前皮质、海马和杏仁核，在不同的实验条件下都表现出活动的增强。在

决定环境刺激的重要性的认知评价方面、在信息的情绪和记忆的整合方面，以及与条件性恐惧行为相关的表情方面，这些脑区所起的重要作用被广泛报道，社交恐怖症中在逻辑现象方面的结合被割裂。

还有资料表明，患有 Williams 综合征（一种由于 DNA 倒位导致的非遗传性病症）的人患恐怖症的比例要远远大于正常人群。几乎 96% 的 Williams 综合征患者都患有恐怖症，这表明恐怖症与个体的生物化学因素关系密切。Williams 综合征的儿童表现了各种焦虑和恐惧。最近 Fidler 等人比较了患 Williams 综合征的儿童与其他大脑发育迟滞儿童的焦虑情况。其他智力落后儿童报告的恐惧只有两种，即他们的父母生病或打针，但患 Williams 综合征的儿童却报告了很多种恐惧。一半以上的 Williams 综合征儿童报告了 41 种不同的恐惧。部分恐惧涉及人际争端，如被嘲弄（92%）、受惩罚（85%）和与别人争吵（85%），部分恐惧涉及身体上的问题，如打针（90%）、被火烧（82%）和被蜂蜇（79%），还有些恐惧是因为受听觉过敏和丑陋的困扰。尽管并非所有 Williams 综合征儿童都出现这些恐惧，但与其他智力落后的儿童相比，他们似乎存在较多的恐惧。

（二）心理因素

在心理因素方面，人格特征是社交恐怖症发病的主要因素。林雄标等人报告，EPQ 测查结果显示社交恐怖症患者神经质分和精神质分显著高于对照组，外向分显著低于对照组。社交恐怖症患者常有不健全的性格基础，病前性格多为自卑、胆小、羞怯、被动、依赖、高度内向、易焦虑、易恐惧、苛求完美、过分自尊、敏感、固执、重视他人的评价、缺乏自信、有强迫

倾向等。尤其是刚刚步入青春期的青年，由于生理上的巨变和生活世界的突然开阔，自尊心日益增强，对社会和其他人的评价也变得敏感起来。在这个时期中，如果在人际交往方面受到像失恋、当众出丑等精神刺激，常会在心理上造成较大的创伤，更容易在上述性格倾向的人身上引起焦虑不安和恐惧心理。社交恐怖症患者对自己的神态举止特别敏感，生怕自己在别人面前出丑，这样，便形成恶性循环，从而采取躲避方式。开始时躲避陌生人，后来竟连熟悉自己的人甚至连亲朋好友也回避了。由于强烈的害怕、恐惧心理，当事人在别人面前出现面红耳赤、讲话口齿不清、行为拘谨、心慌意乱、手足无措、心跳加快、手足发冷等反常表现。实际上社交恐怖症患者的恐惧心理是一种自我暗示、自我加强的心理过程。他们所害怕的对象并非是其他人，实际上是“自己吓自己”。他们把许多实际上并不可怕的人在想象中带上了恐怖的色彩。所以，每时每刻都摆脱不了忐忑不安的心情，造成极大的精神痛苦而不能自拔。

社交恐怖是人类独有的奇妙的现象。在动物世界里，看不到这样的现象。如果动物彼此排斥，也多半是为了生存的疆界、领地、食物与配偶，或者喜欢独居的习性。动物这样的排斥是朝外的，社交恐怖看起来是对某些人的排斥，实质上是朝内的，是自己对自己的排斥。感觉自己在他人眼里不完美、可笑、滑稽，甚至从别人眼里读出自己内心的可耻、卑劣、病态，把他人正常的行为、声音、表情看成是对自己的厌恶、藐视。虽然站在自己对面的人毫无察觉，但社交的真正意义也消失了，他客观上成为自我的一面“照妖镜”。一个人陷入对自己的排斥几乎是一种无解的心理困境，这种困境会激发一种强烈的神经症

冲突，伴随明显的紧张、恐惧、脸红、出汗、激越，甚至逃跑。对自己的不喜欢又怎么逃得掉呢？社交恐怖引发的内心痛苦、羞耻感、自我否定，甚至是自我憎恨会让资深的心理专家吃惊。有时候，仿佛感觉只有渴望死才能稍微平息那种自己对自己的愤怒。

有社交恐怖的人内心都有那么一个超然、完美、权威的我，它用苛刻的“必须”来控制自己，当社交中稍有不完美，一种强烈的自我否定、贬低、谴责便油然而生。是谁让人内心产生这么强大的超我？自然是动物们不具有的文化。文化激发人对自尊、理想化自我、荣誉的过度追求，结果导致一种反向，对自己产生一种神经质的压抑与否定。东方文化的耻辱感可能是造就自我排斥的重要原因之一，所以社交恐怖症中黄种人多，日本的心理学家干脆把它称为“恐人症”。

不过，社交恐怖还有更深层的意义，一般聪明的、敏感的、有些神经质的人容易陷入这样的困境，而这类人恰好是具有创造力的人。正如蜂群只需要一个蜂王一样，自然淘汰会让那些可能成为蜂王的蜜蜂早早被排除出局。神经症冲突是达成自我毁灭的捷径，优秀的人经这样的折磨也会变得平庸而失去竞争力。那么自我如何解读社交恐怖就很重要，如果你认为你的社交恐怖是一种病，你得到沮丧、病态行为和失败。如果你解读为我不爱社交，那么你得到时间、知识和内心宁静。社交是要花精力的，哲学、政治、文学、科学上有成就的人，多半是不喜欢社会交际的一群。

实际上，社交恐怖最核心的原因是其内心的自卑情结。我们每个人都有不同程度的自卑感，自卑感本身并不是变态的，

它们是人类之所以进步的原因，因为我们都发现我们自己所处的地位是我们希望加以改进的。如果我们一直保持着我们的勇气，我们就能以直接、实际而完美的唯一方法改进环境，来使我们脱离自卑这种感觉。没有人能长期地忍受自卑之感，它一定会使他采取某种行动，来解除自己的紧张状态。如果一个人已经气馁了，如果他不再认为脚踏实地的努力能够改进他的情境，他仍然无法忍受他的自卑感，他仍然会努力设法要摆脱它们，只是他所采用的方法却不能使他有所进步。社交恐怖症患者的各种行为都可以看成是为摆脱自卑而产生的。

【病例】

患者自我分析社恐原因

我目前深受视线恐惧和表情恐惧的双重困扰。自我分析：我自幼就有些性格缺陷，有完美主义倾向和强迫倾向；我属马，性格固执，敏感，脆弱。我的家庭环境不是很好，我的父母是从河南农村来新疆投靠我的伯父的，那时物质条件很艰苦。我的父亲原本也是个勤劳本分的人，就是有点打麻将赌博的爱好，那时迫于生计的压力，打得还不很厉害。父亲是那种安于本分、不好进取的人；母亲心气特别高，虚荣心强。打我记事起，他们就经常吵架、打架，到现在还是这样，在我的心里投下了阴影。我还有两个姐姐，但是家里人在精神上基本上不沟通，也沟通不了，我很少能感觉到家庭的温暖和家里人的爱。他们对我在物质上尽量满足，我觉得他们只是关心我的外在物质条件，在思想上从不关心我，我们太缺乏理解了。上学起，我继承了我母亲的秉性：心高，好胜，虚荣，内心脆弱。自从上初中后，我无论怎么努力也学习不好，一年比一年差，可能是我方法不

对吧。那时候自我意识开始复苏了，性意识也觉醒了。我的性格是那种内向自卑的，我很少和同学玩。我现在终于明白我为什么那么自卑了，是因为我心中早已种下自尊的根了，我太要强了。我是农村来的，我的同学及周围人都是城市的，我内心总是想：一定不要被他们看不起，我一定要比他们强。别人眼里的初中是最美好的，可在我的记忆里很糟糕，相反我的小学经历却很值得回味。记得我在小学学习很好，穿衣服也很讲究，很爱干净，很注意形象的。到初中以后可能由于天天死学、苦学，不得方法，学习成绩下降，内心的自责和青春期到来的影响，使原来注意形象的我一去不复返了。我变得邋遢，整天学不好，自责，苦闷，孤独。从初二我就开始失眠了，一晚上一晚上睡不着觉，就像神经衰弱一样。我开始到医院看病，开安眠药，那时候都是我一个人承受的，父母都忙着生计，我多想有个人能听我诉说啊！有一年初中的暑假，我没事干，除了打游戏机，就是和两三个玩得好的邻居到河坝上玩，在家没事的时候拿着我姐姐借的金庸写的几本武侠书看。书中有些男女性事那方面的描写，描写得比较艺术化，特别是女主人公刻画得很神圣，很高贵，使我在以后对周围形象较好的女生心存自卑。我觉得她们在我的心目中被神化了，我脑海里那种性意识的萌动是对他们的荼毒，是对他们圣洁形象的玷污。这种思想在我心里结下了死结，我的学习失去了优势——这可能是我唯一可以炫耀的资本，再加上在性意识上的误区，记得那时候，我在学习上的压抑转化到性意识的萌动上。我的苦闷，我的孤独谁知道？我从父母那里学到了压抑、忍受、冲突。我没有和别人交流过，没有人理解过我；我很少有机会参加一些课外活动，

没有和异性交流的机会。在同学们的冷眼中，转眼我上了高一，到了那时候我已有了抑郁症的样子，整个人郁郁寡欢，我的脑子不会动了，情绪很低落，自知力也下降了很多。后来，第四医院到我们这儿开过一段时间的门诊，我去看了，说是抑郁症。我吃了抗抑郁的药，效果不理想；寒假的时候我让父亲我带到第四医院看病，打针吃药，反而还严重了，心理负担也很重，毕竟是精神病院啊！真是祸不单行，我家那个时候又遇到绑架敲诈，我那脆弱的神经整天瞎想，想着是谁会敲诈我们家，谁会绑架我，我都有了被害妄想了，我都快疯掉了。随着案件的告破，虚惊一场。我的自知力下降了一半，我那时就是想到四院看病，我周围的人都没注意到我有问题了，我父母也不认为我有病，他们也没有时间管我。我后来吃过中药，练过气功，都没什么效果。

（三）社会环境因素

在社会环境因素方面，很多资料显示社交恐怖症患者的发病与童年时期受到挫折以及家庭教育方式有关。

1. 家庭环境以及父母的教育方式 众所周知，家庭环境以及父母的教育方式对个人的个性形成以及心智水平的发展有很重要的影响。社交恐怖症患者的家庭环境以及父母的教育方式又是怎么样的呢？国内外学者对此进行了调查研究。Chartier 观察到社交恐怖症与以下因素有正相关：与成人缺乏亲近关系、不是长子（仅在男性中出现）、家庭里的婚姻冲突、父母亲的精神障碍史、儿童时搬家超过 3 次、少年时期公平待遇及儿童福利的公正、9 岁前需要特殊教育、离家出走、儿童期的身体和

性虐待、降级、高中辍学等。数据显示一些童年时期的危险因素可能受到性别因素干扰，影响社交恐怖的发生。Swanson 等人还发现，恐怖症除与家庭结构、家庭教养方式有关系外，父母文化程度以及出生次序等都与其有着密切的关系。

流行病学调查显示家庭环境内在因素在社交恐怖的发生中扮演重要角色，如过度保护、过度控制、过度批评及虐待。日本学者认为，对人恐怖症与文化有密切的关系，曾认为对人恐怖症是日本特有的“文化结合症候群”。日本对人恐怖症发病率占神经症的 30%，明显高于其他国家，发病特征也有很多差异，如其他国家男女发病率基本相同，而日本男性明显高于女性。路英智、林雄标等人研究表明，不良教养方式，父母尤其父亲对其缺少情感的温暖、理解，过多的拒绝和否认以及有关性的烦恼是中国社交恐怖症发病的主要影响因子。

家庭成员之间公开表示愤怒、相互攻击、矛盾重重、脱离常规的道德观或墨守成规、追求完美，容易造成子女心理冲突，做事犹豫不决，无所适从，不利于其社会化的顺利发展。父母缺乏对子女关心、理解、信任和鼓励，他们将会更多地表现出对事物的冷漠、忽视态度，并随着儿童的成长而发展，延续直至泛化为对周围的人和世界产生一种不安全感，从而影响子女成年后与他人的顺利交往，过多地体验了无助、恐惧、不安全、孤独感；父母的过分保护，阻碍了个体独立性和社交能力的发展；父母的过分严厉与惩罚，往往会造成孩子做事过于拘谨和小心翼翼，唯恐做错事而受罚，在社会交往中害怕自己的行为表现被人指责，故而把注意力放在尽量避免被外界否定上，对内过于苛求自己，甚至对一些正常的欲望也产生羞耻感和自

责感，对外过分渴求他人的赞誉，致使他们担心失败，因此在社会交往中始终处于焦虑恐惧之中，从而出现回避行为。

【病例】

我的重度社交恐怖症病因

我从小在家受到父亲非人虐待及无理殴打，因无其他监督机构，导致长达6年在恐惧和担忧中度过，经常会想到死，精神恍惚。中学进入一所垃圾中学，经常被同学残忍殴打，但是因为目标为考出该校，学习非常刻苦，成绩优秀。中考成绩580，超过重点线20分，但因父母要求，又留在该校，超分数线90分。对该校产生巨大恐惧心理，不敢上学，对人充满敌意，不敢与人对视，精力十分虚弱。又跟以前的仇家发生矛盾，在混乱的帮派打斗中受欺负，又想努力学习，导致精力虚弱，易怒，怕见人，怕上学。到了高二，因为症状过于严重而彻底休学在家调养。我的症状：神经质症严重起来，极度虚弱却消耗非常大，胸口像压了几百斤的石头，轻轻一碰就有要吐血的感觉；脑袋感觉被压在一个很小的盒子里，而且大脑像被搅拌机搅过一样，都是糨糊，持续地耳鸣，头痛得要裂开，像被什么东西在天天挤压，每天上课必须趴着。一天要睡20小时以上，而且不见好转，稍微一动就难受得不行。因为上火挖出过超级大的耳屎，因为这个耳屎在洗澡的时候被泡，引起中耳炎，两只耳朵几乎聋掉；看东西是平的，眼睛里所有东西无立体感，而且似乎是从一个平方厘米的小孔往外看；每天晚上入睡困难，而且一睡着就做噩梦，而且梦都是红颜色的，被非常恐怖的怪物追。每天要面对我极其恐惧厌恶的人和事，精力极其虚弱，感觉生命已经只剩下一口气，精神十分恍惚，无自我意识，如

行尸走肉。无法忍受正常人可以忍受的许多事。对人恐惧，见人就躲，无法忍受噪音，哪怕非常微小的，也能引起我巨大的痛苦。一说话就像胸口要裂开一样，几乎要吐血或晕倒。更不要说上课讲话恐惧、出门恐惧等，那些我小时候就有了。

2. 童年期的生活事件 童年期的生活经历对个人的人格形成以及心理健康水平有很大的影响。童年期如果受到父母、老师或者其他监护人的虐待、不公平的对待，或者长期受到同伴的欺负、侮辱、耻笑，成年后更容易罹患社交恐怖症。特别是儿童在童年期受到性虐待或者性骚扰后，青春期甚至成年后更容易产生对异性的恐惧，罹患异性恐怖症。国内钟友彬等人研究发现，在 113 例社交恐怖症患者中有 110 例（97%）最后承认他们的症状带有性的意味，在详细询问了幼年经历的 78 例中有 67 例（86%）承认在青春期前有过主动参与的性经历。刘文等人的研究中，61 例社交恐怖症患者中有 98% 的人承认与性有关系。胡建、于永达等人研究发现，57 例社交恐怖症患者中，能回忆出有性不良经历者共 45 例，占 78.95%。常见的童年性不良经历是：①偷看异性成人如厕或外阴部（30 例，占 52.6%）；②男女儿童互看或互摸外生殖器（27 例，占 47.4%）；③摩擦外阴部或手淫（20 例，占 35.1%）；④窥看成人裸体或性交（17 例，占 29.8%）；⑤模仿成人性交活动（6 例，占 10.5%）；⑥偷着抚摸异性成人外阴部（4 例，占 7.02%）；⑦未能回忆出有性不良经历者（12 例，占 21.1%）。

还有资料表明，童年期频繁地转换学习环境如搬家、转学等都会增加患社交恐怖症的几率。

【病例】

说说我不堪回首的18年

一直都想说说我的事，说说我不堪回首的18年。我的事要从11岁开始讲起。这个暑假结束我就要上初中了，就在快要开学的时候，那时天还很热，有天晚上我就无意之中发现了父母的事情。这突如其来的事把我吓倒了，吓得一动不敢动，不敢喘气，生怕被他们发现也会对我那样。我浑身冰凉，没有温度，只有死人才这样吧。虽然并没太看清楚，但我猜到了，凭我那时仅有的从电视上得来的一点这方面的知识，我认为这是见不得人的肮脏的罪恶的事。白天见到他们我开始怕，恶心，讨厌他们，晚上只要听到隔壁屋里稍有点动静，我就怕得大气不敢出，用被子蒙住头和耳朵，不想听，不敢听。在学校里我开始变得沉默自卑，特别是在男生面前，我开始怕和他们接触，怕他们知道我身边有个这么危险丑陋的父亲，因此会歧视我。我开始和父亲也不说话了，总觉得他不怀好意，处处躲着他，提防他；后来的好多好多年中我也一共没同他说过几句话。

过了不长时间中学开学了，我进了初中，这时已是秋天了。在这个秋天里发生的另外一件事让我彻彻底底地崩溃了。一次学校包场电影，我受到一个陌生人的不严重的性骚扰。如果是我再大一点儿，或许这个事对我也没有太大的影响。但那时我太小了，才11岁，我能有多少这方面的知识？而且从来也没遇上过。我怕了，再次体验到那种濒死的可怕的恐惧。我以为这样就是失身了，我不敢动不敢喊，怕被后排的男生看到因此对我产生非议，因为在这之前我已经对异性开始怕了。那天看完电影，从影院出来，我和邻居的一个小女孩一起走，外面的阳

光很灿烂，可我浑身冒着冷气。我不敢告诉任何人，不敢告诉家里人，我怕会被家人瞧不起，会被斥责。于是我将所有所有的事情埋在了心底，永远地埋在了心底，直到十几年后。尽管我如此悲伤、恐惧，但我不敢让任何人看出来。我想哭，但当着人的面我又不能哭。只有在夜深人静的时候，家人都睡了，我蒙上被子，偷偷地、拼命地压抑着，无声地让眼泪肆意流淌。我们姐妹三个睡在同一个屋，她们竟没能发现，你说我隐藏压抑到了什么程度！好长好长时间，有十几年吧，我一直觉得喉咙那儿堵得很难受，是因为压抑。在学校里，我也不能学习了，坐在课堂上我的脑子里全是这个事情，有时就偷偷地流出了泪。我就独自承受着这些事，无时无刻不深陷在其中。对异性的恐惧之中带着深深的自卑，可以说是自尊心全面地崩溃了，没有了尊严。我开始远离童年时的伙伴，独来独往。我觉得我是个很令人讨厌、令人鄙视的人，别人都瞧不起，我恐惧自卑得不敢走近人。

有一天，我走在上学的路上，快到学校的时候，迎面走来三个男孩子，我突然之间不知道眼睛该往哪里看了，很无助，很慌乱。我看到在他们身后不远处的一棵大树，于是就目光死死地盯住了那棵树，终于走过了他们。我想从那时起，我就不敢正眼看人了，也怕让人看到我。正常的人谁也不会有意识地考虑自己的目光，在这之前我也从来没有这种感觉。走在放学的路上，我感到周围的人离我那么遥远，这也是我第一次有这样的体验。那时因为没看过心理学方面的书，所以不会去对号入座，没有得病的意识，只是纠缠在自己的事和深深的恐惧之中，痛苦得不知如何是好。好多年里还在想，如果我没有遇到

这些事会如何如何。这一切都是发生在11岁。从那时起，我不再与任何异性有来往。其实11岁时我已完全无法学习了，但这一切我又不能跟任何人说。上课的时候，由于周围都是男生，老师也是男的，我根本没法学，只有无限的恐惧，独来独往，但又怕被人嘲笑说我无人理睬。我不再会笑，在后来的十几年里，我不知道笑是一种什么滋味，我曾经对着镜子做出笑容，但我看到的只是一张悲伤的脸，嘴角被两手拉扯着勉强地向上翘着，很难看，整个的面部肌肉都紧绷着。初中时班里一名男生在背后给我起外号——冷血动物，这还是通过我妹妹知道的，因为我已经远离了人群，不再和谁交往。当从妹妹口中得知后，我心里涌上一种很难受的感觉。现在想想他也不一定有什么恶意，只是我在病中太敏感了。因为我看起来呆呆的，学习也不好，别人以为我很笨，甚至还有很个别的人把我当弱智的傻瓜看，欺负我。我无力反击，因为我怕。我也不敢和家里人说，怕他们斥责我，尤其是姐姐。初中毕业的时候因为想逃避过去的同学，就复读了一年，给家长的理由是想考个好班。复读后还好，那一年换座位与女生同位的时间长些，学习还可以，只是一调到与男生一个位时，我就战栗，恐惧。整个高中，我都没有学，实在没法学，坐在课堂里对我来讲是种痛苦的折磨。我怕，我怕同学，怕老师，怕所有的人。我怕别人看到我，也怕别人的眼神。从11岁开始，所有的假期我都是待在家里，不敢走出家门一步。我一直把自己裹得很严实，不让别人看出我什么，看出我不正常来。在病中很敏感，也很脆弱，脾气也很坏，别人无心的一句话可能就会引起情感的大爆发，当然这种爆发在我也只能偷偷地躲起来爆发。从得病起，除了上学外，

我不仅总躲在家里不敢出门，而且就是有亲戚以及家人的朋友到我家玩，我也都是藏在一个小屋里，一动不敢动，不敢大声喘气，不敢弄出动静，不敢出这个小屋门一步。因为我怕被人知道我在家里而不出来接待他们，我也怕见他们，认为亲戚都把我看成弱智。一直以来，我活得生不如死。

（四）传统文化与社交恐怖症

近些年来，许多心理学家都尝试对社交恐怖进行解释，由此提出了自己的学说，但没有一个学说能够完全清楚地解释已知的各种病前情况（产生原因）以及病后的表现。社交恐怖在临床上常常可以见到这样的病例：病人从小害羞、怕见人，又特别爱面子，争强好胜，并且一直缺乏社交训练，没有任何兴趣爱好，充其量只是会啃书本子，考试总是名列前茅，从青春期开始，他们的社交恐怖便明显严重起来，但心理学者和医生们却往往找不到什么确定的发病诱因。

哲学和心理学的研究告诉我们，在人的内部，起决定作用的是人格结构，是人格结构决定着人们将要做什么，以及如何做和为什么做，而这正是文化特质和模式之所在，人类创造着文化，文化也在不断影响着我们人类。特定的人格结构是特定文化结构的缩影，人类许多的心理疾病包括社交恐怖症的产生，从深层次的角度来讲，与个体所在的社会文化因素有着深刻的关联。

1. 心灵在传统文化与外来文化的碰撞中产生挣扎 目前中国正处于文化转型过程中，随着社会变迁的加速和深入，传统文化以前所未有的规模和速度与外来文化进行着相互交流和渗

透。外来文化的娱乐时尚、行为方式、理论思潮和价值伦理对人们既有的文化心理形成了外在压力和冲击，这使人们在观念和行为上不同程度地有了一种“两脚踏东西文化”的心态：对传统伦理的依恋和归属与对外来文化的冲动与向往同在，既有新的文化视野带来的新鲜感和喜悦，也有文化撞击导致的失落和苦闷。传统价值的导向作用趋于弱化，而“舶来文化”嫁接的价值规范尚未确立。个体的心理经历着价值空缺、规范松弛的失序和阵痛。

(1) 文化变迁使社会适应变得困难。在消息闭塞、社会关系相对单一、生活节奏单调而缓慢的传统的中国社会生活中，文化环境单纯而且相对稳定，个体的文化适应是在文化传承过程中自然而然实现的，人们容易保持内心的满足、恬淡和平衡，因而个体对社会的适应几乎是顺理成章的。但是，社会的现代化进程却对此提出了挑战。因为呈加速度运动的现代化过程“是一种心理态度、价值观和思想的变化过程”，它深刻改变着人们的精神和心理状态，改变着社会的人际关系、交往规范和行为方式。社会的这种迅速变迁要求个体做出相应反应，使个体与时代能同步发展，因此，个体生活的文化环境具有更大的多变性和不确定性，其社会生活适应的难度剧增，人们害怕与人交往的心理也就随之产生，严重的就成为社交恐怖。

(2) 文化交融诱发“双重人格”。在这种传统文化与外来文化冲突与选择互动的文化背景之下，人们都不同程度地具有“双重人格”的特点，一方面人们充满了对超前思想、现代观念和新型人际规范的向往，充满了对传统文化的反思和叛逆；但另一方面，传统文化的深厚积淀又使人们对传统的思维定式和

行为模式表现出认同与习惯。美国社会学家阿·托夫勒曾经把这种由于内在的文化创新和外来的文化移入引起的文化急剧变迁对人们的心理和生活的冲击和震动称作“未来的震荡”，认为“它使人们在一个极短的时间里承受过多的变化之后，感到压力重重、晕头转向以及不知所措”。文化转型所导致的“双重人格”，不仅使人格的内在平衡，即个体的价值需求倾向、个性心理特征、自我行为调节这三方面的平衡变得困难，而且使人格的外在平衡，即个体和社会文化关系的协调趋于动荡不定。人格结构的内外失衡都必将导致人们不同程度的对自我和他人的认知混乱，从而对人际交往感到无从下手，畏惧与逃避人际交往的心理也就应运而生。

(3) 表层观念与深层文化的错位导致内心痛苦。随着改革开放的深入，确实有许多人的观念发生了迅速的变化，但深层次上的文化问题和人格问题并没有解决。人的大脑接受新的观念、新的知识非常快，但要在思想深处进行调整，就不那么容易了。当个体深层的文化结构还没有改变的时候，却又输入了新的思想观念，这应该说是悲剧性的，因为这意味着个体深层的文化同表层的观念形态是错位甚至是对立的，这样会导致人们心理的矛盾与分裂。现代的中国人是幸运的，那是因为赶上了经济和文化发展的好时代；但现代的中国人也是不幸的，因为他们必须因此而忍受内心深处矛盾和分裂所带来的痛苦。一切都是不固定的，一切都无所适从，一切思想和观念都得不到有力的、有意义支持，人的肉体和精神就好像在风中漂浮，无根无蒂，永无宁静。

2. 传统文化中具有诱发社交恐怖的因素 人的本质属性是

社会属性，人从其本性上说是需要同他人发生关系的。人格也是从与他人的关系中形成的。而社交恐怖就是在个体对自我、他人以及整个交往系统的矛盾认知和不良体验中产生的。中国传统文化相对现代文化来说，其中有许多成分都有可能成为现代社会诱发社交恐怖的因素。

(1) 中国传统文化中对“自我”的认知。自我是人格的主体部分。根据心理学的研究，“自我”可分为三个层次：一是内在的自我，二是人际自我，三是社会自我。作为单独的个体，每个人都有自己的内在的自我，这是我之所以为我的根据所在。但是，任何单独的个体也都是生存在同他人关系之中的，都是作为社会的一分子而存在的，所以又必然具有“人际”的自我和“社会”的自我。由于任何人都既是他自己，同时又不能不同别人或群体相联系，所以，每个人的人格结构都包含着这三个方面。但是这三个方面中，究竟谁充当了人格的核心，这便可以区分不同的人格类型，不同的人格类型便是不同文化类型的折射。西方人的人格构成是以内在的自我为核心。在西方人看来，一个人要成为什么样的人，不是由其他任何人决定的，而是由自己的内在自我决定的，人际自我和社会自我都是在内在自我的支配下实现的。作为个体的人，只有从其所属的各种社会角色和社会关系中跳出，才算是真正把握到内在自我，也才算真正把握到了作为个体的“人”。如果没有经历过“从所有的社会角色中撤出，并且以‘自我’作为基地，对这些外在的角色做出内省式的再考虑”，那么，这个人就成为一个没有自己面目的“无名氏”。这是西方人对自我的看法，这种看法无疑会让个体更加尊重自我，而顺从自我的召唤去行动。中国人是以

人际自我为核心来铸造自己的人格。以人际自我为核心，就是说人在构建自己人格、决定自己将要成为一个什么样的人时，主要不是从自己的内在自我，而是从他人对自己的要求出发进行自我设计。换句话说，不是自己给自己定义，而是由他人给自己定义。这一点突出地体现在儒家学说上。儒家曾对“人”下过一个定义：“人者，仁也。”是以“仁”来定义“人”。所谓“仁”，许慎《说文》云：“仁，亲也，从人二。”可见，“仁”就是强调“二人”之间的关系，打破人的独立状态。这一点在中国文化和中国人格结构中体现得非常明显，中国文化正是在两个或两个以上的人之间的关系中构建自己的人格，进行人的设计的。在中国最常见的人际关系有五种（“五伦”），即君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友。每一个中国人都首先在这五种关系中接受定义。

因为重视人际关系，以人际自我为核心，所以中国人对自己的要求也就同西方人不太一样。儒家是要求每个人都能成为“仁”人的。但什么是“仁”？孔子的定义是：“仁者爱人。”强调“爱人”，就表明他是从人际关系上考虑自我，定义自我的。与之相关的还有“恕”，“恕”就是“推己及人”，就是“己欲达人”，“己所不欲，勿施于人”。这里的意思是，考虑问题应该将对方放置在自己的位置上来进行，亦即从对方着眼，为对方着想。这是人际自我的另一种表现形态。

中国传统文化从来不是孤立地对人进行定义的，而总是在同他人的关系中定义。黑格尔曾说，对某物的定义，就是对某物的限定。用他人对自己定义，就是用他人来限定自己。在文化观念、人际关系纷繁复杂的当今时代，如果我们总是有意无

意地用周围的各种各样的他人观念来限定自我，那么最终的结果就是内在自我的丧失，而一个丧失内在自我的人是无法拥有正常的人际交往的。

(2) 传统文化对“个体独立性”的认知。中国人由于是从人际自我来构建自己的人格，因而，他们的内在的自我实际上是由他人内化而成的，比较缺乏个人的独立性。严格地说，在中国传统文化中，独立的或者纯粹的个人是没有意义的，因为它的内核是空虚的，没有内容的，即没有经过定义的。只有当他与他人或社会发生关系，并在这种关系中被定位，获得某种人伦或社会角色时，他才会获得自身的属性和意义。

中国人喜欢用社会角色来称呼每一个人，道理即在这里。比如某某书记，某某主任，某某部长等，就是用社会角色代表的群体来对个人进行界定。中国人对别人很少直呼其姓名，因为这不能够体现出被叫人的身份、意义和价值。即使没有或不使用社会群体的角色来称呼的，如在家里家外，也是要以他（她）与另一个人的关系来相称，以体现他人对他（她）的定义。如称“孩子他爹”、“李家大嫂”等。而在西方，称对方的名字则是最常见的现象。甚至常有儿子对老子直呼其名，这样的称呼在中国是被视为最没有礼貌的。因为这个缘故，在中国人的心目当中，未成年人是很少具有社会意义的，因为它只具有一种自然的人际关系——血缘关系，尚未形成社会性的人际关系。只有当他成年之后，而且在社会上充当了某种角色，即所谓“立业”时，他才具有社会意义。同时，作为一个成年人，他（她）也有待于一种新的人伦关系的建立来对他（她）进行确定，那就是“成家”。“男大当婚，女大当嫁”，表面上似乎

只是一个生理上的必然，但实际上也包含着文化的意义：你的存在有待于你的配偶和子女给你定义，赋予你意义。如果一个人已经成年，但尚未成家，那么，作为最重要的人际自我中的一部分就是残缺的，你的定义就是不周全的，你的意义就是有所缺损的。

传统文化中由于个人缺乏独立性，个人有待于他人和群体的定义，就使得个体在内心深处非常在乎他人和群体对自己的评价，害怕在交往中给别人造成不好的印象，引起别人不好的反应。这就会导致在交往行为发生前，个体就对自我的交往技巧和交往能力产生了较高的期待，总希望自己能以超群的口才和举止得到他人和群体的称赞与喜欢。而怀有这样过高自我期待的人，在交往中就不可避免地会遭遇挫败，这时个体就会认为自己欠缺社交能力，从而每次在与他人或人群发生联系之前，都会产生紧张害怕的心理，而这些正是社交恐怖症产生的重要原因之一。

(3) 中国人的“他人”位置与“耻感”文化。西方人同他人交往，总是倾向于同对方保持适当的距离，以维护自己的独立性。在西方思想史上常常会出现“自由”、“人权”等思潮，这都体现了文化对个体的尊重。而这在传统的中国乃至整个东方世界中简直微乎其微。在中国人的深层意识中，“自我”不是上帝，“他人”才是上帝，因为“我”的意义是由他人给定的。这一点我们可以在中西伦理的不同的心理基础上看出：西方人的伦理意识根植于“罪感”；中国人则根植于“耻感”。“罪感”是建立在个人意识和对自我的充分认定的基础上的，是理智地意识到自己“有罪”；“耻感”则是建立在他人意识之上

的，是感觉到自己在他人眼里“可耻”；前者无须面对他人即可产生，后者则是只有面对他人时才会发生。前者属于个人伦理，后者则属于群性伦理。

“罪感”无须“他人”出面，只看事情本身的“对不对”，只是以内省的方式审视是否违背“自己”的原则，如果有，尽管没有他人在场，也会感到不安和有罪。而“耻感”则必须有“他人”在场，并以他人的看法为转移。从构字法来看，“耻”，从“耳”从“止”，是指自己在听到他人议论以后，就将原想做的事就停止了。“耻”的另一种写法“恥”，从“耳”从“心”，是指听到他人在说自己，心中马上就感觉到了。这都是从“耳”。从“耳”即为“听”，而“听”当然是以他人为对象。所以“耻”总是依赖于有“他人”的存在。“耻感”的根源是在“他人”，而得以发生的机制，就是他人之“言”，即他人的“品”和“评”。“品”是三个“口”，即众人之口，亦即大家对你的评论。而“评”，从“言”从“平”，意即用议论来铲除你不该有的东西，使你同他人一样。所以，中国人的“耻感”是建立在他人对你的评论的基础上的。中国人唯恐被他人议论，唯恐有人说三道四，亦即“人言可畏”的心理，源于此。

也正因为“人言可畏”，才需要认真对待，才会出现道德意识。而中国人的道德的实质，就在于将他人对自己的要求转化为自身内在的行为倾向和价值取向。建立在“耻感”基础上的道德意识，既有积极的一面，也有消极的一面。积极的一面在于它能够重视对方，替对方考虑，使人与人的关系易有人情味。因为人毕竟是社会的人，毕竟要同他人相处，如何提高这种相处的质量，中国的这一思路能够起到积极的作用。消极的一面

则在于它容易将人际关系变成应付，将与他人的相处仅仅理解为“做人”，从而产生出“面子”意识、“被看”心理，同时使得个体不得不忽视、压抑个性而追随大流。这些就使得许多性格内向的人感到人际交往是一种负担，既想和人交往，希望在交往中得到他人的认可，体验自我的价值感，但又害怕交往不成功，受到别人的冷落或耻笑。因此在交往中变得思前想后，优柔寡断，内心非常矛盾，久而久之，人际交往就产生了困难。

(4) 传统文化对“私人状态”的否定。在西方语言中，“私”是一个中性词。“私利”就是个人利益，“隐私”就是个人秘密。这些都是正当合理且受法律保护和社会尊重的。但在中国的语言中“私”则是贬义的。

在正统的中国文化中，多少年来，私人状态始终不发达，甚至是被否定，那些提出个人利益要求的观念，往往也被极端化或者丑化，如“拔一毛利天下，而不为也”，这是被正统文化所不齿的。在中国人的意识里，夫妻、挚友之间是不应该有秘密的，即使有，也少得可怜。这并非有什么人在强迫个人交出私人秘密，而是在他自己看来，根本没有保留这些秘密的必要。他希望让他人看到自己的全部，毫无隐讳。否则，他的心理就会不安，觉得对不起人。

应该注意的是，重视私人状态，并不意味着一定是私心泛滥；而缺乏私人状态，并不一定是大公无私。自私和私人状态有联系，但不是一回事。在西方文化中，由于“私”是被肯定的，所以也是公开的，那么就有相应的规则，即法律进行调整以及保护。而中国人认为“私”是见不得人的，所以是要被隐藏起来，或包装之后才拿出来。例如最常见的形式是通过利人

来利己。老子说：“将欲取之，必先与之。”先给后取，多给少取。有了给，后面的取就变得光明正大、理直气壮了，即为自己的私心提供了充足的理由。孟子也说：“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”这里的言下之意是，你要想别人怎样待你，你就必须怎样待人。个人的“私心”通过为他人着想的方式表现出来，才能够给人的心理以安宁。

这种对个人正当利益、个人正常需求的否定，使得中国人在实现自己利益，即便是正当的自我利益时，势必要拐弯抹角，偷偷摸摸。这对于现代人，尤其已经接受、认可了很多西方文化中关于“私人”、“自我”观念的年轻人来说，是非常矛盾的。一方面他们非常尊重个人利益，个人隐私，希望能够充分实现自我，羡慕西方世界个人利益是神圣不可侵犯的现实；另一方面，他们又认为舍己为人、大公无私这样的行为是非常高尚的，集体利益和国家利益应该高于个人利益。在两种文化价值的交织中，他们很难老练、圆滑地将二者结合起来，在现实中既能实现个人的既得利益，又能履行中国传统的道德理念。因此，在他们眼中人与人之间的关系就变得非常复杂，难以把握，与人交往也是一件让人很不舒服的事情。

(5) “群体”对于“个体”的意义。在西方，群体是以组成它的个体为出发点的，是以个体的独立性为前提的。所以，尽管也存在着个体对群体的依赖和认同，但这时处于自己的自由选择，是由自己的意志决定的，而且是以自己个体的目的和利益为前提的。在最深层的下面所支撑的，仍然是一个纯粹的自我。西方人常常变换自己的工作，虽然有多种原因，但使自己保持相当的独立性，则是一个更为深刻的原因。根植于个体

本位和个体意识的西方人以自我实现为人生第一原则，形成追求人生意义的价值张力。由于没有一个外在的群体凌驾于个体之上，自己的行为无须对谁负责，一切都是由自己自由选择，一切后果也只是由自己来承担，所以西方人能轻装上阵，无所顾忌地去猎取名利，实现自我，甚至冒险，丧生也在所不惜，同时认为在契约和法律的允许下，以自己的能力去获取更多的利益、追求更大的快乐本身是值得肯定的。

中国人则不同。中国社会的群体本位和中国人的群体意识，使我们无法超越所属的群体，相反，总是使人们时时刻刻意识到群体的存在，思考着群体的利益。这样，个体的一言一行就不是个体本人的事，而是群体之事了。这种群体就好像一个沉重的包袱，压在每一个个体的身上，使我们干任何事都要思前想后，步履维艰，唯恐有辱、有损于所属的群体。这种沉重的责任感便形成中国人强烈的忧患心理。这个忧患不是对个人利益和安危的患得患失，而是忧群体之利益，乃至忧天下之利益和得失。所以“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，“向来忧国泪，寂寞洒衣巾”，就是这种忧患心理的写照。

实际上在传统的中国文化中，个人的成长过程就是一个不断提高对群体（包括家庭、学校、工作单位、党派等各种社会团体）的认同性和依赖性的过程。中国人的自我本来就不是独立的，它的自我价值和意义是由他人和他所属的群体所赋予的，所以必须将自己投入这个群体之中，通过对它的认同求取自身存在的价值与意义。在传统文化中，理想、成熟的人格就是那种确立了以人际自我为核心、具有他人意识和群体意识的人格。在这样的文化中，个体没有独立性，没有自身的价值标准，一

切行为的最后根据不在个体而在群体本身。在某一个个体来到这一社会、群体之前，这一群体就已经将他定位了，所以中国人无论在何时何地出现，他都不是以纯个人的身份，而是以所属群体的身份，或是家庭，或是党派，或是民族、国家。而这个社会中的个体也只能通过社会、群体对他的定位才能获得自身的价值。

当个体的某些行为与群体既定的某些规则不符或者因为其他种种原因，导致自己不被群体关注和认可时，这就意味着这个个体是没有个人价值的，对那些非常关注自我价值的个体而言这是个非常可怕、难以接受的现实。而个体对这一现实的反映可以是以新的行为积极获取群体的认可，从而也获取了自我价值，也可以是忽视这个群体的评价，重新寻找属于自己的新的群体，获取认同与价值感。但对于那些在一定时间内，在现在群体中无法获取价值感，同时也没有勇气和魄力出现在群体的个体来讲，他们只能默默忍耐着内心的煎熬。这些人中，有的在忍耐中逐渐麻木，降低了对自我的期待；而有些人则背着沉重的自我价值期待，与他人进行交往，这些人往往容易产生社交障碍。

(6) 中国的面子文化与社交恐怖症形成的关系。中国的面子文化如影随形地伴随着社交恐怖症患者。面子的内涵和取向是多元化、多层次的，中西方在面子的内涵与取向方面有着很大差异。面子的这种不同内涵和取向，作为一种影响因素，对于生活于其中的人的心理和人格特质的形成，起着至关重要的作用。西方人认为上帝面前人人平等，人们高度重视个人的权力和价值，人与人之间的关系基本上是平行的，个人的成败是

个人的事情，与他人无关，别人也不会特别关注。所以西方人所谓的面子指的是个人的面子，是个体取向。他们使用面子功夫（给别人面子和保留自己的面子） 主要是为了人际交流中的相互合作，强调面子的协同作用。他们在交流中既重视正值面子（希望得到别人的承认和赞许），也重视负值面子（一个人在某种范围内的权力，强调他们的权利不完全受某社团或社会价值的支配，尤其是他的行为不受别人的妨碍和强迫，最低限度地考虑别人的需要和兴趣），使个人在与他人的交流中，既保持一定的独立性和自主权，也使他人的独立性和自主权得以维护。正是由于这种个人的价值取向，以及自我独立性和自主权的保持，使得他们在遭遇失败或挫折的时候，有可能产生的是无用感和自责自罪，其情绪体验是抑郁，较少会因“丢脸面”而引起恐怖。

中国社会受儒家文化、地缘文化和农耕文化的影响，人们非常重视自己与家庭以及自己所属群体之间的关系，人与人之间的关系是交叉的、立体的、网状的。在这种关系状态下，一方面，个人的成败，并不单单是自己的事情，而是与自己的家庭和所属群体有着密不可分的关系。它关系到自己的家庭和所属群体的切身利益和“脸面”问题，一荣俱荣，一损俱损。另一方面，社会对每个人都有角色要求，当个人的行为符合社会情境角色要求时，就是成功的，他人也会对自己有一个好的评价，自己就感到有“脸面”，能够面对他人；相反的，如果个人的行为不能符合社会情境对个人的角色要求，就认为是失败的，他人就会对自己有一个不好的评价，自己会觉得“丢脸”，愧对他人。从内涵方面来讲，中国的面子文化比西方的“面子”大

得多，总括起来有五个方面的内容。一是人际关系。在社会交往中，中国人不但要顾自己的脸面，还要顾及别人的脸面，使人际关系的建立得以维护和保持。二是成为社团成员的入场券。人们“争脸面”是为了使社团接受自己。三是和社会地位有关。得到了优越的社会地位，也就为自己和相关的人争得了脸面，大家就能从中获得荣誉和利益。四是与社会秩序有关。若一个人违背了道德标准，违反了法律，就会使自己和家人“丢脸”。五是和自尊有关。脸面和自尊都是来源于父母的早期评价和解释，并需要在社会活动中才能得以实现。自尊是一个人的精神内核、生命支柱。它是个体在社会实践过程中对自身价值、重要性和能力的一种评价体验。这种评价不但来自自身，更依赖于他人。“丢脸面”会使自尊心降低，在社会交往情境中有时出现的“死要面子”行为实际上就是为了维护自尊，使自尊心免受伤害。从而可以看出，在中国社会里，这种由儒家文化衍生出来的面子文化，有着自己独特的不可替代的功能。它调整和维持着人际关系，保证人与人之间关系协调和整个社会的秩序稳定，并使个人有一种归属感和安全感。

各种心理学学派关于发病机制的论述

（一）行为主义学派的观点

行为主义者认为，社交恐怖症是通过学习而获得、强化从而固定下来的。华生曾经做过一个实验，使一个小孩对原来喜欢的小白鼠产生害怕。开始时，每当他伸手玩弄他所喜爱的白鼠时，就在他背后敲击响器发出巨大声响，使之受到惊吓，这

样经过反复强化后，每当白鼠一出现，就受惊吓而产生恐惧，再经过泛化后，孩子对白色有毛的动物也产生恐惧反应。

（二）精神分析学派的观点

精神分析学的创立者弗洛伊德（S.Freud）把人的心理活动分为意识、潜意识、前意识三个层次。意识即我们平时可以感受到的心理活动，但这只是心理活动极小的一部分，犹如“浮在海面上的冰山一角”；我们的心理活动更大一部分属于潜意识范畴，充满了整个心理发育过程，尤其是幼儿期没有得到满足的、因违反社会道德而受到压抑的经历欲望与动机，他们不能直接地或原封不动地进入意识，因为会违背社会规范、良心、道德等而使个体感到痛苦；潜意识与意识之间为前意识，是控制潜意识内容进入意识的守门员。潜意识的内容只有经过改头换面，在前意识防御功能减弱的情况下宣泄出来。然后弗洛伊德又把人格分为本我、自我和超我三个部分。本我是人格的基础，是各种本能活动的中心，包括各种欲望与冲动，不受理性的约束，按快乐原则行事；自我是人格的执行者，是人和客观现实相互作用的产物，其作用是控制精神能量适度地消耗与释放，直到外界现实具备满足本我的条件为止，因此自我是按现实原则行事；超我是人格的监督者，由自我理想与良心两部分组成，它代表的是道义而不是现实，追求的是完美而不是快乐。所以超我按道德原则行事。一般情况下，本我为心理活动提供必要的精神动力；超我则对个体的行为进行监控，使之不违反社会规则；自我则在超我与本我之间协调，使个体本我的冲动能在符合超我的规范下尽可能得到实现与满足。当本我的冲动与超我发生冲突时，自我如果不能运用理性的机制来调节他们

的冲突以及缓解冲突引起的焦虑，就不得不采用一些心理防御机制来应对，如压抑、投射、反向形成、固着等。当自我力量不足以抵御或缓解这些焦虑时，就会产生神经症性的冲突。由于本我要寻求表现的本能冲动处于潜意识领域，自我就很难意识到其冲突的真正对象，因此就体验到莫名的恐惧、焦虑。所以，焦虑被精神分析理论认为是神经症最基本的核心症状。当焦虑转换为躯体症状时，则表现为癔症的转换性症状；焦虑被分离出意识时，则表现为癔症的分离性症状；被转为外部世界的对象时，则表现为恐惧症；被隔离开时，则表现为强迫症；如果被直接体验，则表现为焦虑症。社交恐怖发生机制可表现为：①退行性防御机制。诱发因素使人的心理结构退行到症结产生期，将童年产生的“滞留现象”释放出来，表现为见人恐怖。②投射机制。对人恐怖症病人害怕与异性对视，这是对童年性行为过分自责，感到“内心有鬼”，通过眼神投射出来的结果，此结果与资料报告相符。③自我实现的预言机制。病人愈是害怕什么，偏就出现什么，预言似乎很灵验，这样自我约束信条就变成了发病后的“事实”。④条件反射机制。病人由于反复出现怕见人，激活了记载着对性矛盾和害怕的记忆神经，产生了见人恐怖的条件反射。

精神分析学派还认为，恐惧症的产生与童年期的性经历有关。东方文化中所宣扬的“礼义廉耻”和传统的道德观念，使得中国人非常重视羞耻感的培养。尤其是“性”，被中国人所不齿，“性”是不能拿到桌面上来公开谈论的事情，数千年来“性”一直被传统文化所摒弃，不登大雅之堂，从而造成了性的神秘感和羞耻感。这种强烈的性羞耻感，是性心理冲突的社会

心理基础。东方人的性神秘感、性道德观、贞操观等使人从童年就滋生了对性的羞耻心，并随年龄增长而逐渐增强，到青春期更是达到了强烈的程度。很多的患者最初发病都是处于青春期的性意识萌动阶段就可以证明这一点。由于这些患者对童年期的性经历进行了不恰当的评价，加上青春期的特殊阶段使得患者的性生理、性心理有了显著的变化，有关性道德、性罪错的知识逐渐增多，儿童式性的性经历一旦浮现，患者就以近似成人的性道德规范去审视。由于对性知识、性道德缺乏全面、正确的理解，审视往往演变成自我否定和自我谴责，形成性心理发育的压抑力量。对性欲望全面否定，不可避免地正常萌动的性意识发生剧烈冲突，从而就会出现各种各样的社交恐怖症状。

（三）认知学派的观点

社交恐怖症的认知假说包括过度警觉假说和回避假说。社交恐怖患者在社交前后都运用偏差的认知加工方式，更注意社交表现的负性信息，并运用其对当前与未来的社交表现进行评估和预测。社交恐怖的认知模式认为认知歪曲和对来自他人负性评价的恐惧导致的对恐惧的人际关系的首选注意。这些恐惧可以说明临床上通常说的警觉过度和眼神回避。关于社交恐怖面部表情的加工异常的眼动证据的研究首次提供了关于恐怖相关的加工过程的客观依据。可以预测社交恐怖中过度警觉和眼神回避是最明显的对恐惧的公开表示。一种红外角膜波技术被用于记录视觉扫描途径，与正常的面部表情相比来显示对高兴、悲伤、愤怒的反映。社交恐怖的被试显示了眼睛的过扫描（扫描路径的增长）和回避（固定点注视的减少），在愤怒面孔时更

加显著。这一结果不能用药物疗法和伴发抑郁来解释。这些结果与强调信息加工的偏移在社交恐怖中的作用的理论是一致的，为其在治疗评价方面的应用带来希望。随着心理咨询和社交指导的推广，认知行为学说得到了发展。有些学者认为社交恐怖主要是缺乏社交技巧和能力的培养锻炼。缺乏社交技巧给别人造成不好的印象，引起别人不好的反应，导致尴尬的处境。同时，本人觉察到了自己的社交笨拙也容易造成紧张害怕。

另一些学者强调认知的作用。他们认为，有社交恐怖的病人的社交行为在客观上完全可以是恰当的，但病人对自己的评价不恰当。在社交过程中，病人的自我贬低起着重要作用。不少病人本来就是缺乏自信和倾向于自卑的人。还有一些病人对自己要求过高，恨不能以自己超群的口才和举止得到所有人的称赞与喜欢，这就不可避免反复造成自我挫败，终于见人就紧张害怕。当然，许多学者把社交技巧和自我评价结合起来，强调认知和行为的互相作用。

Leary (1983) 认为，已有的学说都有助于理解社交恐怖症，但没有一个学说能够完全解释已知的各种病前情况（先驱和诱发事件）以及病后的表现。Leary 的学说叫做自我推荐学说。学说的要点是，社交必有动机。通俗地说，一个人只有当他希望在别人心目中造成某种特殊的印象，才可能会感到紧张不安甚至恐怖。假如不论别人对我有什么看法，我一概毫不在乎，我就不会紧张害怕。可见，决定所有社交恐怖的共同因素是动机，即想在别人心目中留下良好印象的动机。决定动机的因素有两个：一个是处境，另一个是人格。

先说处境。举例说，想和异性交朋友或谈恋爱，对方愈是

貌美或有才华，动机就愈强烈，也应愈容易紧张不安。又例如，参加就业面试，如果竞争的人多，挑选的标准很严格，我们就容易感到紧张不安。又如，将要会见的人大权在握，接见将对自己的一生起关键性的作用，见面时也容易紧张。一般的说，第一次与人见面容易紧张，因为我们都懂得给人留下的第一印象特别重要。可见，就诱因或先驱事件说，往往是依着特定动机的某种处境。当然有例外，即事先并无特殊的和明确的目的，但偶然发生的尴尬处境使病人想得到别人好印象的动机受挫，也可以成为诱发事件。

再说决定动机的另外一面，即一个人的人格特性。如果一个人倾向于控制别人对他的印象，或者，特别爱面子，似乎所有的人都喜欢他这才有面子，或者完美主义倾向强烈，恨不得在别人面前表现得完美无缺，那么，这种人便容易患社交恐怖症。

这些年随着认知心理学在中国的传播，越来越多的医生意识到认知—情感—躯体是互相作用的，而且往往是认知决定情感，情感决定躯体症状。为什么一个人见了人会吓得发抖，一个人却特立独行？最关键的差别就是他们对事物的看法不同。比如乙认为甲是个大人物，对自己很重要，他见了甲自然会紧张，丙认为甲对自己没有太大影响，见了甲自然就不会紧张。有些医生认为所有的社交恐怖患者都有一些共同的认知偏差，使社交恐怖似乎可以分成若干种类型。常见的引起社交恐怖的认知偏差大概有以下几种。

(1) 我的个人价值取决于别人对我的看法，我应该让每一个人对我满意，赞美我。有一个病人要求自己见了每一个人都

要有“灿烂的微笑”，否则就是不适应社会，后来越微笑就越不满意自己，越不满意就越刻意练习微笑，最后终于发展为怀疑他人议论自己表情不好，不敢见人了。大家的价值观都不相同，试图讨好每一个人的结果就是疲于奔命，最后可能发展为社交恐怖症。顺便说一句，社交恐怖症患者往往从事社交工作，这是一件很有意思的事情。

(2) 人与人之间的关系都是相互利用的关系。如果一个人试图讨好所有的人，那他必定没有自己的人生观、世界观，也没有自己做人的原则。这样就很可能把人际关系解释为互相利用的关系，很少有诚信可言。这样为人处世可能给人留下不好的印象，觉得患者是一个口是心非的人。周围有些人可能用“以其人之道，还治其人之身”的办法来对付患者，这样一来患者可能觉得世界上的人都是在互相利用，都没有自己做人的原则，这就构成了一个恶性循环。一个在人际交往上缺乏安全感的人是很容易出现社交恐怖的。

(3) 大家都要伤害我。有这种看法的人可能是在童年受到过很大的伤害，对人有敌意，周围的人察觉到这种敌意后也可能用类似的方式对付患者，这样患者的“大家都要伤害我”的信念就会一直持续下去，对周围的人有敌意和戒心，最后可能发展为社交恐怖。

(4) 社交就是礼仪。其实社交的内容是交流思想和感情，患者却往往把社交当成了形式，专门研究自己的表情、姿态，对社交的内容并不放在心上。有的医生建议患者每天找若干人练习说话，结果患者最后找了若干人练习表情、语音、语调去了，越练习问题越严重。笔者对这类行为矫正的看法是：社交

是否有实际的内容？如果没有，那就不必搞什么形式主义了。保险公司评估业绩就不是看语音语调，而是看卖了多少保险。

(5) 任意推断。由于敌意或者隔膜，患者往往缺乏同他人的沟通，不了解他人的想法，好猜疑，常常主观推断他人的想法。比如患者自己觉得没有控制好表情，就因此推断大家都在议论他，这也是导致社交恐怖的重要因素。

以上 5 种是常见的认知偏差，除了这 5 种，还有一些，比如有些很自恋的人认为自己无所不能，对社交的期望很高，达不到要求可能出现社交恐怖；一些性压抑的人规定自己看人只能看特定的部位，看别的部位就“不道德”，最后因为管不好自己的眼睛而不敢见人，等等，这里就不一一列举了。

如果不纠正认知偏差，只是在情感和躯体症状上下工夫，效果自然是有限的了，所以现在有人治疗社交恐怖症提倡注意纠正不合理认知偏差。社交恐怖症患者的价值观是一种“小学生价值观”，只注意他人对自己的评价，不会自己评价自己，须培养自己独有而又能与他人共享的价值观。对于那些对人有明显敌意或者喜欢利用别人的患者须重新培养人际交往模式，先从医患关系做起，再慢慢扩大。对于认为社交就是礼仪的可以提倡关注工作的业绩，用森田疗法治疗。对于任意推断的可以培养沟通技巧，学会批判自己的任意推断思维。

随着时代的发展，社交恐怖的症状也发生了变化。中村报告，1996 年东京慈惠会医科大学第三医院精神科对初诊为对人恐怖症的 63 例病人（男 46 女 17）症状的出现频度进行了总结，其中，对人紧张 73%，他人视线恐怖 36.5%，自己视线恐怖 20.6%，表情恐怖 9.5%，赤面恐怖 7.9%，自己臭恐怖 7.9%。

与 1975 年近藤的调查相比，症状统计有很大的差异。近藤的调查中，对人紧张 38%，视线恐怖 23.8%，赤面恐怖 17.5%。并且当时对人紧张及视线恐怖的症状比较笼统，而现在症状分化很明确，对人紧张和视线恐怖明显地增加，而赤面恐怖在明显地减少。对人恐怖还和其他症状共存，与抑郁、无动机等共患率为 42.9%，并发 3 个月以上闭门不出的有 31.7%，传统的对人恐怖症主要是主观的焦虑、赤面恐怖等特异的症状，而现在发展为被动无力的形式，以回避、闭门不出为主要特征的对人恐怖症的病例在逐渐增加。中国患者主诉自己不如别人并感到自卑，手脚发抖，身体震颤多见，及由于“文革”年代性的压抑，异性恐怖、色目恐怖多见。

可见，社交恐怖的发生除了生理因素外，与心理因素、社会文化环境及时代因素密切相关。我国有关社交恐怖的生理、心理机制的研究尚未取得实质性的进展。尤其是 20 世纪 90 年代出生的青少年正处于发病高峰期，这一代人的社会文化环境与以前相比，发生了巨大的变化。研究新时代青少年的社交恐怖症状特征，主要诱发因素有何特点，对社交恐怖的预防与治疗有指导性意义。

第 5 章

社交恐怖症的诊断

焦虑是一种正常的、普遍存在的人类体验。在社交场合带有一定水平的焦虑对个体保持正常功能是必需的，但过分严重的焦虑干扰了正常功能时则成为一种心理病态。

社交恐怖症大多起病于青少年时期（13~19岁），在这个社交、教育与职业发展的阶段，由于害怕和回避社交，工作、学习能力与社交生活能力下降。主要表现为：①害怕被人注视与评价；②认为别人能看出他不自然的表情与窘态；③预计别人对他的评价是否定或蔑视的；④对害怕的场合回避或痛苦忍受；⑤在害怕的场合常伴有脸红、手抖、恶心或尿频等躯体症状。

症状轻微时只是在与人接触交往时表现腼腆、害羞、不自然和紧张，不能充分发挥应有的交际能力。

某些病人在人多的场合便焦虑不安，尽量躲在不显眼的地方，严重者则回避这类场合。

他们害怕被人注视，有人注视则焦虑不安，甚至脸红、出汗等，因而出门总是低头行走或避免可能被人注视的场合。

虽然与亲人、好朋友相处时正常，一旦与陌生人接触交谈

便紧张、焦虑不安；有些病人表现恰相反，在完全陌生的人中间并不紧张，但与认识或有过接触的人相处便特别焦虑不安，尤其害怕与权威人士晤谈，若不得已谈一次话后便内衣可完全湿透，当时焦虑难忍，表现极不自然，甚至张口结舌，手发颤，心悸等。

这些病人常常害怕与人目光对视，害怕自己会用所谓余光看人。即使向病人解释我们看东西总有一定范围即视野，不可能使目光像激光一样集中于某一点，病人也懂此道理，但仍害怕余光看人。

有些人的害怕有些离奇，他（她）感到别人的目光“特别凶恶”，“寒气逼人”，使他（她）特别恐惧；另有一些人则认为自己的目光会伤害别人，因而不敢看人。

有些病人可以在人多的地方停留或行动，但害怕一对一地与人相处，极力回避；还有的病人不害怕一对一的交往，但只要有第三者在场便紧张焦虑得无法忍受。

某些病人不敢坐在教室前排，后面有同学便如芒刺在背，所以总坐在最后一排。这种人有人在旁边就不能阅读写字，故不敢去图书馆，也不敢在教室里自习。有些病人甚至不能在公共厕所里小便，有人在旁边就排不出尿。

总之，表现是各式各样的，但共同的特点是：病人知道不应该，不必要，没道理，可就是控制不住自己。少数病人有敏感的观念，如常认为有人在议论他，但自己并未听清别人说些什么，也认为不大可能，但控制不住要这样想，并因此而紧张焦虑不安。

社交恐怖症的诊断比较简单，一般当患者在社交场合下出

现明显的紧张、焦虑或回避行为时便可诊断。现有的诊断标准有国际通用的美国的 DSM-IV 和国际疾病诊断分类 ICD-10 中列出的较详细的社交恐惧诊断标准及我国的 CCMD-3 的诊断标准，现介绍如下。

DSM-IV 和 ICD-10 诊断标准

DSM-IV 是指美国精神病学会制定的《精神障碍诊断和统计手册》的第 4 版，它于 1994 年出版。ICD-10 是指世界卫生组织制定的《国际疾病分类》第 10 版。二者对于社交恐怖症的诊断标准如下表所示。

DSM-IV	ICD-10
A. 对一种或多种社交或表演场合（如与陌生人接触或可能被他人注目）的明显和持久性害怕，担心自己举止窘迫或做出令人难堪的事情（或表现出焦虑症状）。 注：如为儿童，可能是与所熟悉的、年龄相仿的人交往过程中发生问题，或在同伴中出现焦虑，而不是与成人的交往问题。 B. 在害怕的社交场合下，几乎不可避免地会产生紧张焦虑，因此有环境限制或境遇性诱发惊恐发作。 注：如为儿童，此焦虑可能表现为哭闹、发脾气、发呆，或从有不熟悉的人群场合中退出来。	1. 害怕在小团体中被人注视，通常导致回避社交场合。 2. 一般伴有害怕批评和自尊心受到损伤。 3. 有脸红、发抖、恶心、尿急、尿频的症状。同时这些症状可能会发展成惊恐发作。

DSM-IV	ICD-10
C. 自己认识到这种害怕是过分的或没有道理的。 注：如为儿童则无此项。 D. 回避害怕的社交或表演性场合，或者是在这种场合下须忍受极度的焦虑或痛苦。 E. 这种对害怕的社交或表演场合所出现的回避、提心吊胆或苦恼，明显地干扰了个人的日常生活规律、工作（或学业）、社交活动或人际关系，或者是对这种恐怖表现感到明显的苦恼。 F. 小于 18 岁者，必须至少有 6 个月病程。 G. 这种害怕或回避不是由于某种物质（如药物滥用或药品）或躯体疾病所致的直接生理效应，也不可能归于其他精神障碍（如：伴有或不伴有广场恐怖的惊恐障碍、分离性焦虑障碍、躯体变形障碍、某种广泛性发育障碍，或分裂样人格障碍）。 H. 除外因为某种躯体疾病或其他精神障碍所伴发的 A 项症状。例如除外因为口吃、帕金森氏震颤，或精神性厌食或贪食等异常进食行为而出现的害怕。 泛化型（generalized）：如果害怕的场合涉及绝大多数的社交场合，则要考虑为泛化型，同时要考虑附加上回避性人格障碍的诊断。	4. 对害怕的场合回避或强忍恐惧。通常回避是非常明显的，可能会引起完全与社会隔离的后果。 5. 焦虑必须是局限于或主要发生在特定的社交场合。 6. 当社交焦虑障碍和广场恐怖难以鉴别时通常优先诊断广场恐怖。惊恐障碍应该只能在恐怖症中诊断。 7. 可以是独立的（害怕在公共场合进食，害怕与异性接触或在公共场合发言）或是泛化的（几乎所有的社交场合）。

DSM-IV 与 ICD-10 的诊断标准有助于定义正常害羞与社交焦虑障碍两者之间的划界及社交焦虑障碍与其他疾病的鉴别。两个诊断系统中社交焦虑障碍的基本特征是患者害怕被众人注视或评价，认为别人能看出他的不自然表情或窘态，预计别人对他的评价是否定的或蔑视的。

两个诊断系统的不同点有：①对有大量听众（众人面前）的公开讲话的恐怖在 DSM-IV 属于社交焦虑障碍，而在 ICD-10 不属于恐怖情境，特指在小团体中害怕被注视；②DSM-IV 特别指出患者因职业或学业功能受损而有社会经济负担；③ICD-10 列出了躯体症状可为主诉。

Wacker 等（1992）采用两个诊断系统对 470 名成人的调查发现，社交焦虑障碍的终生患病率按 DSM-III-R 系统为（16.0%），ICD-10 系统为（9.5%），后者标准严格一些。但两个系统都强调社交焦虑障碍与正常害羞的区别是痛苦体验的强度和认识到害怕是过分且无理由的。

■ CCMD-3 有关社交恐怖的诊断标准 ■

CCMD-3 是《中国精神障碍分类与诊断标准》第 3 版的简称。其中关于社交恐惧症（社会焦虑恐惧症）诊断标准为：

（1）符合恐惧症的诊断标准；

（2）害怕对象主要为社交场合（如在公共场合进食或说话、聚会、开会，或怕自己做出一些难堪的行为等）和人际接触（如怕在公共场合与人接触、怕与他人目光对视，或怕在与人群相对时被人审视等）；

(3) 常伴有自我评价低和害怕批评;

(4) 排除其他恐惧障碍。

社交恐惧常起始于青少年期,核心症状是围绕着害怕在小团体中被人审视,导致对社交情境的回避。主要表现为对单一情境(如在公共场合进食、公开讲话或遇到异性等),或者泛化的(家庭圈子以外的)对几乎所有社交情境感到恐惧。病人通常伴有自我评价过低和害怕批评,可有脸红、手抖、恶心或尿急的主诉。恐惧症状可发展到惊恐发作。回避往往十分明显,在极端的情况下,可导致完全的社会隔离。诊断时必须注意心理、行为或自主神经症状是原发性焦虑所致,而不是继发于妄想或强迫症状等。焦虑必须局限于特定的社交场合,对恐惧情境的回避必须是突出特征。如果社交恐惧与场所恐惧的鉴别十分困难,场所恐惧应予优先考虑。须注意,惊恐发作作为继发症状,可见于多种不同的精神障碍,如恐惧症、抑郁症等。处于惊恐发作中的场所恐惧症病人,常体验到害怕和自主神经症状的不断加重,致使病人十分急切地离开所在的场所。如果这种情况发生在特定情境,例如在公共汽车上或置身人群中,病人以后可能回避这些情境。同样,频繁和不可预测的惊恐发作可导致害怕独处或害怕进入公共场所。一次惊恐发作常继之以持续性地害怕再次发作。尽管如此,发生在确定情境的惊恐发作被认为是恐惧症的严重表现,因此应优先考虑恐惧症的诊断。诊断惊恐障碍,要注意发作出现在没有客观危险的环境,并非局限于已知的或可预测的情境,尽管预期性焦虑常见,但发作间歇期基本没有焦虑症状。确诊惊恐障碍发作时应符合病程标准,即在 1 个月中,至少有几次发作。总之,如果惊恐发作仅

仅是恐惧症的症状或继发于抑郁症，此时如果已经符合恐惧症或抑郁症的诊断标准，不应把惊恐障碍作为主要诊断。

社交恐怖症的鉴别诊断

流行病学的研究显示，社区中的社交恐怖症患者仅有小部分（大约 5%）的患者为他们的状况寻求医生帮助，在美国推算有 240 万的患者没有接受任何治疗。Weiller 等（1996）在巴黎的社区一般医疗机构访谈了 2000 名连续就诊的患者，发现 5% 的患者被诊断现患社交恐怖症，在这部分患者中，仅 24% 被医生给予恐怖症的诊断。仅有 5% 的社交恐怖症患者以心理问题求助于医生，大量患者失去了诊治的机会。

妨碍患者就医的因素有：①缺乏信息，大众及医务人员不知道社交焦虑障碍是一种可治疗的障碍。②患者认为只是害羞或是性格问题。③因为每个人均在社交或职业场合体验过一定程度的焦虑，社交焦虑障碍患者的家人、朋友，甚至医生都认为只是一般化问题。④对精神疾病的羞辱感。⑤患者本身回避接触陌生人而不去看医生。

如何在病人中识别社交恐怖症：①对非常害羞和拘谨的患者要注意有无社交恐怖症。②在酒精滥用者和有抑郁症状的病人中也要注意有无社交恐怖症，因为二者往往同病。③对有焦虑发作的病人，应确定是否主要在社交场合发生。

社交恐怖与广场恐怖及惊恐发作的鉴别诊断：①与广场恐怖难以鉴别时，优先诊断广场恐怖。②惊恐障碍的诱发情境在患者之间是明显不同的，而且惊恐障碍可在任何情境下发作，

但社交恐怖症患者的惊恐发作只在社交或职业场合发生。③与回避性人格障碍存在较大重叠，有时难以鉴别。

评定社交恐怖症已有一些专用量表。他评量表有：①Liebowitz 社交焦虑量表（Liebowitz Social Anxiety Scale）。②社交回避与苦恼量表（Social Avoidance and Distress Scale）。

自评量表有：①害怕负性评价量表（Fear Negative Evaluation Scale）。②害怕问卷（Fear Questionnaire）。③杜克简便社交恐怖量表（Duke Brief Social Phobia Scale）。④社交恐怖和焦虑问卷（Social Phobia and Anxiety Inventory）。

附：社交恐怖症自我测试

你是否患有社交恐怖症，得由精神科医生来进行判定，一般可用以下的专业测试表来进行测试得知：

1. 我怕在重要人物面前讲话。	答：（1 2 3 4）
2. 在人面前脸红我很难受。	答：（1 2 3 4）
3. 聚会及一些社交活动让我害怕。	答：（1 2 3 4）
4. 我常回避和我不认识的人进行交谈。	答：（1 2 3 4）
5. 让别人议论是我不愿的事情。	答：（1 2 3 4）
6. 我回避任何以我为中心的事情。	答：（1 2 3 4）
7. 我害怕当众讲话。	答：（1 2 3 4）
8. 我不能在别人注目下做事。	答：（1 2 3 4）
9. 看见陌生人我就不由自主地发抖、心慌。	答：（1 2 3 4）
10. 我梦见和别人交谈时出丑的窘样。	答：（1 2 3 4）

记分方法：

每个问题有 4 个答案可以选择，它们分别代表：1.从不或很少如此；2.有时如此；3.经常如此；4.总是如此。根据你的情况在上表中圈出相应的答案，此数字也是你每题所得的分数。将分数累加，便是你的最后得分了。

10 分：放心好了，你没患社交恐惧症。10 ~ 24 分：你已经有了轻度症状，照此发展下去可能会不妙。25 ~ 35 分：你已经处在社交恐怖症中度患者的边缘，如有时间一定要到医院求助精神科医生。36 ~ 40 分：很不幸，你已经是名严重的社交恐惧症患者了，快去求助心理医生，他会帮你摆脱困境的。

第 6 章

社交恐怖症的治疗

如果对社交恐怖不治疗的话，往往会有下列一些不利的后果：患者学业成绩差，工作和社会交往能力受限，经济独立能力没有，过多的医疗检查等费用支出；部分患者会以饮酒、吸烟等来自我调整，发生抑郁、广场恐怖症和自杀的危险性增加。因此，社交恐怖需要及时的诊治。目前，主要以药物治疗和心理治疗为主。

药物治疗

美国 ECA 调查显示，社交恐怖症患者在过去的一年中，有 22% 的人用过催眠药，23% 用过镇静药，10% 用过抗抑郁药。目前有研究证实治疗社交恐怖症有效的药物有 4 类：单胺氧化酶抑制剂（MAOI）和 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）、苯二氮草类、 β 受体阻滞药。

1. 单胺氧化酶抑制剂（MAOIs） MAOIs 是通过抑制中枢

神经系统单胺类神经递质的氧化代谢而提高神经元突触间隙浓度，单胺氧化酶有 MAO-A 和 MAO-B 两个亚型。临床上 MAOIs 主要是治疗社交恐怖症患者的人际高度敏感，以及伴有的非典型抑郁、癔症性焦虑和回避性人格表现。早先将苯乙肼 (Phenelzine) 作为社交恐怖的“标准治疗”，有效率为 64%~91%。但苯乙肼属于不可逆性 MAOI，在使用过程中对患者的饮食限制较多，且副反应发生率较高（如性欲减退、早泄、眩晕、失眠、便秘、尿潴留、高血压危象等），故目前已少用于临床。吗氯贝胺 (Moclobemide) 是一种短效的、可逆性、选择性作用于 A 型 MAO 的新型 MAOI，饮食限制较少，不良反应明显减少，对社交恐怖症的有效率为 82%。吗氯贝胺的副作用主要有恶心，其次为口干、便秘、头痛、眩晕、失眠、体位性低血压等。吗氯贝胺是 MAOIs 中的代表药物。

2. 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs) SSRIs 是新一代抗焦虑、抑郁药，临床药理作用主要是选择性抑制神经元回收 5-HT，使突触间隙 5-HT 含量升高而达到治疗目的，而对其他神经递质和受体没有明显影响。目前，帕罗西汀 (Paroxetine, 商品名：赛乐特) 是被 FDA 批准用于治疗社交恐怖症的 SSRIs 药物。目前全世界至少有五千万人服用帕罗西汀治疗精神疾患。在美国进行了一项 183 例社交恐怖症患者参加的临床试验，这些患者分成两组，一组服用帕罗西汀，另一组服用安慰剂。服药剂量为 20~50mg/d，疗程 12 周。试验结果表明：帕罗西汀组症状改善或显著改善率为 22.9%，而安慰剂组只达到 5%。说明帕罗西汀治疗社交焦虑症确实有很好的疗效。近期一项在英国进行的研究表明，每日分别给予 20、40、60mg 的帕

罗西汀治疗社交恐怖症，结果显示，20mg/d 是最适合的剂量。这一方面表明了帕罗西汀的有效性，另一方面，由于剂量低，减低了不良反应的发生率，也降低了患者的用药费用。目前认为帕罗西汀在治疗社交焦虑障碍 11 周后可使患者的临床症状显著减轻。

目前在临床上应用的 SSRI 除了帕罗西汀外还有氟西汀 (Floxetine)、舍曲林 (Sertraline)、氟伏沙明 (Fluvoxamine)、西酞普兰 (Citalopram)。这些药物的共同特点是：疗效确实，与三环类相当；副作用少，较少或没有抗胆碱能副作用，对心脏没有明显毒性；耐受性好，安全性高，使用简便。

3. 苯二氮䓬类药物 (BDZ) 苯二氮䓬类药物具有明确的抗焦虑作用，且安全性高，主要通过加强 γ -氨基丁酸 (GABA) 的功能发挥作用。该类药物用于社交恐怖症治疗的主要是阿普唑仑和氯硝西泮。氯硝西泮是目前临床上最常用的苯二氮䓬类药物，较常见的副反应为性高潮缺失、站立不稳、健忘和注意力不集中等。此类药物长期使用可产生依赖性和耐受性。

4. β 受体阻滞剂 β 受体阻滞剂主要用于解除焦虑障碍的各种躯体性症状，在治疗表演性焦虑方面优于安慰剂。它主要是减轻焦虑的生理症状，如心动过速、战抖、口干、出汗、面红耳赤等，但不能减轻患者的心理症状（如认知性焦虑）。临床上常用一次性大剂量顿服来减轻音乐家的“舞台恐惧”和运动员的比赛恐惧。代表性的药物为普萘洛尔 (Propranolol, 又名：心得安)，其他还有阿替洛尔 (Atenolol)、纳多洛尔 (Nadolol) 等。

社会-心理治疗

社会-心理治疗包括有意识地提高社交技能，暴露疗法，认知疗法以及森田疗法。

1. 暴露疗法 暴露疗法就是“恶治”：把患者放进他害怕的社交场合，开始他会感到极度紧张不安，然后通过放松法让患者逐渐放松，反复数次，直到患者逐渐适应令其紧张害怕的环境。

2. 认知疗法 认知疗法的出发点是改变患者不正确的认识，如在与他人谈话时，社交恐怖症的患者会因紧张不知该说些什么，此时患者会认为是自己的过错而导致社交的失败，由此更加感到紧张不安。认知疗法就是要改变这种想法，引导患者从另一个方面考虑问题，比如把过错推给对方，“为什么是我的过错？是因为你说话跑了题！”这样，患者的紧张情绪会自然得到缓解。

目前常用的主要有认知行为集体治疗（cognitive behavioral group therapy, CBGT）与社交技能训练（social effectiveness training, SET）。两者都包括对恐怖情境的暴露和脱敏，但CBGT 着重于纠正错误认知，SET 利用社交技能训练应付恐怖情境。研究证实两者均比心理安慰剂有效，与药物治疗相比，起效较晚，但疗效持久。

认知行为集体治疗最早是由美国 Heimberg 等于上世纪 80 年代中期应用于临床，经 20 年的实践被证明是行之有效的治疗方法。其中有社交技巧训练、逐步暴露、放松训练、认知转变，以及一系列的认知行为技术等心理社会治疗方法对社交恐怖有

较好的疗效，临床上常用认知-行为小组治疗（CBGT）和社会技巧训练（SET）。但许多临床医师认为：小组形式的认知和行为技术的应用或许是治疗社交恐怖的最佳系列的社会干预方法。因为许多社交恐怖患者在社交场合下会产生认知障碍，如过高估计了他人会对自己的挑剔、过分地关注他人的看法、低估自己的交往能力，以及害怕出现焦虑反应等。根据 Heimberg 和 Juster 的工作，社交恐怖患者的认知行为集体治疗（CBGT）较教育支持性集体心理治疗（ES）效果好：治疗 12 周，CBGT 组 75%改善，ES 组 40%改善；随访 6 个月，CBGT 组 81%改善，ES 组 47%；长期随访（4.5~6.25 年，平均 5.5 年），CBGT 组 89%改善，ES 组 44%改善。CBGT 的基本方案为：6 个患者组成一组，每周治疗性会面一次，每次 2.5 小时，共治疗 12 周次为全部疗程。

社交技巧训练是假设社交恐怖患者缺乏交往技巧而表现出回避或情绪焦虑，因此，侧重交往技巧的训练，找出技巧缺乏的靶行为，然后示范、强化演练及反馈等行为治疗措施会有助于患者症状的改善。这一方法可以中等程度地减轻患者的社交性焦虑表现，机理可能与暴露治疗相似。

上海市精神卫生中心张新凯、吴文源等从事社交恐怖的认知行为集体治疗，结果表明，认知行为集体治疗对社交恐怖症有很好的治疗效果，但也有患者的治疗效果不尽如人意。进一步分析治疗效果的影响因素发现，有社交恐怖家族史的患者可能更多为性格内向者，往往有严重羞耻感特性，也往往发病较早，病程较长，焦虑的躯体症状显著，共病情况高和有较明显的类关系妄想症。

性格内向的患者治疗效果也较性格外向者差；发病年龄早、病程长和同病情况较多的患者的治疗效果较之发病年龄晚、病程短和同病情况较少的患者差。这些与社交恐怖的不同分型有关。文献报道，社交恐怖普通型患者较多伴有回避型人格障碍，共病率高和自杀企图多，社交能力、职业功能受损的程度更显著；非普通型患者较少伴有回避型人格障碍，共病率低和自杀企图少。

疾病因素中，敏感性关系妄想是影响 CBGT 效果最显著的因素之一。尽管社交恐怖患者接受 CBGT 治疗的不良影响也从另一个侧面说明，敏感性关系妄想很可能是社交焦虑障碍患者的一个重要的病理性精神症状。在诸多心理-社会因素中，一些因素显然相互关联且与患者的疾病分型有关，如普通型患者中单身较多、无业或失业 / 休学较多、教育程度偏低、社会经济地位低、社会支持不足等，更多的可能是患者疾病的结果而不是原因。

患者对治疗的合作程度是影响 CBGT 效果很重要的因素之一。行为训练是在认知基础上把良好的认知和正确的行为学习和巩固下来的重要治疗方法，也是 CBGT 行之有效的关键所在。因此，患者严格执行治疗进程和治疗要求、按质按量完成作业是良好行为获得治疗效果的重要因素之一。另外，有物质滥用的患者治疗效果也比无物质滥用者差。国外患者物质滥用主要有毒品或酒精。

3. 森田疗法 森田疗法是日本治疗对人恐怖症最有效的心理疗法。其精髓“顺其自然，为所当为”符合东方文化思想，容易为中国及亚洲地区人所理解。1982 年，韩国的李时炯运用

集团森田疗法治疗对人恐怖症，1982～1985 年到韩国总医院接受治疗的对人恐怖症患者达 315 名，获得了良好的效果。台湾大学简锦标也在积极推广集团森田疗法，并组织了“生活调试爱心会”，2006 年组团来大陆参加了第六届中国森田疗法学术大会。国内也有学者报道运用门诊森田疗法治疗社交恐怖取得显著疗效。本书将在后面的部分详细系统地介绍这方面的内容。

第 7 章

社交恐怖症的预防 ——论自卑与超越

社交恐怖症的发生有许多影响因素，如习得性焦虑、遗传因素、父母的过度保护、儿时缺乏适应能力的锻炼、父母的排斥或批评、令人难堪或耻辱的特殊经历、预期性的焦虑、回避等等，但个体差异很大。其中，性格中的自卑是至关重要的；此外，社交恐怖患者几乎都缺乏社交技巧。如果这些患者能够超越自卑，练习一些必要的与人交往的技巧，社交恐怖就可以避免。实际上，生活中自卑的人很多，而许多人并没有患上社交恐怖症，主要原因是他们都不自觉地用各种方法超越了自卑或通过必要的社交技巧使自己能适应社会生活，避免自己掉入社交恐怖的陷阱。下面，我从如何超越自卑和社交技巧两个方面来探讨社交恐怖的预防。

■ 自卑及其形成的条件 ■

自卑，就是自我评价过低，自己瞧不起自己，认为自己不

如人。当人们发现自己在外貌、家庭、能力水平以及自己所属的社会阶层、民族、出生的地域不如他人，就会产生压抑、失望、怀疑自我价值的情绪。自卑常以一种消极防御的形式表现出来，如抑郁、悲观、猜疑、羞怯、孤僻、焦虑紧张、不安等。自卑使人变得十分敏感，经不起任何刺激。一个人由于缺乏成功的经验，缺乏客观的期望和评价，消极的自我暗示又抑制了自信心，加上生理或心理上的缺陷、恶劣的生活境遇等原因导致了自卑心理的产生。这种心理如果任其发展，便会成为人的性格的一部分，难以改变，严重影响人的社会交往，抑制人的能力发展。

自卑对人的心理发展有很大影响。自卑心理可以成为激发人们向上的强大动力，也可能压抑人的潜能，使人消沉、自暴自弃。

心理学家阿德勒认为，人人都有自卑感，只是程度不同而已。因为每个人都有先天的生理或心理欠缺，这就决定了每个人的潜意识中都有自卑感存在。处理得好，会使自己超越自卑去寻求优越感，而处理不好就将演化成各种各样的心理障碍或心理疾病。自卑容易销蚀人的斗志，就像一把潮湿的火柴，再也燃不起兴奋的火花。而长期被自卑笼罩的人，不仅心理活动失去平衡，也会诱发生理失调和病变。社交恐怖症的患者几乎人人都有严重的自卑心理，或者说，自卑是社交恐怖的核心。

人类的自卑应当是无条件的。不过落实到具体的个人，在具体的文化背景和社会环境中，自卑的形成则是有条件的。

自卑的形成的确与环境有关，但这只是构成自卑的一个条件。自卑的最终形成又受到个人因素的调节。这里的个人因素

包括了生理状况、能力、气质、性格、价值取向、思维方式等。

首先，生理状况与能力水平是能否建立自信的基础。优者、强者肯定与自卑无缘。问题是没有一个人能在生理、心理、知识、能力乃至生活的所有方面都是一个强者、优秀者。因此从理论上说，自卑在任何人身上都可能产生。

的确，无论是伟人还是普通人，都会在某些方面表现出优势，在另外一些方面表现出劣势，也或多或少会遭受到挫折或得到外部环境的消极反馈。但不是所有劣势或弱项都会带来沉重心理压力，都会导致自卑。例如，一个执著于事业的学者可能因为学术成果少、水平不高，与同事有较大差距而自卑，但决不会因为烹饪不如妻子，打牌不如邻居而自卑。这就是主体内在的价值支点在自卑形成中产生的调节作用。

自卑的形成也与气质、性格有关。气质抑郁、性格内向者大都对事物的感受性强，对事物带来的消极后果有扩散趋向，而且不容易将消极体验及时宣泄和排解。因而环境对他们心理的影响往往要比对其他气质、性格类型者的影响来得大，这类产生自卑心态的可能性也相应增大。

人的一生真正对人产生深刻影响的重要时期就那么几个，其中童年经历的影响尤深。心理科学的研究已证实，不少心理问题都可在早期生活中找到症结，自卑作为一种消极心态也不例外。如，有位女士已人到中年，成家后一直自信不足，时感自卑的困扰，但又找不出确凿理由；后经心理医生分析才找到症结，原来她幼年时因为常尿床，遭姐妹嘲笑、父母打骂和邻居指戳；久而久之，她产生了很深的自卑感并且渗入人格中，在各种场合表现出来，深刻影响了她的自我认识。

弗洛伊德认为，人的童年经历虽然随着时光流逝会淡忘，甚至会在意识层中消失，但将顽强地保存于潜意识中，对人的一生产生持久影响力。

童年经历之所以会深刻而长久地影响人的心理和行为，主要在于人生早期的不成熟性。无论从生理还是心理角度看，儿童处于依附成人的地位，因此外部世界对他们的态度和评价，无论是积极的还是消极的，是准确的还是错误的，都会引起他们相应的反应。如果这种态度是来自父母、老师和其他权威者，情况更是如此。因此，同样的刺激，譬如父母离异、被遗弃、遭歧视等发生在童年要比发生在青壮年带来更严重的后果。这也是为什么根植于童年经历的自卑要比发生在以后的更深、影响更持久的重要原因。

如何超越自卑

负面情绪对人的身心健康和成长发展影响很大，自卑心理更使人缩手缩脚，压制才干，容易把人带入自责、自恨、自缚、自弃的怪圈。要想超越自卑应从以下几个方面着手。

（一）改变认知

首先，我们说自卑是一种自认为不如人的感觉，这就意味着它是一种“自认的感觉”。这种感觉往往是我们拿自己的短处与别人的长处相比较而产生的。事实上，地球上每一个人，从某个特定的方面来看，都有不如别人的地方。

而且，自卑感的产生来自我们对事实的结论和对经验的评价，而不是来自事实或经验。例如：我是个举重不行的人，但

这并不等于说我就是个“不行的人”；张三的举重非常出色，但他没有办法替我搞互联网技术，他是网络技术方面不行的人，但这同样不意味着他是“不行的人”。

其次，自卑感之所以会影响我们的生活，是由于我们有“自己不如别人”的感觉。不如人的感觉产生是由于我们不用自己的尺度来判断自己，而用某些人的标准来衡量自己。我们这样做，当然会带来低人一等的感觉。因为我们想、我们假设、我们相信应该用某些人为标准来使我们自己向他们看齐，因而我们觉得不如人，觉得焦虑，从而得出结论认为我们本身有毛病，然后这个愚昧推理过程的逻辑结论是：我们没有价值，我们不配得到成功与快乐。不管我们自己有多行，只要我们不觉得抱歉和罪过，就没有办法充分表现自己的才能与天赋。“自己不如别人”，那么这个“别人”是谁呢？以哪个人为标准呢？有没有一个通用的“别人”的标准呢？为什么（凭什么）我们应该以别人为标准呢？为什么我们应该像“其他每一个人”呢？实际上，并没有“其他每一个人”的通用的标准，就算有，也不过是某一个人或某一些人的主观想法。况且，“其他每一个人”都是由个人组成的，世界上没有完全相同的两个人（可以从系统哲学的高度来论证）。你身为一个人，不必与别人比较高低，因为地球上没有一个人是和你一样的，也没有人和你是同一等级的。你是一个人，一个独一无二的人，你不像任何一个人，也无法变得像某一个人。而且，实际上也没有谁要你去像某一个人，当然，也没有谁要某一个人来像你。世界上的每一个人都有自己个别独特之处，一个标准的人其实是并不存在的，也没有哪一个人身上贴着“这个才是标准”的标签。所以，要

超越自卑，就不要拿别人的标准来衡量自己，因为你不是那个人，也永远无法用那个人的标准来要求自己。只有在自己身上发现特质、独一性、不同性，相信自己有其独特性，才可以找到内心的安全感，才可以轻易地实现自己。

第三，就算是真的在某方面（甚至是自己的长处和自以为得意的方面）不如别人，那也不必自卑，以至怀疑自己的价值。为什么呢？因为造成“自己不如别人”的原因无非有以下这些：首先，先天遗传因素。生下来就智力高人一等，非常聪明，或生下来就具有某一方面的才能（天赋），如莫扎特、维纳（创立控制论，小时候被誉为神童）等人。其次，优越的家庭环境、客观上的有利条件等。第三，自身的主观的努力，刻苦，勤奋。第四，机遇，偶然性等。

而对于因素一，我们没什么自卑的，因为这种因素不能由我们的主观意志决定。对于因素二，我们多半也无能为力。至于有的人认为可以通过主观努力来改变环境，适应环境，利用环境甚至选择有利于我们的环境，我把它归于主观努力因素。对于因素三，我们可以去努力，对此，我们产生的不应该是自卑的情绪或感觉，而应该是一种激励感才对。至于因素四，则是捉摸不定的，而且有人说：“机遇偏爱有准备的头脑”，那么在某种程度上我们可以把因素四归于因素三。进行了上述如此这般的归因分析之后，我们可以得出结论：没必要自卑，别人之所以比我优秀，或者是由于我们无法决定的原因（如遗传、机遇等），或者是我们可以决定、可以改变的原因（如主观努力，正确的方法等）。对于前者，我们不必自卑，因为事出有因，且无法为我所控；对于后者，我们不该自卑，因为我们也可以做

到。所以，有句话说得好：“我们应该努力去改变自己能够改变的，而要接受我们不能改变的，并努力寻求知识，以了解它们的区别。”

（二）用补偿心理超越自卑

补偿心理是一种心理适应机制，个体在适应社会的过程中总有一些偏差，以求得到补偿。从心理学上看，这种补偿，其实就是一种“移位”，即为克服自己生理上的缺陷或心理上的自卑，而发展自己其他方面的长处、优势，赶上或超过他人的一种心理适应机制。正是这一心理机制的作用，自卑感就成了许多成功人士成功的动力，成了他们超越自我的“涡轮增压”，而“生理缺陷”愈大的人，他们的自卑感也愈强，寻求补偿的愿望就愈大，成就大业的本钱就愈多。

解放黑奴的美国总统林肯，不仅是私生子，出生微贱，且面貌丑陋，言谈举止缺乏风度，他对自己的这些缺陷十分敏感。为了补偿这些缺陷，他力求从教育方面来汲取力量，拼命自修以克服早期的知识贫乏和孤陋寡闻。他在烛光、灯光、水光前读书，尽管眼眶越陷越深，但知识的营养却对自身的缺陷作了全面补偿。他最终摆脱了自卑，并成为有杰出贡献的美国总统。贝多芬从小听觉有缺陷，耳朵全聋后还克服困难写出了优美的《第九交响曲》，他的名言“人啊，你当自助！”成为许多自强不息者的座右铭。

在补偿心理的作用下，自卑感具有使人前进的反弹力。由于自卑，人们会清楚甚至过分地意识到自己的不足，这就促使其努力学习别人的长处，弥补自己的不足，从而使其性格受到磨砺，而坚强的性格正是获取成功的心理基础。

自卑能促使人走向成功。人道主义者威特·波库指出，在每个人的内心深处都有一种灵性，凭借这一灵性，人们得以完成许多丰功伟业。这种灵性是潜在于每个人内心深处的一股力量，即维持个性、对抗外来侵犯的力量。它就是人的“尊严”和“人格”。人们为了维护自己的尊严和人格，就要求自己克服自卑，战胜自我。因此，令人难堪的种种因素往往可以成为发展自己的跳板。一个人的真正价值，取决于能否从自我设置的陷阱里超越出来，而真正能够解救我们的，只有我们自己。即所谓“上帝只帮助那些能够自救的人”。

强者不是天生的，强者也并非没有软弱的时候，强者之所以成为强者，在于他善于战胜自己的软弱。一代球王贝利初到巴西最有名气的桑托斯足球队时，他害怕那些大球星瞧不起自己，竟紧张得一夜未眠。他本是球场上的佼佼者，但却无端地怀疑自己，恐惧他人。后来他设法在球场上忘掉自我，专注踢球，保持一种泰然自若的心态，从此便以锐不可当之势进了一千多个球。球王贝利战胜自卑的过程告诉我们：不要怀疑、贬低自己，只要勇往直前，付诸行动，就一定能走向成功，久而久之，就会从紧张、恐惧、自卑的中解脱出来。因此，不甘自卑，发愤图强，积极补偿，是医治自卑的良药。

心理补偿是一种使人转败为胜的机制，如果运用得当，将有助于人生境界的拓展。“疯狂英语”的创始人李阳就是一个典型的例子。

在北京太庙举行万人英语演说，在上海外滩办起英语互动课堂，在革命老区遵义让成千上万的孩子跟自己一起疯狂呐喊，十多年来，李阳就是这样以自己的方式将“疯狂英语”推广到

全国，甚至闯出国门，在日本、韩国、美国都树立了“疯狂英语”的口碑。对于李阳来说，“疯狂”可以使他成功，然而，你很难想象，李阳曾经是一个自卑、对人恐怖的小男孩，从小就害羞自闭，连电话都不敢接，认为自己的人生一片灰暗，毫无光彩。在大学的前两年，他有多门功课不及格，就连现在他最擅长的英语那时也是连续两年补考。而李阳的童年记忆里，更是有太多的灰暗。

李阳一直说自己曾经是一个很自卑的人，甚至觉得买一瓶酱油如果能够成功地买回来，都是一个非常了不起的成就。他脸上有一道疤，那道疤的来历是一个著名的自卑的故事，也算是“性格自闭”的故事，是他初三时到医院去做理疗，因为特别怕医生，二十多分钟不敢吭声，而被理疗仪器烫的！

李阳曾回忆道：“我从小是在江苏常州出生的，由我姥姥把我带大，到三四岁以后又回到新疆跟父母生活在一起。这样的话肯定跟父母之间不是很亲了，再加上父母那时候好像是知识分子被打成‘臭老九’了，‘文化大革命’的时候，生活也是非常不如意的。那么不如意以后，这些东西都发泄在小孩身上，小孩是个发泄工具，外面有什么不如意，回来以后可能打打骂骂，以为是自己的孩子，打是亲骂是爱。现在是明白这个道理，但是当时那些话我都记得非常非常清楚。比如说‘你个笨蛋’，‘你将来掏大粪去吧’这样的，反正是这之类的一些话。我现在不会恨他们，但是就觉得扭转这种东西很难。怎么说呢？我很羡慕别人家的孩子，他们与父母之间能够相互拥抱，我要拥抱自己的孩子我会起鸡皮疙瘩的。但我强迫自己改变，

不要再传下去了，不要再把那种东西再传到下一代身上。我记得我叫我父亲是叫不出来的，我必须到他前面去，比如从背后我想叫他没法叫，我只有到他前面去，‘哎’，这样子才行。叫‘爸爸’，脸会‘哗’就红掉，当然这些东西，是一种分析了，不会伤害什么人。父母肯定不会希望自己的孩子是这样一个状态，但其实就是这种状态。我曾经上过一些课，心灵的一种课程，想超越一下，也希望跟父母敞开谈一谈，拥抱一下，让情感的闸门打开一下，到目前为止还没有成功。”

“其实包括我们的民族习惯，你发现烙在每个人脸上的烙印，甚至都是拘谨，都是压抑，有点自闭那种。如果大家真正渴望成功，都须打破这样一个牢笼和枷锁。我还发现比如说俞敏洪，他曾经喜欢一个女孩子，但是不敢跟她说话，追踪了她三个月，最后趁一个月黑风高的夜晚，图书馆没有电了，灯灭了，才做了一个动作，帮助这个女孩子拿起书包来，由此才搭上这个线。他称自己是非常自卑的人，但是他现在的成功也是有目共睹的。”

家庭教育在李阳的心灵留下了挥之不去的阴影，他胆小、自卑、不敢说话。长大以后，一个偶然的的机会，他发现大声喊英语可以让自己找到自信，于是他再也没有停止这种疯狂的呼喊。通过不断地自我超越，李阳为成千上万在人生道路上拼搏的人树立了一个榜样。超越自我，直面人生的困境，这几乎成了所有成功者的必经之路。

李阳认为，成功的人总是要先经历一次次的失败，然后才有可能迎来成功。所以他特别强调要有面对挫折的勇气，并且要善于从失败中吸取经验，这样的人才最终成功。

（三）用乐观态度面对失败

在自我补偿的过程中，还须正确面对失败。人生之路，一帆风顺者少，曲折坎坷者多，成功是由无数次失败构成的。正如美国通用电气公司创始人沃特所说：“通向成功的路即把你失败的次数增加一倍。”但失败对人毕竟是一种“负性刺激”，总会使人产生不愉快、沮丧、自卑。那么，如何面对，如何自我解脱，就成为能否战胜自卑、走向自信的关键。

面对挫折和失败，唯有乐观积极的心态，才是正确的选择。其一，做到坚韧不拔，不因挫折而放弃追求；其二，注意调整、降低原先脱离实际的“目标”，及时改变策略；其三，用“局部成功”来激励自己；其四，采用自我心理调适法，提高心理承受能力。

要使自己不成为“经常的失败者”，就要善于挖掘、利用自身的“资源”。虽然有时个体不能改变“环境”的“安排”，但谁也无法剥夺其作为“自我主人”的权利。应该说当今社会已大大增加了这方面的发展机遇，只要敢于尝试，勇于拼搏，是一定会有所作为的。屈原放逐乃赋《离骚》，司马迁受宫刑乃成《史记》，就是因为他们无论什么时候都不气馁，都有坚韧不拔的意志。有了这一点，就会挣脱困境的束缚，走向人生的辉煌。

此外，作为一个现代人，应具有迎接失败的心理准备。世界充满了成功的机遇，也充满了失败的可能。所以要不断提高自我应对挫折与干扰的能力，调整自己，增强社会适应力，坚信失败乃成功之母。若每次失败之后都能有所“领悟”，把每一次失败当作成功的前奏，那么就能化消极为积极，变自卑为

自信。

（四）用实际行动建立自信

征服畏惧，战胜自卑，不能夸夸其谈，止于幻想，而必须付诸实践，见于行动。建立自信最快、最有效的方法，就是去做自己害怕的事，直到获得成功。具体方法如下：

1. 突出自己，挑前面的位子坐 在各种形式的聚会中，在各种类型的课堂上，后面的座位总是先被人坐满，大部分占据后排座位的人，都希望自己不会“太显眼”。而他们怕受人注目的原因就是缺乏信心。

坐在前面能建立信心。因为敢为人先，敢上人前，敢于将自己置于众目睽睽之下，就必须有足够的勇气和胆量。久之，这种行为就成了习惯，自卑也就在潜移默化中变为自信。另外，坐在显眼的位置，就会放大自己在领导及老师视野中的比例，增强反复出现的频率，起到强化自己的作用。把这当作一个规则试试看，从现在开始就尽量往前坐。虽然坐前面会比较显眼，但要记住，有关成功的一切都是显眼的。

2. 睁大眼睛，正视别人 眼睛是心灵的窗口，一个人的眼神可以折射出性格，透露出情感，传递出微妙的信息。不敢正视别人，意味着自卑、胆怯、恐惧；躲避别人的眼神，则折射出阴暗、不坦荡的心态。正视别人等于告诉对方：“我是诚实的，光明正大的；我非常尊重你，喜欢你。”因此，正视别人，是积极心态的反映，是自信的象征，更是个人魅力的展示。

3. 昂首挺胸，快步行走 许多心理学家认为，人们行走的姿势、步伐与其心理状态有一定关系。懒散的姿势、缓慢的步伐是情绪低落的表现，是对自己、对工作以及对别人不愉快感

受的反映。倘若仔细观察就会发现，身体的动作是心灵活动的结果。那些遭受打击、被排斥的人，走路都拖拖拉拉，缺乏自信。反过来，通过改变行走的姿势与速度，有助于心境的调整。要表现出超凡的信心，走起路来应比一般人快。将走路速度加快，就仿佛告诉整个世界：“我要到一个重要的地方，去做很重要的事情。”步伐轻快敏捷，身姿昂首挺胸，会给人带来明朗的心境，会使自卑逃遁，自信滋生。

4. 练习当众发言 面对大庭广众讲话，需要巨大的勇气和胆量，这是培养和锻炼自信的重要途径。在我们周围，有很多思维敏锐、天资颇高的人，却无法发挥他们的长处参与讨论。并不是他们不想参与，而是缺乏信心。在公众场合，沉默寡言的人都认为：“我的意见可能没有价值，如果说出来，别人可能会觉得很愚蠢，我最好什么也别说，而且，其他人可能都比我懂得多，我并不想让他们知道我是这么无知。”这些人常常会对自己许下渺茫的诺言：“等下一次再发言。”可是他们很清楚自己是无法实现这个诺言的。每次的沉默寡言，都是又中了一次缺乏信心的毒素，他会愈来愈丧失自信。从积极的角度来看，如果尽量发言，就会增加信心。不论是参加什么性质的会议，每次都要主动发言。有许多原本木讷或有口吃的人，都是通过练习当众讲话而变得自信起来的，如萧伯纳、田中角荣、德谟斯梯尼等。因此，当众发言是信心的“维他命”。

5. 学会微笑 大部分人都知道笑能给人自信，它是医治信心不足的良药。但是仍有许多人不相信这一套，因为在他们恐惧时，从不试着笑一下。真正的笑不但能治愈自己的不良情绪，还能马上化解别人的敌对情绪。如果你真诚地向一个人展颜微

笑，他就会对你产生好感，这种好感足以使你充满自信。正如一首诗所说：“微笑是疲倦者的休息，沮丧者的白天，悲伤者的阳光，大自然的最佳营养。”

（五）牢记增强自信心的11个法则

人人都能忍受灾难和不幸，并能战胜它们。有人也许不相信自己能办得到，可是人类有强得惊人的内在源泉，只要我们加以利用，便能渡过难关。

法则 1：首先对自己抱有希望。如果你连使自己改变的信心都没有，那就不要再向下看了……要对自己宽容，并使事情看起来容易做到。

法则 2：表现得好像自信十足，这会使你勇敢一些。想象你的身体已接受挑战，显示自己并不是全然害怕。

法则 3：停下来想一想，别人也曾面对沮丧和困难，却克服了它们，别人既然能做到，当然你也能。

法则 4：记住：你的生命是以某种节奏前进，你若感到失意消沉，无力面对生命，你也许会沉至山洼的底部；但是你若保持自信，便可能利用当时正扯你下坠的那股力量，跃出洼谷之外。

法则 5：记住夜晚比白天更容易使你感到挫败和气馁。自信多与太阳一道升起。

法则 6：只有想不到的事情，没有干不成的事情。

法则 7：我们大多数人所拥有的自信，远比我们想象的更多。

法则 8：克服局促不安与羞怯的最佳方法，是对别人感兴趣，并且想着他们，然后胆怯便会奇迹般消失。为别人做点事

情，举止友好，你便会得到惊喜的回报。

法则 9：只有一个人能治疗你的羞涩不安，那便是你自己。没有什么方法比“忘我”更好。当你感觉胆怯、害羞和局促不安时，立刻把心思放在别的事情上。如果你正在演讲，那么除了讲题，一切都忘了吧，切莫在意别人对你和你的演讲如何看，忘记自己，继续你的演讲。

法则 10：只要下定决心，就能克服任何恐惧。请记住，除了在脑海中，恐惧无处藏身。

法则 11：害怕时，把心思放在必须做的事情上。如果准备充分，便不会害怕。

下

篇

社交恐怖症的森田疗法



第 8 章 森田疗法

第 9 章 日本对人恐怖症的研究概况

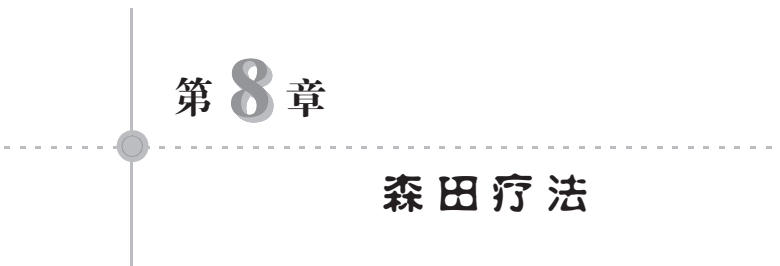
第 10 章 森田理论关于对人恐怖症发病机制的论述

第 11 章 森田教授与患者谈如何治疗对人恐怖症

第 12 章 一位日本社交恐怖症患者的心路历程

第 13 章 施旺红教授的集团森田疗法

第 14 章 施教授论森田疗法的运用技巧



第 8 章

森田疗法

森田疗法，是由已故日本东京慈惠医科大学教授森田正马先生在1919年创立的。其理论也受我国古代老庄思想影响，其价值已被充分证明和广泛确认，并已在世界范围内得到广泛的认可。中日两国同属东方文化。近年来，在我国临床验证，森田疗法是治疗神经症理想的方法，它使众多为神经症所苦恼的人获得了新生。森田学说的理论体系不是出自某种理论的延伸或实验室的结论，而是来自森田先生自身的神经症体验和他多年的临床实践经验的总结。

森田先生小时候由于家庭强迫学习导致过“学校恐怖”；12岁时为仍患夜尿症而苦恼；16岁时患头痛病，常常出现心动过速，容易疲劳，总是担心自己的病，是所谓的“神经衰弱症状”。在高中和大学初期，他经常神经衰弱，东京大学诊断为神经衰弱和脚气病，经常服药治疗。大学一年级时，父母因农忙，两个月忘记了给森田寄生活费，森田误以为是父母不支持他上学，感到很气愤，甚至想到当着父母的面自杀。于是暗下决心，豁出去拼命地学习，要干出个样子来让家里人看看。在这时期

什么药也不吃了，放弃一切治疗，不顾一切地拼命学习，考完试后，取得了意想不到的好成绩。不知什么时候，脚气病和神经衰弱等症状不知不觉也消失了。

这些个人经历，导致他后来提倡的神经症的本质论，包括疑病素质论。神经衰弱不是真的衰弱，而是假想的主观的臆断。神经质者本能上有很强的生存欲望，是努力主义者，症状发生的机制即精神交互作用。最重要的是森田先生在自己切身体验中发现“放弃治疗的心态”，对神经症具有治疗作用。从以上资料可以看出，这些成为森田疗法理论基础的内容，全都是他自己痛苦体验的结晶。然而仅仅有这些体验是不够的，更加重要的是，他通过多年来对神经症患者的观察，把握其症状的实际表现，密切注意其经过转归，并把这些观察与自己的体验相对照；他阅读国内外文献，将当时认为较好的治疗神经症的各种治疗方法一一进行实践验证；最后，森田先生把当时的主要治疗方法，如安静疗法、作业疗法、说理疗法、生活疗法等取其有效成分合理组合，提出了自己独特的心理疗法。

■ 森田疗法的基本理论 ■

（一）疑病素质论

森田认为，神经质发生的基础是某种共同的素质倾向，称为疑病素质。所谓疑病素质是指一种精神上的倾向性，其表现如下。

1. 精神内向 所谓精神内向，是指经常把活动目标拘泥于自身，偏重于自我内省，对自己躯体方面和精神方面的不快、

异常疾病等感觉特别注意、关心，并为此而忧虑和担心，以自我为中心，被自我内省所束缚。而精神外向，是指精神活动趋向外界，追逐现实，目的明确，有时表现轻率。精神外向的人充满热情，常因事业的追求，无暇关注个人身体疾病等。弗洛伊德也说过：“精神时常向内活动，从而封闭在自我身心内部的人，易患神经症；精神经常向外活动的人，就不会得神经症。”

2. 疑病症 所谓疑病症，即害怕疾病的意思，是一种担心患病的精神倾向。其实这是人人都有的一种表现，神经质的人只不过是程度过强而已。森田认为神经质是一种先天性素质，是一种侧重于自我内省、很容易疑病的气质。

（二）精神交互作用和思想矛盾

1. 精神交互作用 指因某种感觉偶尔引起对它的注意集中和指向，那么，这种感觉就会变得敏锐起来，而这一敏锐的感觉又会更加吸引注意力，进一步固着于这种感觉，感觉与注意交互作用彼此促进，致使该感觉越发强大起来，对这种精神活动过程称之为精神交互作用。例如神经性头痛，由于过劳、紧张，有人会因头部有异常感觉而使本人的注意倾注于此，注意与感觉的相互作用越发引起敏感。即便是过劳或紧张情况早已消失之后，由于预期恐怖引起的注意固着状态，会遗留下痛苦的感觉，形成习惯性头痛。

2. 思想矛盾即心理冲突 主要指应该如此和事实如此之间的矛盾，是理想与现实之间的冲突。这里的事实也包括自身的自然现象，例如从理智上认识到世界上是没有鬼的，但夜间走过坟地时照样会感到害怕恐惧，所以单靠理智上的理解是不成

的，如果企图用理性来克服这种恐怖，便会造成思想矛盾即心理冲突。

（三）生的欲望和死的恐怖

森田认为生的欲望的含义至少有如下几类：①希望健康地生存；②希望更好地生活，希望被人尊重；③求知欲强，肯努力；④希望成为伟大的、幸福的人；⑤希望向上发展。这是人类本性的表现，是人人都有的一种表现。但是神经质的人想将自己生的欲望达到一种完美的境界，这种苛求完美的理想主义是神经质人格的又一特征。其表现是：在完成自己生的欲望的同时，绝对不能容忍丝毫的心身异常的出现，出现一种强迫性求全欲，甚至对自己内在的性格——容易出现焦虑、神经过敏等倾向，也非常不满，想成为一个完美的人，由于克服这种焦虑的愿望很强烈并由此形成思想矛盾。由于神经质的人生的欲望非常强烈，所以死的恐怖也非常强烈，二者成正比例，死的恐怖中包含了对生的欲望追求的同时，还包括怕失败，怕疾病，怕种种有价值的东西失去，怕死亡等，焦虑与死的恐怖具有相同的意义，可以说是神经质者所特有的病理学的概念。

（四）精神拮抗作用

森田认为，人的精神活动也存在一种拮抗作用。例如当我们发生恐怖时，另一方面又出现不要怕它的相反心理；打算买东西时，先要考虑一下是否浪费的问题；要出门时，反倒先要回顾室内是否忘记东西。这是所谓相对观念。这种对应作用也是精神领域中的一种自然现象，可以保证生命安全和精神安全。这种精神拮抗作用如果过弱，如小孩或白痴，一旦产生欲望，就会毫无顾忌地行动。而神经质者精神抗拒作用过强，由于欲

望和抑郁之间的抗拒作用，常引起犹豫不决而精神痛苦。又如在某种情况下，出现对某人（尤其是大家常崇拜的人）的不敬念头，同时会想到这是错误的，不是自己的真实想法，从而在内心加以否定。这些在一般人只是一闪即逝、不留痕迹的想法，在疑病本质并且精神拮抗作用很强的人身上，会固执地出现，形成对立，再通过精神交互作用而形成强迫观念症。

以上论及的森田关于神经质发病的基本理论，简而言之，就是具有疑病素质的人，由于某种契机，（疑病体验）把人们普遍存在的一些身心自然现象如用脑过度时的头痛、失眠、与生人交往时的拘谨不安，以及偶然出现的杂念、口吃等，误认为是病症，而把注意力集中在这上面，感觉愈敏锐，“病症”也就愈重。由于这种精神交互作用而形成恶性循环，结果成为神经症患者。

森田疗法的适应证

1. 普通神经症 即平常所说的神经衰弱，包括失眠症、头痛、头昏、头脑不清、感觉异常、易兴奋、易疲劳、脑力减退、疲劳感、不必要的忧虑、性功能障碍、头晕耳鸣、颓废、记忆减退、注意力不集中等。

2. 强迫观念症 主要包括对人恐怖如赤面恐怖、视线恐怖、自己表现恐怖、循环恐怖、学校恐怖、外出恐怖、罪恶恐怖、不祥恐怖、高处恐怖等。

3. 发作性神经症 如呼吸困难发作、焦虑发作等。

新森田疗法不仅限于治疗神经症，而适应证也在不断地扩

大。例如，药物依赖、酒依赖、精神分裂症、抑郁症等，都取得了治疗效果（对于后两种疾病的患者，主要是进入缓解期以后）。这些患者采用森田疗法，不是正规地由绝对卧床开始，而是从作业期开始。

森田疗法的治疗原理

根据森田的病理理论，森田提出了针对性的治疗原理与方法，疗法的着眼点在于陶冶疑病素质，打破精神交互作用，消除思想矛盾。其治疗原理可概括为两点。

（一）顺其自然

森田认为，要达到治疗目的，说理是徒劳的。正如从道理上认识到没有鬼，但夜间走过坟地时照样感到恐惧一样，单靠理智上的理解是不行的，只有在感情上实际体验到才能有所改变。而人的感情变化有它的规律：注意越集中，情感越加强；听其自然不予理睬，反而逐渐消退；在同一感觉下习惯了，情感即变得迟钝；对患者的苦闷、烦恼情绪不加劝慰，任其发展到顶点，也就不再感到苦闷烦恼了。因此，要求患者对待症状首先是要承认现实，不必强求改变，要顺其自然。

什么叫顺其自然呢？森田把它看做是相当于佛禅的“顿悟”状态。所谓“顿悟”，就是让患者认识并体验到自己在自然界的位置，体验到：对超越自己控制能力的平常的事，看得很严重而产生抗拒之心，结果使自己陷入了神经质的旋涡。这就与上述规律相符合，即由于集中注意于令其感到厌恶的情感，并不断压抑这种情感而使之受到强化，经多次反复而培养起他对人

极度恐惧的体验，而这一过程又违背了上述规律。因此，要改变这种状况就须使患者认识情感活动的规律，接受自己怕的情感，不去压抑和排斥它，让其自生自灭，并通过自己的不断努力，培养积极健康的情感体验。

1. 要认清精神活动的规律，接受自身可能出现的各种想法和观念 神经质患者常常主观地认为，自己对某件事物只能有某种想法而不能有另一种想法，有了就是不正常或者不道德的，即极端的完善欲造成了强烈的劣等感。要改变这一点，就得接受人非圣贤这一事实，接受我们每个人都有可能存在邪念、嫉妒、狭隘之心的事实，认识到这是人的精神活动中必然会出现的事情，是一个人靠理智和意志不能改变和决定的，但是否去做不理智的事情，却是一个人完全可以决定的。因此，不必去对抗自己的想法而须注意自己所采取的行动，同时，还要认清精神拮抗作用，从心理上放弃对对立观念的抗拒，认识到人有对生的欲望和对死的恐惧两种相互对立的心理现象，并接受这种心理现象，而不必为出现死亡的恐怖而恐惧不安，也不必摒除这些令人恐惧的念头，使自己陷入激烈的精神冲突之中。

2. 要认清症状形成和发展的规律，接受症状 神经症患者原本无任何身心异常，只是因为他存在疑病素质，将某种原本正常的感觉看成是异常的，想排斥和控制这种感觉，使注意固着在这种感觉上，造成注意和感觉相互加强的作用，即形成精神交互作用。这是一种恶性循环，是形成症状并使之继续的主要原因。认清这一点，对自己的症状采取接受态度，一方面不会强化对症状的主观感觉；另一方面，因为不再排斥这种感觉，而逐渐使自己的注意不再固着在症状之上，以这样的方式打破

精神交互作用，从而使症状得以减轻直至消除。比如：对人恐怖患者见人脸红，越怕脸红，就越注意自己的表情，越注意就越紧张，反而使自己脸红的感觉持续下去了；相反，接受脸红的症状，带着“脸红就脸红吧”的态度去与人交往，反而会使自己不再注意这种感觉，从而使脸红的反应慢慢消退。

3. 要认清主客观之间的关系，接受事物的客观规律 人之所以患神经质症，疑病素质是症状形成的基础，精神交互作用是症状形成的原因，而其根源在于人的思想矛盾。这一思想矛盾的特征就是以主观想象代替客观事实，用“理应如此”来限定自身的思想、情感和行为。森田指出：“人究竟如何破除思想矛盾呢？一言以蔽之，应该放弃徒劳的人为决策，服从自然。想依靠人为的办法，任意支配自己的情感，就如同要使鸡毛上天、河水断流一样，不仅不能如愿，反而徒增烦恼。此皆力所不能及之事而强为之，当然痛苦难忍。然而，何谓自然？夏热冬寒乃自然规律，要想使夏不热、冬不寒，悖其道而行之则人为的决策；按照自然规律，服从、忍受，就是顺应自然。”针对思想矛盾，森田提出了“事实唯真”的观点，意即“事实即是真理”，并以此作为座右铭。他说：“吾人不要把情绪或想象，误认为事实来欺骗自己。因为不论你是否同意，事实是不可动摇的。事实就是事实，所以人必须承认事实。认清自己的精神实质，就是自觉；如实地确认外界，就是真理。”只有使人的主观思想符合客观事物的规律，才能跳出思想矛盾的怪圈。

（二）为所当为

森田疗法把与人相关的事物划分为两大类：可控制的事物和不可控制的事物。所谓可控制的事物是指个人通过自己的主

观意志可以调控、改变的事物；而不可控制的事物是指个人主观意志不能决定的事物。

森田疗法要求神经症患者通过治疗，以学习顺应自然的态度，不去控制不可控制之事，如人的情感；但还是注意为所当为，即控制那些可以控制之事，如人的行动。即“为所当为”是指在顺应自然的态度指导下的行动，是对顺应自然治疗原则的充实。

1. 忍受痛苦，为所当为 森田疗法认为，改变患者的症状，一方面要对症状采取顺应自然的态度，另一方面还要随着本来有的生的欲望，去做应该做的事情。通常症状不会即刻消失，在症状仍存在的条件下，尽管痛苦也要接受，把注意力及能量投向自己生活中有确定意义，且能见成效的事情上，努力做应做之事；把注意力集中在行动上，任凭症状起伏，都有助于打破精神交互作用，逐步建立起从症状中解脱出来的信心。例如：对人恐怖的人，不敢见人，见人就感到极度恐惧，森田疗法要求其带着症状生活，害怕见人没关系，但该见的人还是要见，要带着恐惧与人交往，注意自己要做什么；而这样做的结果，患者自己就会发现，原来想方设法要消除症状，想等症状不存在了再与人接触，其实是不必要的；过去为此苦恼，认为不能做，是因为老在脑子里想而不去做。而“为所当为”要求患者该做什么马上就去做什么，尽管痛苦也要坚持，就打破了过去那种精神束缚行动的模式。

2. 面对现实，陶冶性格 森田疗法的专家高良武久指出：“人的行动一般会影响其性格，不可否认，一定的性格又会指导其做出一定的东西，但仅仅看到这一方面，则是一个片面性的

认识。我们也不能忘记‘我们的行动会造就我们的性格’这一客观事实。正是这一点，才是神经质性格得以陶冶的根本理由。”

神经症患者的精神冲突，往往停留在患者的主观世界之中。他们对引起自己恐惧不安的事物想了又想，斗了又斗，但在实际生活中，对引起其痛苦的事物却采取了一种逃避和敷衍的态度。事实上，单凭个人主观意志的努力，是无法摆脱神经质症状的苦恼的，只有通过实际行动，才会使思维变得更加实际和深刻。实际行动才是提高对现实生活的适应能力的最直接的催化剂。对此，高良武久举例说，要学会游泳，不跳入水中就永远也学不会游泳，即使完全不会游泳，跳入水中也是完全可以做到的，然后再逐步学习必要的技术。与此道理相同，神经症患者无论怎么痛苦，也会在别人指导下做到，这样就可以在不知不觉中得到自信的体验。要想见人不再感到恐惧，只有坚持与人接触，在实际接触中采用顺其自然的态度，使恐惧感下降，而逐步获得自信。前面已经谈到，“为所当为”有助于使症状得到改善，其中很重要的一点，就是在实际生活中将精神能量引向外部，就是要注意所做的事情，这就减少了指向自己心身内部的精神能量。而与外部世界的实际接触，又有助于患者认识自身症状的主观虚构性。这一过程实际上是使内向型性格产生某种改变的过程。

在顺应自然的态度指导下的“为所当为”，有助于陶冶神经质性格。这种陶冶并非彻底改变，而是对其性格的不同部分进行扬弃，即发扬神经质性格中的长处——认真，勤奋，富有责任感等；摒弃神经质性格中的致病之处——神经质的极端的内省及完善欲。

由此可见，顺应自然既不是对症状的消极忍受，无所作为，也不是对症状放任自流，听之任之，而是按事物本来的规律行事，听凭症状存在，不抗拒排斥，带着症状积极地生活。“顺应自然、为所当为”治疗原则的着眼点是，打破精神交互作用，消除思想矛盾，陶冶性格。这一治疗原则还反映了森田疗法对意志、性格、行动和情感之间的关系的看法，即意志不能改变人的情感，但意志可以改变人的行为；通过改变人的行为来改变一个人的情感，陶冶一个人的性格。

■ 森田式的生活态度 ■

高良武久博士在开展森田疗法的同时，还规定了森田式的生活态度。这对于实施森田疗法，促进疗效，会带来莫大好处。

1. 端正外表 完美的外表与完美的心灵是联系在一起的。衣冠整洁，才能意志坚定。要振作精神、情绪焕发，首先要端正外表。一个衣饰凌乱不堪、生活懒散的人，很难相信他是一个意志坚定的人。因此，要摆脱内心的痛苦和不安，首先须端正外表，要意志自然而然地坚定起来。

2. 保持充实的生活 人们要保持充实的生活，就必须养成劳动的习惯。要自我感到不干事情心里就不踏实。人普遍要有向上的进取心，并不断地通过创造性的工作来实现，尔后才能取得成绩。例如，农民洒下了辛勤的汗水，秋后获得丰收的喜悦，从中体会到生活的意义。人们遭受痛苦，也会在工作中增加信心，减轻痛苦。对于过度内向化的神经症患者来说，通过

积极工作，可逐步走向外向型。高良武久博士指出：外向化的最佳方法是从事某种工作，即使是难做的事情，也要逼迫自己去做。

3. 勿长期休养 神经症患者不宜长期休养。长期休养，有害无益。神经症患者具有较强的上进心，他们要摆脱症状，也是为了能得到更强的工作能力。让患者长期不工作，会使患者觉得丧失了工作能力，从而可能使症状愈加严重。其实，神经症患者的身体根本无毛病，硬要让其休息，会使患者感到病情严重，这就很难从疾病观念中解脱出来。

4. 要正视现实 有一种人，当要去做一件不情愿的事情时，会找出一些借口，尽可能去回避；相反，要去做极感兴趣的事情时，虽然有困难，也要想法去实现。人要躲避现实生活中的烦恼，往往会受到理性的自责，当然，也会以各种理由来自我安慰。他们以病为借口，逃避现实，为此感到现实严酷，更感到病的痛苦。他们做每件事都会表示：我有病。这给治疗带来莫大困难，也是难以治愈的重要因素。正确的态度应是：不要以疾病为借口去逃避现实。

5. 不做完美主义者 神经症患者往往是完美主义者。他们有极强的欲望，他们想工作，但又不愿接受工作所付出的代价。他们以最顺利的状态为标准来要求自己，事实上这是根本无法实现的。现实与希望背道而驰，其结果处于一种完善的理想与不完善的现实的矛盾之中。事实上，绝对的完善是不存在的。正确的态度是：不做完美主义者。

6. 树立自信 森田正马博士认为，神经质的人一般带有劣等感。所谓劣等感，即相当于自卑感。他们自觉处处不如别人，

做事没有自信，结果一事无成。高良武久博士这样认为：“许多事情并不一定要有了自信之后才去做，自信产生于努力之中。有人认为只有有了自信之后才能去工作，这好比人学会了游泳之后再下水学游泳一样，是非常荒谬的。”人对根本不可能实现的事情，不会贸然从事。只有通过自己的努力还有成功的希望时，方能付诸行动。对于有劣等感的人来说，缺乏自信，做事犹豫不决，三思而不行，陷于完善欲的桎梏之中，这样就会一事无成。正确的态度应是：增强自信，勇于进取，通过实际行动去完成要达到的目的。

7. 不要急于求成 人们遇到悲痛忧伤的事情，譬如亲人的死亡，其情感的波动，难以在短时间内消除，使人经常沉溺于痛苦的回忆中。人们在心理上又想消除这种痛苦，然而，事与愿违，有的人越想排除越排解不开，这就是实际上想把不可能的事情变为可能，势必会陷入欲罢不能的心理冲突之中。高良武久博士主张：“既然对往事不能忘怀，就不要强行忘怀，而应带着这种思维积极地去做好日常生活中需要做的工作，这样就会在不知不觉中使这种思绪逐渐淡化，以至彻底消失，即使不完全消失，也会不再严重牵动我们的感情了。”显然，对于现实的痛苦，硬要逃脱是办不到的。我们只能顺其自然，听之任之，努力将自己致力于工作和学习之中。随着时间的流逝，痛苦和悲伤自然会逐渐消失了。

森田疗法的治疗要点

森田治疗的治疗要点是陶冶疑病素质和打破精神交互作用，

单纯说理是无效的。正如对人恐怖患者从道理上认识到人没有什么可怕的，但见人后照样感到恐惧、不自然，尽量避免与人接触。所以仅在理智上理解是不行的，必须在情感上身临其境去体验方能有所变化。

对于症状，森田教授提出“顺应自然”，采取不予理睬的态度，症状反而逐渐消退。因此对病人不予劝慰，令其顺应自然，如让苦闷发展到顶峰，这时反倒不再感到苦闷了。具体的做法是：一方面要无条件地接受症状，不排除症状，充分认识到对症状的抵抗；一方面带着症状去做应该做的事情，像正常人那样去工作和学习。对人恐怖的病人，见人感到恐惧，表情不自然时，就让他不自然、恐惧好了，同时去做该做的事情，这就是“忍受痛苦，为所当为”。对此，坚持下去自然就解除了主、客观的矛盾和冲突，打消了精神交互作用，症状也就随之减轻和消除了。

森田疗法所遵循的“顺应自然”的治疗原理，看起来似乎很简单，但真正领悟以达到治疗效果，并非那样容易。尤其是较重的神经症病人，让他们对引起痛苦的症状“顺应自然”、不予理睬和抗拒是不可能的。住院治疗则为其创造了一个特定的治疗环境，在医生的指导下，使其获得领悟和积极的生活体验。

■ 森田疗法的实践计划 ■

（一）第一阶段：生活实践阶段

1. 体力劳动——森田疗法实践的钥匙 从寝室或家庭卫生做起，做每天力所能及的劳动。体力劳动是最有效的实践方法，

它要比脑力劳动更有效果。

2. 做应该做的事——实践的定位 做应该做的事，无论自己的心情如何，都要坚持日常的工作和学习，这是森田疗法的最关键措施。但是，如果为了锻炼自己，而去做与自己意愿相反的事则不是为所当为的真正意义了。

3. 每天要不断地干点什么——实践的强度 要减少睡眠时间尤其是尽量不在白天睡觉，白天要不断地干点什么。

4. 禁止消愁解闷的各种活动 这类活动如吸烟，听音乐，弹琴，玩游戏。我说不要这样做是指在集中实践这段时间不要这样做。这样安排的目的是为了体验森田疗法的精神，我不是要您永远都不要这样。

神经质的症状，用消愁解闷的方法也可以解决。然而，因为那样做只不过是精神上的一种暂时性的转换，时过境迁，立即就会重新恢复原状，就和催眠术只能解决一时性的问题是同样的。倘能经常正面地面对苦恼，把苦恼切实看作苦恼来接受它，这样一来，苦恼本身终于被绝对孤立起来，自己再也无法对它感受和评价了，苦恼的感受也就没有了。

5. 对症状要采取忍受的态度，带着症状坚持实践 对待症状要不过问，不测试，不拘泥。

不过问：尽可能不要再谈自己的病情，如果遇到症状缠绕的情况，可采取所谓不问疗法，装作不知，听之任之。

不测试：制止自己测试症状是否好转，情绪是否变好，要听其自然地对待病情。

不拘泥：如果感觉“头轻快了，精神爽快了”时，应当注意这只不过是一种自我感觉，从疾病的角度来看，它和痛苦是

同一的东西，爽快之后，作为一种相反的状态往往会出现不愉快，到了完全摆脱愉快与不愉快的感觉之后才是真正恢复了健康。

6. 阅读森田疗法书籍的问题 在实践头一周内请不要阅读森田疗法方面的书籍，在实践一周后开始每天晚上睡前抽出半小时左右阅读森田疗法的书籍，请用体会的态度去读。

7. 切莫拘泥于理论 在治疗过程中莫拘泥于理论，把自己的情况机械地与理论对照，看哪里好哪里不好，勉强地来矫正自己。但愿能顺应自然，保持安心度日的情绪就很好，要逐渐领会某种体验，在此基础上才能形成正确的理论。

请按上面的要求去实践，森田疗法的实践以一个月为一个进程，也就是说，只有实践到一个月的时候才可能有一定的体验。总的实践时间短则三个月长则半年。

每月推荐之实践计划：

- (1) 禁止消愁解闷(禁止游戏、吸烟、听音乐、上网消遣等)。
- (2) 做当为之事，包括读书、劳动、工作、运动及其他每日当为之事。

要求：①做事要不分重要的还是不重要的，有意义的还是无意义的。②每天都要不断地干点什么，要减少睡眠时间。

(3) 对待症状是没有办法的事，要逐渐在实践中体会这一点。

- (4) 每天读少量森田疗法方面的书。
- (5) 每三天或一周写一篇日记。

(二) 生活实践阶段的注意事项

在这一阶段要逐步体验下面的内容。

1. 体验自己在自然界中的位置 体验自己是无法控制感情和症状的，就像你不能使身体飞起来一样。我们的心情就像水一样，不时地泛起阵阵波澜，如果我们任其自然地发展，水波就会自然地产生，自然地消失，不会给我们带来更多的痛苦，但如果我们想人为地令水的波浪消失，就必然会撩起更多的波澜。

2. 培养迅即工作的精神 无论做什么，必须尽量迅速地工作，而且要坚持实践下去；无论做什么都不必安排时间表，估计效果，也不必选择，即要排除患者对于工作的预先考虑和价值观。

注释：①去掉预先的考虑。过去我在工作的空隙，总好不断考虑关于“怎样引导自己才好”的问题，然而，即使规定了某种行动方针，虽然放心了，却丝毫没有成为实际行动的规范。如果有时候没有提出什么所谓既定的方针，便越发不断地陷入了迷惑。今天，我已经不再那样考虑，只是凭借朴素的欲望去干点什么而已。一位会员在谈自己对此的体验时说，“最近，没再为寻找工作而费尽心机，也没在早晨就订好一天的工作计划，只是在着手干某种事情的过程中顺便由此及彼地考虑好下一步要干什么工作的问题。现在我对于出现在眼前的千头万绪，能有一心一意地自右向左逐条顺理依次去做的打算。今后即使回到单位，越是特别忙的时候，将会越是满心高兴。”因此那种每每工作之前都要计划一番的习惯亦应逐步改变。②去掉工作的价值观。森田说“在价值观和某种打算之下进行工作时，工作永远不会真正成为自己的东西。归结起来，对工作本身充满乐趣的那种纯真的精神才算是超越了价值观念的东西。”因

此，我们在长期学习生活中所形成的对待不同工作的强烈的价值观应逐步消除，在进行实践时尤应注意要排除“这样的工作有意义，那样的工作无意义”的想法，这样工作才会形成乐趣。

3. 不必刻意安排对自然的生活节奏的体验 我们只要能照朴素的欲望去活动就可以了，不必害怕心身的消耗或毙命。因为在我们身体中，存在着像安全阀那样起到自我调节作用的东西。因此，没有必要死按那些机械的理论去休息或休养。在活动的过程中，就会不断调剂缓急，自然进行工作上的变化，通过它是可以自动调节的。

4. 欲治不治、不治而治的体验 最近的实践给我一个最大的体验就是当你一味祈求“顺应自然，为所当为”以消除自身的某种症状时，症状反而会加重，而当你逐渐为另一症状所困惑或专心于其他事时，这一症状则会减轻甚至消失，这就是顺应自然的真谛。老子曰：“无为而无不为”。无为就是不去设法改变自己的症状和性格，这样症状和性格就会自然改善，从而造成一种无不为的状态。

5. 不需要什么勇气 患者说“已经决定我从一月份开始必须到学校去上班，可是真不知道我是否有了去学校的勇气”。森田说“只要能去就行，不需要什么勇气”。患者有所谓“努力把痛苦当作痛苦来接受”的说法，倘真这样努力，就又使痛苦成为双重了。实际上即使不努力，痛苦终究还是痛苦。所以，想特意设法取消痛苦这是多余的。降临在身的灾难，涌现心头的痛苦，除了承认事实，听之任之，别无他法。就像禅家所说“心头无杂念，烈火也觉凉”那样，已经到了这种时候，若再专

心致志地祈求听其自然，或用上力气去灭却心头杂念的话，那就已经既不能顺应自然，也不能灭却心头杂念了。

（三）森田疗法实践计划——坚持森田疗法的宗旨

下面是森田疗法治疗宗旨，在实践过程中请一定要坚持下面三点，它是指导您行动的指针。

1. 作业疗法 绝对卧床结束后即进入作业期。作业是由最初的简单轻体力劳动向重体力劳动过渡。其目的是：

（1）人本来就是要活动的，要让患者体会到，即使有症状也可参加劳动。通过劳动，减轻症状的痛苦。

（2）通过劳动使患者由自我防卫和自我中心的倾向变为外向化，更实事求是。

2. 体验疗法 在森田疗法中重视通过亲身体验去认识事物。不是只靠思考去认识，要通过自身的行动体验去认识。由于重视这一点，也有人称森田疗法为体验疗法。

3. 不过问疗法 这也是一种技巧，把患者有关自己症状的主述，只当作是“一面之词”，尽量不去采纳，而是尽力让患者通过行动去获得某种体会。可以说绝对卧床就是这种技巧的象征性形式，是森田疗法特色之一。

（四）第二阶段——社会实践阶段

大约需要1~2个月进入第二阶段，进入第二阶段的标志是能对森田疗法理论中1/3的内容有所体会。这一阶段要坚持上面的实践方法，同时加强读书问题和社会交往问题的解决，并对“顺应自然，为所当为”产生更深层次的体验。因此在坚持上面的实践原则的同时，要注意以下几个方面。

1. 坦诚地与人交往 把“真实的自我”展现在众人面前，

停止演示伪装的愚蠢做法，这是语言行为上的顺应自然。即停止掩饰自己，停止心理文饰作用，坦诚地与人交往。（比如当因脸红恐怖，在人面前被称作“你是腼腆的人”时，最好是敞开心扉照实说：“实际上我为自己胆小而发愁，无论对方说点什么，我都立即脸红。这样无可奈何的事情真是少见。我真是的。”这种讲法暂且作为公式来套用也可以。请多次地反复使用。）

2. 纯真的感情是指导我们行动的指南 尤其是那些歉疚自责、羞愧害羞、紧张焦虑等反面心理，若能将这些心理付之行动和语言，使之充分地表达出来，则能使人左右逢源。非神经质的人是很难做到的。要善于利用神经质者的善于反省的特点，要知道这是神经质者的最大的优点。要善于把反省转变为行动。这样就能在人际关系中左右逢源。

3. 不要进行不必要的交际 所谓“广泛交际”实际上是一种虚张声势、外强中干的虚伪精神，而不是什么在交际方面的学习。人们的行动必须是根据生活需要或者是受个人欲望驱使的结果。不要去进行那些不必要的交际。自己要经常注意，切莫丢失自己原来谨慎的态度。一切活动必须经常出自本意才行，这就是去掉虚伪，回归真人的自然状态。

4. 有选择地读书 选择平铺直叙、内容实际的科学性读物。具体方法：随便摸过一本什么书，不加选择地翻开就读，不要追求理解，也不必用力记忆，要不问内在事理地一顺溜地默读下去。体验下面读书的新境界：如今读书，全然处在一种毫无牵挂的境地。有时连早晨迷迷糊糊、似睡非睡的时候读过的内容，也能很清晰地重现在脑海之中，再如，即使读书的当时未能立即记住的地方，事后考虑起来，却觉得记忆很好，因此感

到非常高兴。

这一时期可加大森田疗法书籍的阅读数量，这时阅读就会对其中的道理有一定的体会了。

（五）社会实践阶段着重体验的几方面

1. 纯真的心是坦诚的心，富于人情味的心 治疗过程中要逐渐去体察和发挥纯真的心和自己原始的性情，以及不蒙骗自己的精神。按照森田疗法的观点，越是坦诚的人，治愈得越快。

2. 对“无”的体验 什么事一旦刻意地从理论上解决，就会使最简单的问题也变得最复杂，就像佛家所说的“落入迷中了”。有人问森田博士：“我该用什么理论指导自己的行动呢？”森田说“这样也行那样也行”。他是在劝导人们不必追求理论，没有道理就是最好的道理。另外，对己对人对事无评价也很重要。因为一旦有了评价就会脱离事物的本相了。脱离了理论与评价的人会充满自信，对事物有深刻的见解，而落入理论与评价的泥潭中则会使人缺乏正确的自我评价，从而缺乏自信，看问题偏执。总之，“无”是最合现实的道理。例如：对自己的情绪无评价不分好坏则会回归到“纯真的心”的境界；对自己对人无评价则会更全面地认识自己与他人；对自己为何自信或自卑不求原因则会使人更清醒；受人夸奖、批评时心中无理论无评价时则能正确对待别人的话。另外，在心中波澜起伏时不参与任何内心辩解而迅速转换到工作中去，就能把注意力转移出来，从而很快会回复到“无”的状态，认识也自然清醒了。顺应自然的最高境界和核心内容大概就是这个“无”字。但只内心无物不行，在行动上要强调“有”字，即所谓“为所当

为”。这是最现实最有效的人生观。

3. 对“无所住心”——健康注意力的体验 这种健康注意力的体验就是一种注意力能迅速地转换的一种体验。无论处在多么高兴或沉迷的环境中都可以迅速地转换注意力。这是森田要患者形成的一种体验。

4. 另一个重要的体验是即使症状再次出现，却丝毫没有任何恐怖感了 这种情况就是疑病素质逐渐陶冶的体现。

5. 对不安常在的体验 人要活着，总会伴有不安。期望越大，不安就越甚，不安是必然存在的。你要摆脱不安，它却穷追不舍，你和不安抗争，它就一味地加剧。因此即使感到不安，如果能毫不惊慌失措地泰然处之，那么这种不安就会逐渐消失，即使有不安也如同没有一样。也就是说对于不安应该是来者不拒，顺其自然，继续做自己该做的事。为值得烦恼的事而烦恼的意思是：不值得去烦恼的事，烦恼也没有用，值得烦恼的，不妨为之烦恼。

森田疗法治疗用语及格言

在森田疗法的理论结构及治疗实践中(如说理,谈话,指导写日记等)都使用了一些已定的用语,其中有些来源于佛教。森田在治疗过程中往往给这些用语赋予多种含义。常用的格言简要说明如下:

顺其自然 对出现的情绪和症状不在乎,要着眼于自己的目的去做应该做的事情。“对待不安应既来之则安之”,“对情绪要顺其自然,仍然去做应该做的事情”。而不是一出现了不

安就听凭这种不安去支配行动。高良先生医院的院刊就叫“顺其自然”。

精神拮抗作用 精神拮抗作用也是症状顽固的原因，特别是强迫观念中，这种心理活动作用很大。把自己的某种身心现象视为于己不利或令人不快的东西，企图加以排斥和否定的态度。例如，当自己意识到在众人面前感到恐惧时，想要排斥恐惧，必须平静，但又做不到。因此总想把不可能变为可能的矛盾心理就会成为强迫观念的原因。结果由于这种机制，增强了精神交互作用。

精神交互作用 对神经质的发病有决定性作用的是疑病素质，对于症状的发展有决定作用的就是精神交互作用。对某种感觉如果过度注意，对这种感觉就会变得敏感，对这种敏感的感觉越来越注意并会使之固定，这种感觉与注意进一步相互作用，越来越形成感觉过敏的精神过程。

欲想一浪平息一浪，反而波浪迭起 意思是说如若企图一浪平息一浪，反倒会出现更多的波浪，极力要消除症状，结果反而接二连三地出现新的症状，最后弄得不可收拾。不要光想着治病，首先要成为一个有益于他人的人，把治病看成一件小事。

外表自然，内心健康 意思是说，像健康人一样地生活就能健康起来。神经质者总是希望先消除症状（改善情绪），然后再恢复到健康的生活，这样做永远不能有健康人的生活。对情绪不予理会，首先要像健康人一样去行动，这样，情绪自然而然就变成健康的情绪。

情绪为准则（情绪中心） 是指注重情绪的生活态度。情

绪本来不受自己的意志所支配。这种看重情绪的生活态度是神经质者所共有的。森田疗法要求“对于不受意志支配的情绪不必予以理睬”，让我们重视符合自己心愿的行动。当患者认为自己有病，并对症状感到精神负担时，医生就告诉患者，“这不是症状，只是一种情绪”，能体现你的价值的是行动和达到的效果，重视着眼于行动的生活态度。

行动为准则 唯有行动和这种行动的成果才能体现一个人的价值。一个人即使想法有多么高尚，若是偷窃他人的东西，那就是盗贼；反之，即使想过多少坏事，若肯帮助别人，就会被看成是好人。舆论的评价就是如此。这就是“与其想，不如做”。从这个意义上，森田对情绪要既来之则安之，要为实现既定目标去行动的生活态度，称做行动为准则。

心随万境变，变化之处实幽玄 这是摩攀罗尊者的话。意思是：人的心境随着境遇不同而千变万化，甚至可以说，这种现象实在是玄妙。在森田疗法中它赋予的含义是“情绪就像天气一样容易变化；情绪恶劣时不要悲观，情况顺利时也不要高枕无忧，要着眼于行动，努力去干”。

唯事实为真实 意思是“只有事实才是真实的”。它是以情绪为准则相对应的词。对无能为力的客观事实，就要承认自己无能为力。与顺从自然是同义语。

顺从自然 与“顺其自然”同义。不是要屈服于大自然的意思，而是说，对于由不得自己的事情，即使怎样着急也无济于事，同样，自己的心情受现实的影响。这时就应该老老实实地接受现实，自己的情绪好也罢，坏也罢，唯有行动要一如既往地坚持下去。

思想矛盾（恶智） 所谓思想矛盾是指“应该如此”的想法与“就是如此”的事实之间有矛盾。与佛教所说的“恶智”具有同样的内容。据森田说，我们的主观与客观、情感与知识、理解与体验经常互相矛盾；这是理性认识上的方法错误，它总是错误地认为凭着合理的、合乎逻辑的理性能够解决不合情理的情感方面的问题，并试图解决这类问题。

死的恐怖 生的欲望是积极方面的精神动力；与此相反，死的恐怖则可以说是一种消极方面的精神动力。虽然二者同属于动力，但方向不同，因此其表现形式也完全相反。就是说：如果一个人表现出强烈的“生的欲望”，他就会具有健康人的生活态度；而当“死的恐怖”明显时，就会成为神经质。二者不是对立的观念，毋宁说他们是相互协调的，偶尔还会彼此交替。从这个意义上，森田疗法是把“死的恐怖”转向“生的欲望”的一种操作。

温顺 是指一种顺从老实的态度，但它不同于盲从。有这样一个例子。一次森田对一位神经质患者说：“你要是照我说的去做，病就会好，怎么样，你做不做？”患者回答说：“好的，怎么做都行。”于是森田说：“那么你现在就原地转三圈儿，然后给我鞠躬。”患者照他说的做了。然后，森田告诉他：“你这不是温顺，而是盲从。如果是真正温顺的人，你会因为感到害羞而停止，或者说‘这家伙真有点……’，或抓抓头。而你这样做是被曲解的‘必须要温顺’所束缚。”

主观虚构性 这是高良提出的问题。神经质者很难自己冷静、如实地做出客观判断。这是由于思想受到疑病情绪的影响，其判断往往被情感色彩所歪曲。因此，患者在叙述症状时，往

往内容与事实明显不一致。高良把这叫做神经质者的“主观虚构性”。

纯真的心 意思是坦诚的心，富于人情味的心。按照森田疗法的观点，“越是坦诚的人，治愈得越快”。

神经质（症） 森田把森田疗法有效的各种神经症叫做神经质。但另一方面，他也把神经质这一名称用来表示一种性格特征。森田把神经质者同其他精神障碍者严格区分开。可以设想，他之所以使用这一像病名又像性格特征的模糊概念，是因为他有一个信念：“神经质不是病”。然而高良则把神经质看成是神经症的一种类型，把它叫做神经质症，把神经质用来表示性格特征。至今有多数学者在使用这一名称时，仍然沿用森田的本来含意。由于这样缘故，也有学者强烈主张，在使用“神经质”这一名称时，应用“森田神经质”。

尽性 有这样一句话，叫做“要尽己性，尽人性，尽物性”。所谓“尽己性”，就是要真正明确自己的状态，怀着生的渴望去过积极的生活，为实现自我从现在做起，奋发努力。所谓“尽人性”，就是要肯定别人应有的价值，发挥他的长处。所谓“尽物性”，就是要看准每件事物的存在价值，提高它的价值。

生的欲望 这一概念是森田的基本指导思想之一。“生的欲望”通常被解释为人类总希望自己不断向上、不断发展的一种欲望。但分析一下森田的文献，可以发现其中包含以下的种种愿望：①不想得病，不想死，想生存；②想活得更好，不希望被人看不起，希望得到别人的肯定；③想多知道一些知识，想学习；④想变得了不起，想得到幸福；⑤想提高和发展等。

这种欲望可以说是一种积极的精神动力，精神健康的人，无论谁都有很多这种欲望。

碎啄同时 指治疗时机成熟。来源于当鸡蛋中的小鸡即将孵出时，母鸡从外面啄蛋壳的动作同小鸡从蛋里面破壳的动作同时发生。在使用森田疗法的专家中，有人使用“嘴啄同时”或“碎啄同时”。这种说法在字典中找不到。

有大疑才有大悟 越迷惑越好，越怀疑越好。这种矛盾心理越厉害，领悟就越大。

体验疗法 在森田疗法中重视通过亲身体验去认识事物。不是只靠思考去认识，要通过自身的行动体验去认识。由于重视这一点，也有人称森田疗法为体验疗法。

协调 在森田理论中，一般没有对立概念。就以“生的欲望”和“疑病性”为例，乍看上去，使人觉得是对立的概念，其实在人格中保持协调。“协调”这一概念往往被人忽视，而它是森田人生观的体现。森田追求的人生目标，总的来说，就是要在自己所处的时代和领域中成为一个“伟人”。他对自己在该领域中的知识有绝对的自信心。在他看来，一个健康人要谋求地位、获得财富，并在自己所处的时代树立起要成为一个“了不起的人”的人生奋斗目标乃是人之常情，但其内在，需要经常保持一种“协调”。无论怎样想要得到财富、得到地位，如果没有“协调”（即若是成为非社会性的或是反社会的）那他就根本不可能成一个“了不起的人”。

适应不安 这是高良提出的概念。高良认为森田所用的疑病性基调这一概念模糊不清，于是便提出了“适应不安”这一概念，以取而代之。高良认为，所谓“适应不安”就是感到无

法以自己的现状去适应环境从而出现了不安。从这一意义上说，适应不安就是一种症状，严格地说，它同疑病性基调有不同的内涵。

束缚 在森田的理论中，通常把引起神经症的冲突、发生的机理用“被束缚”或“注意”来解释。就是说，冲突心理的产生，就是经常提到的“由于被束缚”、“过度注意”那样的自身原因所引起。根据森田学说，导致“被束缚”和“注意”的个体因素，不能只单纯看成是疾病恐怖、对死的恐怖的单纯本能反应，而有更复杂的因素。除对疾病、死和异常的恐怖之外，还与完美欲、优越欲、罪恶感和良心的谴责等有关。

突然悟道 恍然大悟。在森田疗法的治疗过程中，患者的某些症状，有时会因某种突然的原因，一下子从困扰中解脱出来。

为值得烦恼的事而烦恼 这是弗郎克尔的一句话。意思是，不值得去烦恼的事，烦恼也没有用，值得烦恼的，不妨为之烦恼。

人若有生活的目标，就能承受一般的困苦 意思是告诫人们“活着要有目的”，这是大原常引用的一句尼采的话。

人是在不安中生存 这是萨尔托尔的一句话。意思是，“人本来就是不安的”，与不安常在是同义词。

睡眠的多少，要顺其自然 如果身体需要睡眠，即使在火车上也能入睡，在极端的情况下，甚至能边走边睡。与此相反，如果身体不需要睡眠，无论在床上躺多久也还是无法入睡。要紧的是情绪要放松。对于睡眠的多少，要顺其自然。只要睡上5~6个小时，精力就会得到恢复，足以坚持第二天的工作。

烦恼即解脱 即使内心烦恼也不要企图逃避，毋宁任其烦恼。这样，烦恼的心情就会消失，解决问题的办法自然也就有了。

日新又月新 尽管看上去，每天的生活内容千篇一律，但今天和昨天总是不一样，今天就是新的一天。今天比昨天，明天比今天应该过得更充实。

日日是好日 这是云门禅师的一句话。意思是，如果工作、学习一天之后，感到过得很充实，那就是好日子；如果没能过得充实，那就是坏日子。至于这一天的情绪如何并不重要。